NTS N° -MINSA/DGIESP-2026

NORMA TÉCNICA DE SALUD QUE ESTABLECE EL ESQUEMA NACIONAL DE INMUNIZACIONES

I. FINALIDAD

Contribuir a disminuir la morbimortalidad causada por enfermedades inmunoprevenibles, protegiendo la vida y la salud de la población por curso de vida a través de las inmunizaciones.

II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General:

Establecer el esquema nacional de inmunizaciones para la población por curso de vida.

2.2 Objetivo Específico:

Definir los criterios técnicos para la planificación, programación, implementación, monitoreo, supervisión y evaluación de las intervenciones de inmunizaciones por curso de vida.

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN

La presente Norma Técnica de Salud es de aplicación y cumplimiento obligatorio en todos los establecimientos de salud públicos (del Ministerio de Salud, Seguro Social de Salud – EsSalud, Sanidad de las Fuerzas Armadas, Sanidad de la Policía Nacional del Perú, Instituto Nacional Penitenciario - INPE y Gobiernos Regionales) y privados del Sector Salud que realicen actividades de inmunizaciones.

IV. BASE LEGAL

- Ley N° 26842, Ley General de Salud.
- Ley N° 27337, Ley que aprueba el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes.
- Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley N° 28010, Ley General de Vacunas.
- Ley N° 28736, Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial.
- Ley N° 29459, Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios.
- Ley N° 29733, Ley de protección de datos personales.
- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Ley N° 31883, Ley que promueve la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) en la niñez y adolescencia.
- Ley N° 32501, Ley que promueve la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) de los pacientes con virus de inmunodeficiencia humana (VIH), tuberculosis (TBC) e inmunosupresión.
- Decreto Legislativo N° 1156, Decreto Legislativo que dicta medidas destinadas a garantizar el servicio público de salud en los casos en que exista un riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las poblaciones.

- Decreto Legislativo N° 1161, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud.
- Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos sólidos.
- Decreto Legislativo N° 1490, Decreto Legislativo que fortalece los alcances de la Telesalud.
- Decreto Legislativo N° 1702, Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 1612, Decreto Legislativo que fortalece el Sistema Nacional de Focalización mediante la creación del Organismo Técnico Especializado denominado Organismo de Focalización e Información Social (OFIS) y dicta otras medidas complementarias, a fin de incorporar el padrón nominal de la población menor de seis años como instrumento del OFIS y determinar el alcance del rol de los gobiernos locales y del OFIS para el seguimiento nominal a la primera infancia, desde la gestación y con miras a un seguimiento longitudinal.
- Decreto Supremo N° 008-2007-MIMDES, que aprueba el Reglamento de la Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial.
- Decreto Supremo N° 005-2012-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Decreto Supremo N° 007-2014-SA, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1156, que dicta medidas destinadas a garantizar el servicio público de salud en los casos en que exista un riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las poblaciones.
- Decreto Supremo N° 020-2014-SA, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud.
- Decreto Supremo N° 008-2017-SA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud.
- Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
- Decreto Supremo N° 005-2021-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30421, Ley Marco de Telesalud, y del Decreto Legislativo N° 1490, Decreto Legislativo que fortalece los alcances de la Telesalud.
- Decreto Supremo N° 016-2024-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales.
- Decreto Supremo N° 005-2025-MIDIS, que aprueba la Norma Técnica del Producto "Niños y Niñas entre 6 hasta 36 meses que requieren de cuidado extra familiar por ausencia de un adulto competente para su atención en el ámbito del hogar reciben servicios de cuidado y atención integral" del Programa Presupuestal orientado a Resultados de Desarrollo Infantil Temprano (PPoR DIT).
- Resolución Suprema N° 023-2019-EF, que aprueba el Programa Presupuestal orientado a Resultados de Desarrollo Infantil Temprano.
- Resolución Ministerial N° 720-2006/MINSA, que aprueba el Documento Técnico "Modelo de Abordaje de Promoción de la Salud en el Perú".
- Resolución Ministerial N° 579-2008/MINSA, que establece servicios y actividades públicos esenciales en los Establecimientos de Salud en el ámbito nacional.
- Resolución Ministerial N° 800-2012/MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N° 049-MINSA/DGE-V.01 "Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de Sarampión, Rubéola y Otras Enfermedades Febriles Eruptivas".
- Resolución Ministerial N° 063-2014/MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N° 054-MINSA/DGE-V.01, "Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación o Inmunización (ESAVI)".

- Resolución Ministerial N° 931-2014/MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N° 059-MINSA/DGE-V.01 "Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de Poliomielitis/Parálisis Flácida Aguda".
- Resolución Ministerial N° 132-2015/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en Laboratorios, Droguerías, Almacenes Especializados y Almacenes Aduaneros.
- Resolución Ministerial N° 833-2015/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: Manual de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios.
- Resolución Ministerial N° 539-2016/MINSA, que aprueba la NTS N° 123-MINSA/DIGEMID-V.01, Norma Técnica de Salud que regula las actividades de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios.
- Resolución Ministerial N° 024-2017/MINSA, que aprueba la NTS N° 131-MINSA/2017/DGIESP, Norma Técnica de Salud para la Vigilancia, Prevención y Control de la Rabia Humana en el Perú.
- Resolución Ministerial N° 366-2017/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: "Lineamientos de Política de Promoción de la Salud en el Perú".
- Resolución Ministerial N° 572-2017/MINSA, que conforma el Comité de Expertos ad honorem de la Dirección de Intervenciones por Curso de Vida y Cuidado Integral de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública respecto a temas de salud neonatal.
- Resolución Ministerial N° 116-2018/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N° 249-MINSA/2018/DIGEMID "Gestión del Sistema Integrado de Suministro Público de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios – SISMED".
- Resolución Ministerial N° 190-2018/MINSA, que conforma el Comité Consultivo de Inmunizaciones.
- Resolución Ministerial N° 1295-2018/MINSA, que aprueba la NTS N° 144-MINSA/2018/DIGESA, Norma Técnica de Salud: "Gestión Integral y Manejo de Residuos Sólidos en Establecimientos de Salud, Servicios Médicos de Apoyo y Centros de Investigación".
- Resolución Ministerial N° 1330-2018/MINSA, que aprueba la NTS N° 146-MINSA/2018/DGIESP: "Norma Técnica de Salud para la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Hepatitis Viral B en el Perú".
- Resolución Ministerial N° 323-2019/MINSA, que conforma el Comité de Expertos de la Dirección de Inmunizaciones de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública.
- Resolución Ministerial N° 1138-2019/MINSA, que aprueba la NTS N° 159-MINSA/2019/DGIESP: Norma Técnica de Salud para la Prevención de la Transmisión Materno Infantil del VIH, Sífilis y Hepatitis B.
- Resolución Ministerial N° 030-2020/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: "Modelo de Cuidado Integral de Salud por Curso de Vida para la Persona, Familia y Comunidad (MCI)".
- Resolución Ministerial N° 882-2020/MINSA, que aprueba la NTS N° 167-MINSA/2020/DGIESP, Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes infectados por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).
- Resolución Ministerial N° 499-2023/MINSA, que conforma el Comité de Expertos denominado "Comité Nacional de Certificación de la Erradicación de la Poliomielitis" de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública.

- Resolución Ministerial N° 632-2023/MINSA, que aprueba la NTS N° 206-MINSA/CDC-2023 "Norma Técnica de Salud para la Vigilancia Epidemiológica, Prevención y Control de Tos Ferina.
- Resolución Ministerial N° 633-2023/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: "Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud".
- Resolución Ministerial N° 749-2023/MINSA, que conforma el Comité Nacional para la Contención de Poliovirus.
- Resolución Ministerial N° 789-2023/MINSA, que aprueba la NTS N° 207-MINSA/DGIESP-2023, Norma Técnica de Salud para el Cuidado Integral de Salud de las Personas Adultas Mayores.
- Resolución Ministerial N° 1154-2023/MINSA, que conforma el Comité de Expertos denominado "Comité Nacional de Monitoreo y Recertificación de la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita" de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública.
- Resolución Ministerial N° 545-2024/MINSA, que aprueba la NTS N° 214-MINSA/DGIESP-2024, Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud Neonatal.
- Resolución Ministerial N° 894-2024/MINSA, que modifica el rubro Autorización de Uso del Anexo de la R.M. N° 792-2024/MINSA y aprueba la NTS N° 221-MINSA/DGIESP-2024, Norma Técnica de Salud para la Prevención y Control de la Tuberculosis.
- Resolución Ministerial N° 310-2025/MINSA, que aprueba la NTS N° 229-MINSA/DGIESP-2025, Norma Técnica de Salud para el Cuidado Integral de Salud de la Persona Adulta.
- Resolución Ministerial N° 553-2025/MINSA, que dispone que el Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas - SIHCE del MINSA, sea implementado y usado de manera obligatoria en los establecimientos de salud del primer nivel de atención del Ministerio de Salud y de los gobiernos regionales.
- Resolución Ministerial N° 682-2025/MINSA, que aprueba la NTS N° 238-MINSA/DGIESP-2025, Norma Técnica de Salud para el control de crecimiento y desarrollo del niño.
- Resolución Ministerial N° 074-2026/MINSA, que aprueba la NTS N° 242-MINSA/DGIESP-2026: "Norma Técnica de Salud para el Manejo de la Cadena de Frío en Inmunizaciones".

V. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. DEFINICIONES OPERATIVAS:

- **Actividades complementarias de vacunación:** Se caracterizan por estar orientadas a una o más población objetivo; se implementan en un período de tiempo definido, se programan con la finalidad de complementar las acciones regulares de vacunación ante un evento de riesgo epidemiológico por enfermedades inmunoprevenibles por vacuna en eliminación o control.
- **Actividades regulares de vacunación:** Son actividades diarias de vacunación, de carácter preventivo en población susceptible, niños y niñas, adolescentes, adultos, adultos mayores. Estas actividades se desarrollan en todos los establecimientos de salud a nivel intra y extramural, con la finalidad de captar y/o completar el esquema de vacunación en forma oportuna, a cargo del profesional de enfermería y en casos excepcionales del técnico de enfermería capacitado.
- **Adyuvantes:** Son substancias agregadas a las vacunas con el objetivo de aumentar la respuesta inmune en grado y duración, logrando de esta manera reducir la cantidad de antígeno por dosis o el número de dosis necesarias para alcanzar protección.

- **Anafilaxia:** Reacción alérgica grave, sistémica de instauración rápida (minutos u horas) que puede ser mortal. Provoca síntomas cutáneos (urticaria, hinchazón), respiratorios (dificultad para respirar), digestivos (vómitos) y cardiovasculares (bajada de tensión). El tratamiento inmediato de primera línea es la adrenalina (epinefrina) intramuscular.
- **Anticuerpo:** Son moléculas de la inmunidad humoral específica cuya principal función es la defensa contra microorganismos y toxinas producidas por los distintos agentes microbianos. Estas moléculas que son proteínas (inmunoglobulinas), tienen la capacidad de unirse con el antígeno que ha producido su formación.
- **Anticuerpo Monoclonal:** Es una proteína de defensa producida en el laboratorio que se une específicamente a un único antígeno (una sustancia extraña o anómala en el cuerpo), puede neutralizar virus específicos.
- **Antígeno:** Sustancia o grupo de sustancias que son capaces de estimular la producción de una respuesta inmune, específicamente de anticuerpos.
- **Barrido:** Es una actividad complementaria de vacunación masiva, que se realiza con el objetivo de desarrollar una barrera sanitaria en un determinado ámbito geográfico en riesgo epidemiológico, por la presencia de un caso confirmado de una enfermedad sujeta a erradicación o eliminación o frente a la acumulación de susceptibles.
- **Bloqueo vacunal documentado:** Actividad que se realiza ante la notificación de un caso sospechoso/probable de una enfermedad prevenible por vacuna, sujeto a eliminación o control. Se ejecuta en un ámbito de acción de 5 manzanas a la redonda en torno a la ubicación de la vivienda del caso notificado (121 manzanas), teniendo en cuenta la cadena de transmisión. Su ejecución se realiza dentro de las 72 horas de notificado el caso y consiste en identificar a toda población objetivo de acuerdo a escenario epidemiológico, en el área de intervención, evaluando su estado de vacunación. De identificarse un niño con esquema de vacunación incompleto se procederá a vacunar al menor; esta actividad se realiza en coordinación con el área de epidemiología.
- **Brigada de vacunación:** Equipo conformado por un vacunador (profesional de enfermería o técnico de enfermería capacitado) y un anotador (técnico de enfermería u otro profesional capacitado y/o bachiller, estudiantes de enfermería).
- **Brote:** Es el incremento o aparición inusual de casos de una enfermedad en un área geográfica delimitada, durante un período de tiempo y afectando a personas y estos casos tiene un nexo epidemiológico.
- **Cadena de frío en inmunizaciones:** Es la secuencia que comprende las fases o eventos de transporte del producto termo-sensible como las vacunas, desde su fabricación hasta su recepción por el usuario final (vacunación), manteniendo la temperatura dentro de las especificaciones aprobadas.
- **Consentimiento informado:** Conformidad expresa del padre, madre, personal de apoyo o de confianza, para que su familiar o el mismo, reciba la vacuna y/o inmunización en forma libre, voluntaria y consciente, después de haber sido informado sobre la vacuna o inmunización incluyendo los riesgos reales/ potenciales, efectos colaterales, efectos adversos, así como los beneficios. Debiendo ser registrado y firmado en un documento por el padre, madre, personal de apoyo o de confianza y el profesional responsable de la atención.
- **Contraindicación:** Es una situación o prescripción específica por la cual no debe administrarse una vacuna.
- **Control:** Disminución de la transmisión de una enfermedad infecciosa con descenso de su incidencia.

- **Dosis de refuerzo (booster):** Es la dosis de vacuna que se administra después de haber recibido el esquema básico o serie primaria de vacunación, con la finalidad de incrementar y prolongar el efecto inmune de la misma.
- **Dosis de rescate:** Referida a la vacunación de niños, niñas, adolescentes, adultos o adultos mayores con vacunación incompleta bajo un esquema de vacunación acelerada.
- **Dosis no utilizadas:** Dosis que se dejan de utilizar en las vacunas que tienen presentación de multidosis y deben ser descartadas. Se prioriza la protección de la persona, evitando en todo momento las oportunidades perdidas.
- **Eliminación:** Cese sostenido de la transmisión de una enfermedad infecciosa dentro de una región, aunque el agente patógeno pueda continuar circulando en otras regiones del mundo.
- **Enfermedades prevenibles por vacunación:** Son aquellas enfermedades que se pueden prevenir mediante el uso de las inmunizaciones (vacunas/anticuerpos), entre ellas: la Difteria, Tos ferina, Tétanos, Hepatitis B, Hepatitis A, Influenza, Poliomielitis, Sarampión, Rubeola, Parotiditis, Varicela, Tuberculosis, Meningitis, Fiebre Amarilla, Neumonías, diarreas por Rotavirus, cáncer de cuello uterino por VPH, virus respiratorio sincitial, entre otras.
- **Erradicación:** Cese total de la transmisión de una enfermedad infecciosa en todo el mundo, con lo cual se elimina la necesidad de medidas de control futuras.
- **Errores programáticos:** Fallas en la operación del programa de vacunación que no están relacionadas con la vacuna en sí, sino con problemas en su cadena de custodia o administración (transporte, almacenamiento, preparación, aplicación) que afectan la efectividad o seguridad, siendo estos errores prevenibles, a diferencia de los Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) que son más inherentes al proceso inmunológico del individuo.
- **Esquema de Inmunización:** Es la representación cronológica y secuencial para la administración de las inmunizaciones (vacunas/anticuerpos) aprobadas oficialmente para el país, como parte de la política nacional de vacunación e inmunización.
- **ESAVI Leve:** Reacción que se presenta con signos y síntomas fácilmente tolerados. No requieren tratamiento ni hospitalización.
- **ESAVI Moderado:** Reacción que requiere de tratamiento farmacológico o un aumento de la frecuencia de la observación del paciente.
- **ESAVI Severo:** Es todo ESAVI que incluye uno o más de los siguientes criterios: hospitalización, riesgo de muerte, discapacidad y/o fallecimiento, que desencadena el proceso de la investigación que concluye con su clasificación final y la implementación de medidas correctivas.
- **Estabilizantes:** Son usados para mantener las propiedades fisicoquímicas de la vacuna durante el almacenamiento. Para garantizar la calidad del producto biológico, se agregan algunos compuestos para minimizar problemas con los cambios en la acidez, alcalinidad, estabilidad y temperatura. Los estabilizantes son esenciales sobre todo en condiciones en las que es difícil mantener estable la cadena de frío en inmunizaciones.
- **Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación o Inmunización (ESAVI):** Cualquier situación de salud (signo, hallazgo anormal de laboratorio, síntoma o enfermedad) desfavorable y no intencionada que ocurra luego de la vacunación o inmunización y que no necesariamente tiene una relación causal con el proceso de vacunación o con la vacuna.
- **Factor de pérdida:** Corresponde al valor por el cual se multiplica la población objetivo y permite obtener la cantidad óptima de vacuna requerida para cubrir dicha población y los posibles desperdicios.

- **Fecha de vencimiento de la vacuna:** Fecha colocada en el envase inmediato de una vacuna que indica el periodo máximo de uso de la vacuna. Esta fecha se basa en la estabilidad del producto farmacéutico. Si la fecha de vencimiento señala mes y año se entiende que es el último día del mes o según especificación de ficha técnica.
- **Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS):** Es un mecanismo de colaboración solidaria mediante el cual se compran vacunas, jeringas y suministros afines.
- **Gestantes atendidas:** Es la gestante que acude a su 1era atención pre natal, en el embarazo actual en cualquier institución prestadora de servicios de salud pública o privada.
- **Gratuidad de la vacunación:** Las vacunas y jeringas que se usan en la actividad regular y complementaria de inmunizaciones, son adquiridas por el gobierno peruano con fondos del Tesoro Público y se otorgan de manera gratuita a toda la población beneficiaria del presente Esquema Nacional de Inmunizaciones, por el profesional de enfermería.
- **Inmunidad:** Es la capacidad que tienen los organismos para resistir y defenderse de la agresión de agentes extraños.
- **Inmunización:** Proceso por el que una persona se hace inmune o resistente a una enfermedad infecciosa, mediante la administración de una vacuna (inmunidad activa) y/o anticuerpos (inmunidad pasiva).
- **Inmunodeficiencia:** Es una disminución o falta de respuesta inmunitaria. Pueden ser por causas primarias (celular y humoral) o secundarias o adquiridas (VIH, oncohematológicas, corticoterapia, quimioterapia, radioterapia y trasplantados).
- **Inmunosuprimido:** Persona cuyo sistema inmunitario presenta una disminución parcial o total de su capacidad para generar una respuesta inmunológica adecuada frente a agentes infecciosos o enfermedades. Esta condición puede ser consecuencia de enfermedades de base, trastornos congénitos, infecciones, neoplasias o del uso de tratamientos inmunosupresores como corticoides, quimioterapia, radioterapia o medicamentos administrados posterior a un trasplante.
- **Microplanificación:** Es una herramienta esencial en salud pública, especialmente para vacunación, que ordena y sistematiza la gestión local, identificando áreas y poblaciones específicas para optimizar la programación, organización, ejecución y evaluación, asegurando que los servicios lleguen a todos y logrando altas coberturas, mediante un enfoque participativo y "de abajo hacia arriba".
- **Monitoreo Rápido de Vacunados (MRV):** Es una herramienta de gestión que ayuda en el proceso de supervisión de las actividades de vacunación pues permite determinar si todos los niños y niñas de un área determinada del establecimiento de salud han sido vacunados y las razones o motivos por los que no se vacunaron.
- **Niños y niñas con vacuna completa:** Es la niña o el niño que de acuerdo a su edad ha recibido las vacunas de manera adecuada y oportuna según lo establecido en el Esquema Nacional de Inmunizaciones vigente. Actividad desarrollada por el profesional de enfermería de manera periódica y sistemática.
- **Oportunidad Pérdida de Vacunación:** Toda situación en la que un niño elegible visita un establecimiento de salud y no se le aplican las vacunas necesarias, a pesar de la ausencia de contraindicaciones.
- **Paciente con Trasplante de Órganos Sólidos (TOS):** Persona que ha recibido el reemplazo quirúrgico de un órgano sólido enfermo o insuficiente -como riñón, hígado, corazón, pulmón, páncreas o intestino- mediante la implantación de un

órgano proveniente de un donante, con la finalidad de restablecer la función orgánica y mejorar la supervivencia y calidad de vida del paciente.

- **Pacientes con Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos (TPH):** Persona que ha recibido la infusión de células madre hematopoyéticas, provenientes de sí mismo o de un donante compatible, con el propósito de restablecer la función normal de la médula ósea afectada por enfermedades hematológicas, inmunológicas o neoplásicas.
- **Periodo estacional del Virus Respiratorio Sincitial (VRS):** Tiempo en el cual se concentra la mayor circulación y cantidad de casos por VRS (ambulatorios y hospitalizaciones), en el Perú comprendido entre los meses de abril y septiembre, según vigilancia epidemiológica nacional.
- **Población objetivo a proteger contra el Virus Respiratorio Sincitial (VRS):** Recién nacido y lactantes menores de 6 meses, nacidos y expuestos en el periodo estacional de mayor circulación del VRS informado por en el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del país (CDC).
- **Población considerada en la intervención estratégica contra el virus Respiratorio Sincitial (VRS):** La intervención estratégica incluye 02 grupos poblacionales:
  - ✓ Gestantes de 32 a 36 semanas de embarazo en el periodo estacional.
  - ✓ Recién nacidos y lactantes menores de 6 meses, nacidos en el periodo estacional.
- **Población Vulnerable:** Grupo de personas que se encuentran priorizadas para la atención de la vacunación. Dentro de estos grupos están considerados las gestantes, población indígena, personas con discapacidad, personas privadas de su libertad y personal de primera línea (bomberos, serenazgo, policías, limpieza, seguridad, Fuerzas Armadas).
- **Promoción de la Salud:** Proceso de empoderar a las personas para que aumenten el control sobre su salud; busca modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas en las que viven las personas, con el fin de mitigar su impacto en la salud pública e individual, mediante el abordaje de los Determinantes Sociales de la Salud.
- **Puntos de Vacunación:** Es un espacio amplio y ventilado que cumple con criterios de bioseguridad para el personal de salud y las personas que acuden a vacunarse. Está adecuadamente equipado para garantizar el proceso de la vacunación segura. Estos puntos de vacunación son de carácter temporal y pueden estar instalados en parques, estadios, estacionamientos, colegios, universidades u otros, siempre que cumplan con los criterios antes descritos.
- **Síncope:** Es una pérdida brusca y temporal de la conciencia y del tono postural, de duración breve y con recuperación rápida y espontánea usualmente sin secuelas. Se produce por una disminución transitoria del flujo sanguíneo al cerebro. Es un problema frecuente en la población general.
- **Toxoides:** Toxinas de origen bacteriano modificadas, que han perdido su capacidad de producir enfermedad, pero conservan su poder antigénico, es decir, generan una respuesta inmune protectora en el organismo.
- **Vacuna:** Es toda preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando una respuesta inmune específica contra la enfermedad infecciosa respectiva. Habitualmente, es la suspensión de microorganismos virales, bacterianos vivos, inactivados o sus fracciones, subunidades o partículas proteicas de los mismos, toxoides y otros.
- **Vacuna combinada:** Pueden contener antígenos distintos del mismo microorganismo (denominándose poli o multivalentes) o bien estar compuestas de distintos microorganismos, ya sean virus, bacterias o virus y bacterias

(pentavalente o hexavalentes). Ninguna vacuna combinada mezcla componentes atenuados con inactivados.

- **Vacuna conjugada:** Vacuna de antígenos T-independientes que se conjugan de forma covalente a proteínas transportadoras o *carrier* para convertirlos en antígenos T-dependientes con el objeto de que sean inmunógenos y generen memoria inmunológica.
- **Vacunación:** Acción que consiste en administrar una vacuna/anticuerpo a una persona, de acuerdo a un esquema establecido, para que adquiera protección contra una enfermedad.
- **Vacunación segura:** La vacunación segura es un componente prioritario y esencial de los programas de inmunización y comprende el cumplimiento de un conjunto de procedimientos normalizados, estandarizados o protocolizados que se observan desde la formulación de una vacuna, su producción, transporte, almacenamiento y conservación, distribución, manipulación, reconstitución, administración (inyección segura), eliminación (bioseguridad), comunicación oportuna, clara y basada en evidencia y la vigilancia epidemiológica e investigación de los ESAVI.
- **Vacunas inactivadas:** Vacunas compuestas por gérmenes muertos que han perdido su capacidad patogénica, pero conservan la capacidad inmunogénica. Se obtienen tratando los antígenos vivos mediante procedimientos físicos (calor) o químicos (formaldehído) que destruyen su infectividad sin afectar la inmunogenicidad.
- **Vacunas vivas atenuadas:** Vacunas compuestas por microorganismos infecciosos vivos (bacterias o virus) que muestran bajos niveles de virulencia. Conservan la capacidad inmunogénica y estimulan la inmunidad protectora, pero han perdido el poder patógeno y muy rara vez son capaces de causar formas graves de enfermedad, por ejemplo, la vacuna contra la fiebre amarilla y la vacuna anti poliomielítica oral. Se obtienen seleccionando mutantes avirulentas o de virulencia atenuada a través de pases sucesivos en diferentes huéspedes animales y/o medios de cultivos celulares.
- **Vacunatorio:** Espacio físico dentro o fuera de los establecimientos de salud públicos o privados, donde se realizan las actividades de orientación, consejería y administración de vacunas por un profesional de enfermería y en casos excepcionales por un personal técnico de enfermería, debidamente capacitado para la atención de las personas tanto niñas y niños, adolescentes, gestantes, adultos y adultos mayores.

5.2. ACRÓNIMOS/SIGLAS/SÍMBOLOS

En la presente Norma Técnica de Salud se usan los siguientes acrónimos:

- **ACS:** Agente Comunitario de Salud.
- **AISPED:** Equipos de Atención Integral de Salud a Poblaciones Excluidas y Dispersas.
- **AMA:** Antiamarílica.
- **AcM:** Anticuerpo monoclonal
- **APO:** Anti poliomielítica oral.
- **BCG:** Bacilo de Calmette-Guerin.
- **CDC:** Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades.
- **cc:** Centímetros cúbicos.
- **cm:** Centímetros.
- **CENARES:** Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud.

- **DEMID:** Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas.
- **DICC50:** Dosis que Infecta a 50% del Cultivo Celular.
- **DIGEMID:** Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas.
- **DIGESA:** Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria.
- **DGIESP:** Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública.
- **DIRESA:** Dirección Regional de Salud.
- **DIRIS:** Dirección de Redes Integradas de Salud.
- **DIT:** Desarrollo Infantil Temprano
- **DMUNI:** Dirección de Inmunizaciones.
- **DPT:** Difteria-Pertussis-Tétanos.
- **DT o dT:** Difteria-Tétanos.
- **Tdap:** Tétanos, Difteria, Pertussis acelular.
- **EE.SS.:** Establecimientos de Salud.
- **ESAVI:** Evento Supuestamente Atribuido a la Vacunación y/o Inmunización.
- **ESRI**: Estrategia Sanitaria Regional de Inmunizaciones.
- **ESSALUD:** Seguro Social de Salud.
- **EPV:** Enfermedades Prevenibles por Vacunación.
- **FF.AA.**: Fuerzas Armadas.
- **GERESA:** Gerencia Regional de Salud.
- **HBsAg:** Antígeno de superficie de la Hepatitis B.
- **Hib:** *Haemophillus influenzae* tipo b.
- **HSH:** Hombre que tiene sexo con hombre.
- **HvA:** Virus de la Hepatitis A.
- **HvB:** Virus de la Hepatitis B.
- **ICI:** Informe Consumo integrado.
- **ID:** Intradérmica.
- **IGA**: Inventario y análisis de brecha.
- **IM:** Intramuscular.
- **INS:** Instituto Nacional de Salud.
- **INEI:** Instituto Nacional de Estadística e Informática.
- **IPV:** Vacuna Antipolio Inactivada.
- **IRA:** Infecciones Respiratorias Agudas.
- **Lf:** Límite de floculación.
- **ml:** Mililitro.
- **mg:** Miligramo.
- **mcg o µg:** Microgramo.
- **MINSA:** Ministerio de Salud.
- **MINEDU**: Ministerio de Educación.
- **MIDIS**: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
- **MIMP:** Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
- **MRV:** Monitoreo Rápido de Vacunados.
- **NTS:** Norma Técnica de Salud.
- **OFIS:** Organismo de Focalizacion e Informacion Social.
- **OGTI:** Oficina General de Tecnologías de la Información.
- **OMS:** Organización Mundial de la Salud.
- **OPS:** Organización Panamericana de la Salud.
- **ORAS-CONHU:** Organismo Andino de Salud - Convenio Hipolito Unanue.
- **PNP:** Policía Nacional del Perú.
- **POI:** Plan Operativo Institucional.
- **PPOR:** Programa Presupuestal Orientado a Resultados.
- **PpR:** Presupuesto por resultados.
- **RAM:** Reacción Alérgica al Medicamento.
- **RENIEC:** Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
- **SC:** Subcutánea.

- **SIGA:** Sistema Integrado de Gestión Administrativa.
- **SIHCE DEL MINSA:** Sistema de información de historias clínicas electrónicas del Ministerio de Salud.
- **SISMED:** Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e Insumos Médico Quirúrgico.
- **SPR:** Sarampión-Paperas-Rubéola.
- **SR:** Sarampión-Rubéola.
- **TB:** Tuberculosis.
- **UE:** Unidades Ejecutoras.
- **UI:** Unidades Internacionales.
- **UFC:** Unidad Formadora de Colonia.
- **UFP:** Unidad Formadora de Placa.
- **UNICEF:** Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
- **UO:** Unidad de Opacidad.
- **VIH:** Virus de Inmunodeficiencia Humana.
- **VPH:** Virus del Papiloma Humano.
- **VRS:** Virus Respiratorio Sincitial.

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

El Estado Peruano, mediante el MINSA, garantiza la compra y distribución de 23 vacunas del esquema regular, 01 anticuerpo monoclonal y 04 vacunas según situaciones epidemiológicas. Este esquema busca proteger a la población contra 36 enfermedades inmunoprevenibles, asegurando el abastecimiento desde el nivel nacional, al nivel regional, para cada curso de la vida.

Las acciones de vacunación e inmunización son consideradas una intervención de salud pública para reducir la morbilidad y mortalidad por enfermedades inmunoprevenibles, las cuales están sustentadas en el Objetivo Estratégico Sectorial N° 1 "Mejorar el estado de salud de las personas que habitan en el territorio peruano", del Plan Estratégico Sectorial Multisectorial (PESEM) 2024-2030 del Sector Salud, aprobado por Resolución Ministerial N° 1174-2023/MINSA, en beneficio de la salud pública de la población más vulnerable y de menos recursos económicos, las mismas que se encuentran alineadas a uno de los objetivos prioritarios de la Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030 "Perú, País Saludable", aprobada por Decreto Supremo N° 026-2020-SA.

6.1. VACUNAS DEL ESQUEMA NACIONAL:

El Esquema Nacional de Inmunizaciones incluye las siguientes vacunas y un (01) anticuerpo monoclonal según denominación y tipo:

N°	VACUNA	
	DENOMINACIÓN	TIPO
1	Vacuna BCG: Bacilo de Calmette – Guérin	Virus vivo atenuado
2	Vacuna contra Hepatitis B (HvB)	Inactivado (recombinante)
3	Vacuna Combinada Hexavalente (DPT-HvB-Hib-IPV)	Vacuna combinada: inactivadas de Bordetella pertussis, toxoide diftérico y tetánico, antígeno de superficie del virus de la Hepatitis B, Poliomielitis (inactivada) y el polisacárido conjugado de Haemophilus Influenzae tipo b

4	Vacuna Combinada Pentavalente (DPT-HvB-Hib)	Vacuna combinada: inactivadas de Bordetella pertussis, toxoide diftérico y tetánico, antígeno de superficie del virus de la Hepatitis B, y el polisacárido conjugado de Haemophilus Influenzae tipo b
5	Vacuna contra difteria y tétanos (DT pediátrico)	Mezcla de toxoide diftérica purificada y anatoxina tetánica (DT)
6	Vacuna contra Haemophilus Influenzae tipo B (Hib)	Inactivado (polisacárido conjugado)
7	Vacuna antipolio Inactivada (IPV o Salk)	Virus inactivado
8	Vacuna antipolio oral de poliovirus (APO O SABIN)	Virus vivo atenuado
9	Vacuna contra Rotavirus	Virus vivo atenuado
10	Vacuna Antineumocócica	Inactivada (polisacárido conjugado)
11	Vacuna contra Sarampión, Paperas y Rubeola (SPR)	Virus vivo atenuado
12	Vacuna contra Sarampión-Rubéola (SR)	Virus vivo atenuado
13	Vacuna contra Varicela	Virus vivo atenuado
14	Vacuna contra Fiebre amarilla (AMA)	Virus vivo atenuado
15	Vacuna contra difteria, pertussis y tétanos (DPT)	Toxoide (DT) e inactivo (P)
16	Vacuna contra difteria y tétanos (dT adulto)	Toxoide (dT)
17	Vacuna contra difteria, tétanos y pertussis acelular (Tdap)	Toxoide baterianos (dT) acelular pertussis(pa) asorvidos
18	Vacuna contra Hepatitis A (HVA)	Virus inactivado (adsorbido)
19	Vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH)	Inactivado (recombinante)
20	Vacuna contra Influenza	Inactivado
21	Vacuna frente al Virus Respiratorio Sincitial (Recombinante) (VRS)	Vacunas de subunidades proteicas, basadas en proteínas recombinantes
22	Vacuna Combinada acelular Hexavalente (DTaP-HvB-Hib-IPV)	Vacuna contra la difteria, el tétanos, la tos ferina (acelular, compuesta), la hepatitis B (ADN recombinante), la poliomielitis (inactivada), y Haemophilus influenzae de tipo b (conjugada), adsorbida.
23	Vacuna Meningococo (niñas y niños viviendo con VIH)	Vacuna conjugada
24	Anticuerpo Monoclonal contra el Virus Respiratorio Sincitial	Anticuerpo monoclonal humano de larga duración: nirsevimab

Otras vacunas de acuerdo con situación epidemiológica, cuya la implementación será de acuerdo a sus documentos normativos.

N°	VACUNA	
	DENOMINACIÓN	TIPO
01	Vacuna contra la COVID 19	ARN mensajero
02	Vacuna contra la Viruela del Mono (MPOX)	Virus vivo atenuado no replicable
03	Vacuna contra el Dengue	Virus vivo atenuado recombinante
04	Vacuna Antirrábica Humana	Inactivado

* Nota: Las precisiones técnicas están descritas en sus respectivas normas técnicas vigentes.

6.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS VACUNAS DEL ESQUEMA NACIONAL DE INMUNIZACIONES

El Esquema Nacional de Inmunizaciones incluye las siguientes vacunas:

6.1.1.1. VACUNA BCG: BACILO DE CALMETTE – GUÉRIN

TIPO DE VACUNA	Vivo atenuado
DESCRIPCIÓN	La Vacuna BCG es una vacuna viva liofilizada derivada de la cepa atenuada de Mycobacterium bovis (Bacilo Calmette y Guérin, cepa Moscow 361-I) usada en la prevención de la tuberculosis.
COMPOSICIÓN	Cada dosis de 0.1 ml reconstituida, contiene: 1 X 10^5 del bacilo de Calmette-Guérin y 33 X 10^5 U.F.C. Cada dosis de 0.1 ml reconstituida, contiene: 2 x 10^5 y 8 x 10^5 UFC
PRESENTACIÓN	Frasco con polvo liofilizado de 10 o 20 dosis y diluyente de 1 ml (10 dosis de 0.1 ml o 20 dosis de 0.05 ml), requiere reconstitución con cloruro de sodio al 0.9% p/v
INDICACIÓN	Prevención de las formas clínicas graves de la tuberculosis infantil, meningitis tuberculosa y diseminada.
ESQUEMA DE VACUNACIÓN	Recién nacidos con peso igual o mayor de 1500gr. Ver: Dosis de rescate en Anexo 2 y casos especiales en ítem 6.3.
DOSIS (CANTIDAD)	La dosis de vacunación es 0.05 ml de la vacuna reconstituida para niños menores de un año, incluyendo a recién nacidos y 0.1 ml de la vacuna reconstituida para niños mayores de un año de edad y adultos.
CONSERVACIÓN DE LA VACUNA	+ 2°C a +8°C
	Una vez reconstituida, el tiempo de uso es 6 horas.
VÍA Y SITIO DE ADMINISTRACIÓN	Intradérmica.
	Región del músculo deltoides, del brazo derecho a 2 cm del acromion o vértice del hombro.
JERINGAS A UTILIZAR	Para administrar: jeringa descartable de 1ml con aguja auto retráctil 27G x ½".
	Para reconstituir: Jeringa descartable de 5 ml con aguja 21G x 1 ½"

POSIBLES EFECTOS POST-VACUNALES	Días después de la vacunación puede desarrollarse una pápula en el sitio de la inyección, que disminuye gradualmente y es reemplazado por una reacción local que puede ulcerarse semanas más tarde. Esta reacción local no requiere tratamiento.
CONTRAINDICACIÓN	• Recién nacidos con un peso inferior a 1,500 gr.
	• Enfermedades infecciosas (especialmente sarampión y varicela), debiendo esperar 1 mes de transcurridas estas infecciones para su aplicación.
	• Reacciones dermatológicas que impidan la administración de la vacuna en el área de aplicación.
	• En casos de hipogammaglobulinemia, inmunodeficiencia congénita, sarcoidosis, leucemia, neoplasia generalizada, infecciones de VIH o cualquier otro trastorno en que la respuesta inmune natural se altera, como también aquellos en terapia inmunosupresora, corticoides, radioterapia.
USO SIMULTÁNEO CON OTRAS VACUNAS	Se puede aplicar simultáneamente con cualquier otra vacuna ya sean estas vivos atenuados o inactivados.

6.1.1.2. VACUNA CONTRA HEPATITIS B (HvB)

TIPO DE VACUNA	Inactivado recombinante	
DESCRIPCIÓN	Contiene el antígeno de superficie (HBsAg) de la Hepatitis B (HvB), obtenido por técnicas de recombinación genética (ADN recombinante).	
COMPOSICIÓN	Vacuna Pediátrica	Vacuna para Adulto
	Cada dosis de 0.5 ml de la vacuna HvB contiene: • Antígeno de superficie hepatitis B 10 mcg. • Gel de hidróxido de aluminio. • Tiomersal	Cada dosis de 1 ml de la vacuna HvB contiene: • Superficie antígeno hepatitis B 20 mcg. • Gel de hidróxido de aluminio. • Tiomersal.
PRESENTACIÓN	Frasco Monodosis de 0.5 ml, suspensión líquida levemente opalescente.	Frasco Monodosis de 1 ml, suspensión líquida levemente opalescente.
INDICACIÓN	Prevención de la transmisión de la hepatitis B.	
ESQUEMA DE VACUNACION	Vacuna Pediátrica	Vacuna para Adulto
	• Recién nacidos con peso igual o mayor de 1500 gr, administrar la dosis correspondiente, dentro de las 12 primeras horas de nacidos (ideal) y	A partir de 20 años, que no recibió o completó el esquema primario. • Población que vive en áreas de alta

	máximo dentro de las 24 horas, usando vacuna contra HVB monovalente". • Excepcionalmente en partos domiciliarios se podrá vacunar hasta los 7 días de nacido. • Niñas y Niños menores de 5 años, que han presentado reacción adversa severa a la vacuna pentavalente o hexavalente. • De 7 a 19 años 11 meses 29 días, que no han iniciado, completado o no muestran evidencias de haber recibido las 3 dosis de vacuna **HvB, en su esquema primario con** vacuna pentavalente o hexavalente.	prevalencia de HvB. No hay límites. • Personal de la salud, de limpieza, estudiantes de salud. • Gestante: ver esquema en el numeral 6.2.1 • Poblaciones indígenas. • Trabajadores Sexuales (TS), • Hombres que tienen sexo con hombres (HSH). • Miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, población privada de la libertad, inmigrantes y refugiados. • Otros grupos de riesgo (véase esquema de vacunación en condiciones especiales)
	• Primera dosis: al primer contacto con el EE.SS. • Segunda dosis: al mes de la primera dosis. • Tercera dosis: a los cinco meses de la segunda dosis (excepto recién nacidos) Ver: Dosis de rescate en Anexo 2 y casos especiales en ítem 6.3.	
DOSIS (CANTIDAD)	• Recién Nacido: Dosis única de 0.5 ml. • En niños, niñas y adolescentes hasta los 19 años, 11meses, 29 días 3 dosis 0.5ml.	• Desde 20 años: 1ml (según esquema primario)
CONSERVACIÓN DE LA VACUNA	+ 2°C a +8°C Frasco abierto: su uso es inmediato	
	Intramuscular:	Intramuscular

VÍA Y SITIO DE ADMINISTRACIÓN	Menor de 2 años tercio medio del músculo vasto externo, en la cara antero lateral externa del muslo. Mayor de 02 años: región deltoides, parte superior de la cara lateral externa del brazo	Región deltoides, parte superior de la cara lateral externa del brazo.
JERINGAS A UTILIZAR	Jeringa descartable de 1 ml con aguja auto retráctil 25G x 5/8" para el RN Jeringa descartable de 1 ml con aguja auto retráctil de 25Gx 1", para niños de 2 meses a más	Jeringa descartable de 1 ml con aguja auto retráctil de 25G x 1".
POSIBLES EFECTOS POST-VACUNALES	Nivel local: dolor, eritema, edema e induración. Nivel sistémico: malestar general, cefalea, fatiga o irritabilidad.	
CONTRAINDICACIÓN	Personas con hipersensibilidad conocida a cualquiera de sus componentes.	
USO SIMULTÁNEO CON OTRAS VACUNAS	Se puede aplicar simultáneamente con cualquier otra vacuna ya sean estas vivos atenuados o inactivados.	

6.1.1.3. VACUNA COMBINADA HEXAVALENTE (DPT-HvB-Hib-IPV) (*)

TIPO DE VACUNA	Inactivados
DESCRIPCIÓN	Vacuna combinada: inactivadas de Bordetella pertussis (célula entera), toxoide diftérico y tetánico, antígeno de superficie del virus de la Hepatitis B, Poliomielitis (inactivada) y el polisacárido conjugado de Haemophilus Influenzae tipo b
COMPOSICIÓN	Cada dosis de 0.5 ml contiene: • Toxoide Diftérico ≥30 UI • Toxoide Tetánico ≥40 UI • B. pertussis (de célula entera) ≥ 4 UI • HBsAg (ADN recombinante)15 mcg • Vacuna inactivada de polio (Cepas Salk crecidas en las células vero) Tipo 1 (40 DU), Tipo 2 (8 DU) y Tipo-3 (32 DU). • Hib (PRP)10 mcg • Conjugado TT (proteína portadora)19 a 33 mcg • Adsorbido en fosfato de aluminio, Al+++ ≤ 1,25 mg • 2- fenoxietanol 0,5%
PRESENTACIÓN	Frasco monodosis de 0.5 ml, líquido color blanquecino, ligeramente opaco.

INDICACIÓN	Inmunización contra la difteria, tétanos, Tos ferina, hepatitis B, Poliomielitis y enfermedades invasivas causadas por Haemophilus influenzae tipo b.
ESQUEMA DE VACUNACIÓN	• Tres (3) dosis a los 2, 4 y 6 meses. • Intervalo: de 2 meses entre dosis y dosis, excepcionalmente 4 semanas o más (ámbitos de difícil acceso, situación de riesgo epidemiológico, entre otras). • Refuerzo a los 18 meses • En caso de interrupción de la vacunación, es importante completar el esquema de 3 dosis. Ver: Dosis de rescate en Anexo 2 y casos especiales en ítem 6.3.
DOSIS (CANTIDAD)	0.5 ml.
CONSERVACIÓN DE LA VACUNA	+ 2°C a +8°C Frasco abierto: uso inmediato
VÍA Y SITIO DE ADMINISTRACIÓN	Intramuscular: Menor de 2 años: tercio medio del músculo vasto externo, en la cara antero lateral externa del muslo. Mayor de 02 años: región deltoides, parte superior de la cara lateral externa del brazo
JERINGAS A UTILIZAR	Jeringa descartable de 1 ml con aguja Auto retráctil 25G x 1"
POSIBLES EFECTOS POST-VACUNALES	Reacciones locales: Dolor, enrojecimiento, induración en el lugar de la aplicación. Reacciones sistémicas: Se manifiestan en las 48 horas siguientes a la vacunación con llanto persistente, alza térmica, irritabilidad. Menos frecuentes (convulsiones tipo espasmos o crisis de ausencia).
CONTRAINDICACIÓN	Reacción alérgica a dosis previas de la vacuna o a uno de sus componentes.
USO SIMULTÁNEO CON OTRAS VACUNAS	Puede ser aplicada simultáneamente con cualquier otra vacuna ya sean estas vivos atenuados o inactivados

(*) La incorporación progresiva de esta vacuna está supeditada al agotamiento de stocks de vacuna pentavalente e IPV en el almacén nacional y los almacenes regionales (DIRESA/GERESA/DIRIS) y locales (Redes, microrredes, IPRESS)

6.1.1.4. VACUNA COMBINADA PENTAVALENTE (DPT-HvB-Hib) (*)

TIPO DE VACUNA	Inactivados
DESCRIPCIÓN	Vacuna combinada, contiene células enteras de Bordetella pertussis inactivadas, toxoide diftérico y tetánico, antígeno de superficie del virus de la Hepatitis B, y el polisacárido capsular purificado de Haemophilus influenza tipo b. Los toxoides de difteria y tétanos se obtienen respectivamente de cultivo de Corynebacterium difteria y Clostridium tetani respectivamente por inactivación con formaldehido y purificación.

	El componente de suspensión de pertussis se obtiene de cultivos de Bordetella de la pertussis tras inactivación y purificación. El componente de Hib se prepara de polisacárido capsular de la cepa de Haemophillus influenzae tipo b y después de la inactivación se liga al toxoide tetánico.
COMPOSICIÓN	Cada dosis de 0.5 ml contiene: • Toxoide Diftérico ≤ 25 Lf (≥ 30 UI) • Toxoide Tetánico ≥ 2.5 Lf (≥ 40 UI) • B. pertussis (célula entera) ≤ 16 UO (≥ 4 UI)* • HBsAg (ADN recombinante) ≥ 10 mcg • Polisacárido capsular purificado de Hib (PRP) conjugado con toxoide tetánico (proteína transportadora) 10mcg • Adsorbido en fosfato de aluminio, Al ≤1.25 mg • Preservante: Tiomersal 0.005% • *El límite Fiducial más bajo (P=0.95) de la potencia estimada no es menos de 2.0UI
PRESENTACIÓN	Frasco monodosis de 0.5 ml, líquido turbio blanquecino
INDICACIÓN	Prevención de la difteria, tos ferina, tétanos, enfermedades invasivas provocadas por el Hib (meningitis, neumonía) y Hepatitis B en niños de 6 años, 11meses 29 días.
ESQUEMA DE VACUNACIÓN	• Se recomienda 03 dosis: 2, 4, 6 meses de edad. • Intervalo: 2 meses entre dosis y dosis, excepcionalmente 4 semanas o más (ámbitos de difícil acceso, situación de riesgo epidemiológico, entre otras). • En caso de interrupción de la vacunación, es importante completar el esquema de 3 dosis, en ningún caso se reinicia el esquema, este se debe completar tomando en cuenta el intervalo mínimo. Ver: Dosis de rescate en Anexo 2 y casos especiales en ítem 6.3.
DOSIS (CANTIDAD)	0.5 ml.
CONSERVACIÓN DE LA VACUNA	+ 2°C a +8°C Frasco abierto: su uso es inmediato
VÍA Y SITIO DE ADMINISTRACIÓN	Intramuscular. Menor de 2 años: músculo vasto externo, en la cara antero lateral externa del muslo, tercio medio. Mayor de 2 años: músculo deltoides, cara lateral externa, tercio superior del brazo.
JERINGAS A UTILIZAR	Jeringa descartable de 1 ml con aguja auto retráctil 25G x 1".
POSIBLES EFECTOS POST-VACUNALES	Reacciones locales:

	Dolor, enrojecimiento en el lugar de la aplicación. Reacciones sistémicas: Se manifiestan en las 48 horas siguientes a la vacunación con llanto prolongado de 24 horas dentro de la administración, alza térmica, irritabilidad. Menos frecuentes (convulsiones tipo espasmos o crisis de ausencia).
CONTRAINDICACIÓN	Reacción alérgica a dosis previas de la vacuna o a uno de sus componentes. Mayores de 7 años
USO SIMULTÁNEO CON OTRAS VACUNAS	Puede ser aplicada simultáneamente con cualquier otra vacuna ya sean estas vivos atenuados o inactivados

(*) Esta vacuna debe usarse hasta el agotamiento de stocks en el nivel nacional, regional y local.

6.1.1.5. VACUNA CONTRA DIFTERIA Y TÉTANOS (DT PEDIÁTRICO)

TIPO DE VACUNA	Inactivados
DESCRIPCIÓN	La vacuna DT es una mezcla de Toxoide Diftérico y Tetánico, adsorbido en fosfato de aluminio. Los Toxoides de Difteria y Tétanos se obtienen de cultivos Corynebacterium diphtheriae y Clostridium tetani. Respectivamente por inactivación con formaldehido seguido de una purificación
COMPOSICIÓN	Una dosis de 0.5 ml contiene: • Toxoide Diftérico: menor o igual 25 Lf (Mayor o igual 30 UI). • Toxoide Tetánico: mayor o igual 5 Lf (Mayor o igual a 40 UI). • Adsorbida en fosfato de aluminio Al+++ (Menor o igual 1.25 mg). • Preservante: Tiomersal
PRESENTACIÓN	Frasco multidosis de 10 dosis, de 5 ml suspensión blanca grisácea.
INDICACIÓN	Prevención de la difteria y tétanos en niños que presentan reacción adversa severa a la vacuna pentavalente (componente pertusis).
ESQUEMA DE VACUNACIÓN	Niños que presentan reacción adversa a la vacuna Pentavalente completar el esquema de vacunación: • Intervalo: 8 semanas entre dosis y dosis. El intervalo mínimo y excepcionalmente será de 4 semanas (ámbitos de difícil acceso, situación de riesgo epidemiológico, entre otras). • En caso de refuerzo para niños con antecedentes de RAM, aplicar 2 dosis, según esquema (18m y 4 años).
DOSIS (CANTIDAD)	0.5ml
CONSERVACION DE LA VACUNA	+ 2°C a +8°C.

MINISTERIO DE SALUD C. VILA

MINISTERIO DE SALUD Dirección de Inmunizaciones Lic. Liliana Mardeny Chirinos Aponte V°B° Dirección Ejecutiva Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública

	Luego de la apertura del frasco se puede conservar 4 semanas.
VÍA Y SITIO DE ADMINISTRACIÓN	Intramuscular. • Menor de 2 años: Tercio medio del músculo vasto externo, en la cara antero lateral externa del muslo. • Mayor de 2 años: músculo deltoides, cara lateral externa, tercio superior del brazo.
JERINGAS A UTILIZAR	Jeringa descartable de 1 ml con aguja auto retráctil 25G x 1"
POSIBLES EFECTOS POSTVACUNALES	Reacciones locales: Dolor, enrojecimiento, edema, induración en el sitio de la aplicación de la vacuna.
CONTRAINDICACIÓN	Reacción alérgica a dosis previas de la vacuna o a uno de sus componentes.
USO SIMULTÁNEO CON OTRAS VACUNAS	Se puede aplicar simultáneamente con cualquier otra vacuna ya sean estas vivos atenuados o inactivados.

6.1.1.6. VACUNA CONTRA HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (Hib)

TIPO DE VACUNA	Inactivados Polisacárido conjugado
DESCRIPCIÓN	La vacuna Hib es un polisacárido capsular bacteriano conjugado con proteína transportadora
COMPOSICIÓN	Polisacárido capsular del Haemophilus influenzae tipo b, más una proteína transportadora adherida (vacuna conjugada).
PRESENTACIÓN	Frasco monodosis con polvo liofilizado. Frasco Ampolla de vidrio con diluyente por 0.5ml.
INDICACIÓN	Confiere inmunidad ante la infección por Hib, agente causal responsable de neumonía, meningitis y otitis media. Se administra en niños que presentan reacciones alérgicas a la vacuna pentavalente o hexavalente. Se considera la vacunación en casos especiales según Esquema. Ver numeral 6.3
ESQUEMA DE VACUNACIÓN	En caso de RAM a vacuna pentavalente usar 2 dosis con intervalos de 2 meses entre dosis y dosis. En caso de refuerzo para niños con antecedentes de RAM, completar las 2 dosis primarias según esquema, y 2 dosis de refuerzos (18m y 4 años). El intervalo mínimo y excepcionalmente será de 4 semanas (ámbitos de difícil acceso, situación de riesgo epidemiológico, entre otras). Esquema de vacunación según casos Especiales. Ver numeral 6.3.
DOSIS (CANTIDAD)	0.5 ml.
CONSERVACIÓN DE LA VACUNA	+ 2°C a +8°C. Frasco abierto: su uso es inmediato

VÍA Y SITIO DE ADMINISTRACIÓN	Intramuscular. • Menor de 2 años: músculo vasto externo, en la cara antero lateral externa del muslo. • Mayor de 2 años: músculo deltoides, cara lateral externa, tercio superior del brazo.
JERINGAS A UTILIZAR	Para administrar: Jeringa descartable de 1 ml con aguja auto retráctil 25G x 1". Para reconstituir: Jeringa descartable de 5 ml con aguja 21G x 11/2".
POSIBLES EFECTOS POST-VACUNALES	Reacciones locales: Dolor, eritema, edema, en el sitio de la aplicación de la vacuna. Reacciones sistémicas: Alza térmica, irritabilidad.
CONTRAINDICACIÓN	Reacción alérgica a dosis previas de la vacuna o a uno de sus componentes.
USO SIMULTÁNEO CON OTRAS VACUNAS	Se puede aplicar simultáneamente con cualquier otra vacuna ya sean estas vivos atenuados o inactivados.

6.1.1.7. VACUNA ANTIPOLIO INACTIVADA (IPV o Salk) (*)

TIPO DE VACUNA	Inactivado
DESCRIPCIÓN	Suspensión inyectable, compuesta por poliovirus inactivados.
COMPOSICIÓN	Una dosis de 0.5 ml contiene: Virus inactivado de la poliomielitis tipo 1 Mahoney*.....40 unidades de antígeno D. Virus inactivado de la poliomielitis tipo 2 MEF-1* ....8 unidades de antígeno D. Virus inactivado de la poliomielitis tipo 3 Saukett* .....32 unidades de antígeno D. 2-fenoxietanol...2,5 mg Formaldehido...12,5 mcg *Cultivado en células Vero.
PRESENTACIÓN	Monodosis, Jeringa precargada por 0.5 ml (1 dosis)
INDICACIÓN	Prevención de la poliomielitis.
ESQUEMA DE VACUNACIÓN	En aquellos que reciban pentavalente: La vacunación contempla 3 dosis: a los 2, 4, 6 meses de edad. Se aplica: un refuerzo a los 18 meses (*) Podrá administrarse una dosis adicional de IPV como parte de una intervención de respuesta rápida ante riesgo epidemiológico Ver: Dosis de rescate en Anexo 2 y casos especiales en ítem 6.3.
DOSIS (CANTIDAD)	0.5 ml
CONSERVACIÓN DE LA VACUNA	+ 2°C a +8°C Frasco abierto: su uso es inmediato
VÍA Y SITIO DE ADMINISTRACIÓN	Intramuscular. • Menor de 2 años: tercio medio del músculo vasto externo, en la cara antero lateral externa del muslo.

	• Mayor de 2 años: músculo deltoides, cara lateral externa, tercio superior del brazo.
JERINGAS A UTILIZAR	Jeringa precargada
POSIBLES EFECTOS POST-VACUNALES	Reacciones locales: Dolor en el sitio de la aplicación de la vacuna.
CONTRAINDICACIÓN	Reacción alérgica a dosis previas de la vacuna o a uno de sus componentes.
USO SIMULTÁNEO CON OTRAS VACUNAS	Se puede aplicar simultáneamente con cualquier otra vacuna ya sean estas vivos atenuados o inactivados

(*) Esta vacuna debe usarse hasta el agotamiento de stocks en el nivel nacional, regional y local.

6.1.1.8. VACUNA ANTIPOLIO ORAL DE POLIOVIRUS (APO O SABIN)

TIPO DE VACUNA	Virus Vivo Atenuado
DESCRIPCIÓN	Vacuna bivalente que contiene las suspensiones de los tipos 1 y 3 poliovirus vivo, atenuado (cepa Sabin)
COMPOSICIÓN	Una dosis de 2 gotas contiene: Virus de polio (Sabin) cultivado en las células del riñón de mono Tipo-I $\geq 10^{6.0}$ $DICC_{50}$ Tipo III $\geq 10^{5.8}$ $DICC_{50}$ Neomicina 15 mcg Estabilizante: 1M $MgCl_2$
PRESENTACIÓN	Frascos multidosis de 10 dosis, su color puede variar de amarillo claro a rosa oscuro.
INDICACIÓN	Esta vacuna está indicada para la prevención de la poliomielitis.
ESQUEMA DE VACUNACIÓN	2do refuerzo contra poliomielitis a los 4 años 11 meses 29 días Una dosis adicional a riesgo epidemiológico definida según país. Ver: Dosis de rescate en Anexo 2 y casos especiales en ítem 6.3.
DOSIS (CANTIDAD)	2 gotas
CONSERVACIÓN DE LA VACUNA	+ 2°C a +8°C. Luego de la apertura del frasco se puede conservar 4 semanas.
VÍA Y SITIO DE ADMINISTRACIÓN	Oral. Si el niño escupe o regurgita la vacuna, se administra 1 dosis de reemplazo.
POSIBLES EFECTOS POST-VACUNALES	Es una vacuna segura, en raras ocasiones pueden ocurrir eventos adversos.
CONTRAINDICACIÓN	Inmunodeficiencia personal y/o en el núcleo familiar (siendo reemplazada por IPV) y niños de madre con tratamiento inmunosupresor.
USO SIMULTÁNEO CON OTRAS VACUNAS	Se puede aplicar simultáneamente con cualquier otra vacuna ya sean estas vivos atenuados o inactivados.

6.1.1.9. VACUNA CONTRA ROTAVIRUS

TIPO DE VACUNA	Virus Vivo Atenuado
DESCRIPCIÓN	Es una vacuna líquida monovalente. Indicada para la prevención de la gastroenteritis causada por el rotavirus.
COMPOSICIÓN	1 dosis (1,5 ml) contiene: Rotavirus humano, vivo atenuado, cepa RIX 4414* no menos de $10^{6.0}$ $DICC_{50}$ Producido en células Vero
PRESENTACIÓN	Monodosis. Jeringa precargada (aplicador oral) de 1.5 ml Tubo dosificador de 1.5 ml
INDICACIÓN	Prevención de enfermedad diarreica severa causada por rotavirus.
ESQUEMA DE VACUNACIÓN	Corresponde a 2 dosis: 2m y 4m • Intervalo: 2 meses entre dosis y dosis, excepcionalmente el intervalo mínimo será de 04 semanas (ámbitos de difícil acceso, situación de riesgo epidemiológico, entre otras). • Edad máxima de administración de las dos dosis es a los 8 meses CERO días. (sea 1era o 2da dosis) Ver: Dosis de rescate en anexo 2 y casos especiales en ítem 6.3.
DOSIS (CANTIDAD)	1.5 ml.
CONSERVACIÓN DE LA VACUNA	+ 2° a + 8° C jeringa prellenada o aplicador oral y tubo dosificador: su uso es inmediato
VÍA Y SITIO DE ADMINISTRACIÓN	**Oral.** Si el niño escupe o regurgita la vacuna, no se administra dosis de reemplazo.
POSIBLES EFECTOS POST-VACUNALES	Puede presentarse en muy pocos casos: Alza térmica, diarrea, vómitos, irritabilidad.
CONTRAINDICACIÓN	Reacción alérgica a una dosis previa de la vacuna. Niños con Inmunodeficiencia primaria y niños de madres que han estado recibiendo inmunosupresores. Se debe evaluar la administración en lactantes con diarrea aguda o vómitos. No vacunar a mayores de 8 meses 0 días de edad
USO SIMULTÁNEO CON OTRAS VACUNAS	Se puede administrar simultáneamente con cualquier otra vacuna vivo atenuado o inactivado.

6.1.1.10. VACUNA ANTINEUMOCÓCICA (*)

TIPO DE VACUNA	Inactivado Conjugada	
DESCRIPCIÓN	Es una vacuna que previene las infecciones invasivas graves, de los serotipos más comunes de *Streptococcus pneumoniae*.	
COMPOSICIÓN	Vacuna PCV 20, cada dosis de 0.5 ml contiene de: Polisacárido del serotipo (1, 3, 4, 5, 6A, 7F, 8, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F y 33F); 2,2 µg cada uno. Polisacárido del serotipo neumocócico 6B 4,4 µg Proteína diftérica CRM 197- 51 µg. Aluminio como adyuvante en forma de fosfato de aluminio (0,125mg). Otros ingredientes polisorbato 80 mcg, cloruro de sodio y agua para inyección.	
PRESENTACIÓN	Monodosis. Frasco de 0.5 ml, suspensión homogénea de color blanco al mezclar con movimientos rotatorios.	
INDICACIÓN	Prevención de las enfermedades invasivas provocadas por el neumococo como: neumonías, meningitis, sepsis y las no invasivas como otitis media aguda, sinusitis.	
ESQUEMA DE VACUNACIÓN	**Vacunación en menores de 5 años (3 dosis)** 1° y 2° dosis antes del primer año: • 2 y 4 meses de edad. • Intervalo: 2 meses entre la primera y segunda dosis. • 3° dosis a los 12 meses. • Los NO vacunados entre 12 y 23 meses, **recibirán 2 dosis con intervalo mínimo de 4 semanas entre cada dosis.** • Niños de 2 a 4 años que no han recibido ninguna dosis debe recibir	**Mayores de 5 años** Aplicación de una dosis única. • Vacunar a personas con comorbilidad entre ellos: con condiciones médicas crónicas de riesgo como enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedad renal, diabetes, obesidad, otras enfermedades metabólicas, síndrome de Down, nefropatías, cáncer o inmunodeficiencia en fase controlada, hipertensión arterial, accidentes cerebrovasculares, enfermedades neurodegenerativas (Enf. de Parkinson, ELA, enfermedades

	una dosis por única vez.	que reciben controles médicos, entre otros (ver esquema especial numeral 6.3). • **Adulto mayor:** de 60 años a más. • **Personal de Salud.**
	Ver: Dosis de rescate en Anexo 2 y casos especiales en ítem 6.3.	
DOSIS (CANTIDAD)	0.5 ml,	
CONSERVACIÓN DE LA VACUNA	+ 2°C a +8°C Frasco abierto: su uso es inmediato	
VÍA Y SITIO DE ADMINISTRACIÓN	Intramuscular. Menor de 2 años: Tercio medio del músculo vasto externo, en la cara antero lateral externa del muslo. Mayor de 2 años: músculo deltoides, cara lateral externa, tercio superior del brazo.	
JERINGAS A UTILIZAR	Jeringa descartable de 1ml con aguja auto retráctil 25G x 1".	
POSIBLES EFECTOS POST-VACUNALES	**Reacciones locales:** Dolor, eritema, edema y nódulo en el sitio de la inyección. **Reacciones sistémicas:** Alza térmica, irritabilidad, somnolencia, pérdida de apetito, vómitos, diarreas, reacción cutánea.	
CONTRAINDICACIÓN	Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la vacuna incluida el toxoide de la difteria. Reacción anafiláctica a una dosis previa.	
USO SIMULTÁNEO CON OTRAS VACUNAS	Se puede administrar simultáneamente con cualquier otra vacuna vivo atenuado o inactivados.	

(*) La incorporación progresiva de esta vacuna está supeditada al agotamiento de stocks de vacuna antineumocócica trecevalente.

6.1.1.11. VACUNA CONTRA SARAMPIÓN, PAPERAS Y RUBEOLA (SPR)

TIPO DE VACUNA	Virus Vivos Atenuados
DESCRIPCIÓN	Preparadas en cepas vivas atenuadas del virus del sarampión Edmonston-Zagreb, virus de la parotiditis Leningrad-Zagreb (L-Z) cultivado en embrión de pollo y virus de la rubeola Wistar RA 27/3, cultivados en células diploides humanas. Los virus del sarampión y la rubéola se propagan en células diploides humanas (HDC) y el virus de la parotiditis se cultiva en fibroblastos de pollo de huevos SPF (huevos libres de patógenos específicos).

COMPOSICIÓN	La vacuna contiene: ≥ 1000 $DICC_{50}$ del virus de sarampión. ≥ 1000 $DICC_{50}$ del virus de la rubeola ≥ 5000 $DICC_{50}$ del virus de la parotiditis.
PRESENTACIÓN	Vacuna monodosis: Frasco liofilizado con diluyente de 0.5 ml. Vacuna multidosis: Frasco liofilizado con diluyente de 2.5 ml Según presentación del laboratorio productor.
INDICACIÓN	Prevención del Sarampión, Rubeola y Parotiditis
ESQUEMA DE VACUNACIÓN	Dos dosis: 12 meses y 18 meses de edad. En situaciones de brote y de manera excepcional se utilizará las vacunas disponibles SR o SPR en todas las edades Ver: Dosis de rescate en Anexo 2 y casos especiales en ítem 6.3.
DOSIS (CANTIDAD)	0.5 ml
CONSERVACIÓN DE LA VACUNA	+ 2°C a +8°C Multidosis: Una vez reconstituida, el tiempo de uso es 6 horas. Monodosis: Frasco abierto: su uso es inmediato
VÍA Y SITIO DE ADMINISTRACIÓN	Subcutánea En la parte superior de la cara lateral externa del brazo (tercio medio del músculo deltoides).
JERINGAS A UTILIZAR	Para administrar: Jeringa descartable de 1 ml con aguja auto retráctil 25G x 5/8". Para reconstituir: Jeringa descartable de 5 ml con aguja 21G x 11/2"
POSIBLES EFECTOS POST-VACUNALES	Usualmente entre los siete y doce días se puede presentar: **Por el componente sarampión:** Alza térmica, exantema, tos, coriza, manchas de Koplik, purpura trombocitopenia, conjuntivitis del componente anti sarampión. **Por el componente antirrubeólico:** genera fiebre, exantema, además linfoadenopatías y artralgias en menos de 0.5% de los casos. **El componente antiparotídico** puede producir en muy raras ocasiones (menos del 0.1%) fiebre, hipertrofia parotídea, entre el día 7 y 21 post - vacunación.
CONTRAINDICACIÓN	Reacción alérgica severa (anafilaxia) a una dosis previa de la vacuna. Reacción a los componentes de la vacuna. (Huevo, gelatina, Neomicina). Paciente con inmunodeficiencia grave, gestantes

MINISTERIO DE SALUD C. VILA

MINISTERIO DE SALUD Dirección de Inmunizaciones Lic. Liliana Kanashiro Cipriano V°B° Dirección Ejecutiva Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública

USO SIMULTÁNEO CON OTRAS VACUNAS	Se puede administrar simultáneamente con cualquier otra vacuna vivos atenuados e inactivados.

6.1.1.12. VACUNA CONTRA SARAMPIÓN Y RUBEOLA (SR)

TIPO DE VACUNA	Virus vivos atenuados
DESCRIPCIÓN	Preparadas en cepas vivas atenuadas del virus del sarampión Edmonton-Zagreb y virus de la rubeola Wistar RA 27/3, cultivados en células diploides humanas.
COMPOSICIÓN	La vacuna contiene: ≥ 1000 DICC $_{50}$ del virus de sarampión. ≥ 1000 DICC$_{50\ del}$ virus de la rubeola
PRESENTACIÓN	Frasco liofilizado y ampolla con diluyente de 0.5 ml Multidosis
INDICACIÓN	Prevención del Sarampión y Rubeola
ESQUEMA DE VACUNACIÓN	**Una dosis:** A partir de 11 a 59 años (que no recibieron la vacuna). a) Se vacuna en poblaciones de riesgo como: - Personal de salud. - Personal de aeropuertos, terrapuertos, migraciones y otras áreas de contacto con turismo. - Población que vive en fronteras y en zona de elevado tránsito turístico-comercial. - Población que viaja a países con circulación endémica y áreas de brote de sarampión. - Poblaciones indígenas y dispersas, de manera voluntaria, respetando sus derechos y su interculturalidad. b) Se utilizará también en caso de brotes. Ver: Dosis de rescate en anexo 2 y casos especiales en ítem 6.3.
DOSIS (CANTIDAD)	0.5 ml.
CONSERVACIÓN DE LA VACUNA	+ 2°C a +8°C Una vez reconstituida usar dentro de las 6 horas
VÍA Y SITIO DE ADMINISTRACIÓN	Subcutánea, en la parte superior de la cara lateral externa del brazo (tercio medio del musculo deltoides).
JERINGAS A UTILIZAR	Jeringa descartable de 1 ml con aguja auto retráctil 25G x 5/8 Jeringa descartable de 5ml para reconstituir la vacuna

POSIBLES EFECTOS POST-VACUNALES	Usualmente entre los siete y doce días: **Por el componente sarampión**: Alza térmica, exantema, tos, coriza, manchas de Koplik, purpura trombocitopenia, conjuntivitis del componente anti sarampión. **Por el componente antirrubeólico** genera fiebre, exantema, además linfoadenopatías y artralgias en menos de 0.5% de los casos.
CONTRAINDICACIÓN	Reacción alérgica severa (anafilaxia) a una dosis previa de la vacuna. Reacción a los componentes de la vacuna. (huevo, gelatina, Neomicina). Paciente con inmunodeficiencia grave. En el embarazo, la recomendación es no vacunar contra la rubeola es para no asociar la vacuna con complicaciones que eventualmente pueden ocurrir durante la gestación.
USO SIMULTÁNEO CON OTRAS VACUNAS	Se puede administrar simultáneamente con cualquier otra vacuna vivos atenuados e inactivados.

6.1.1.13. VACUNA CONTRA VARICELA

TIPO DE VACUNA	Virus Vivo Atenuado
DESCRIPCIÓN	Es una preparación liofilizada de la cepa vivo atenuado de la varicela (cepa OKA) producida en cultivos de células diploides humanas.
COMPOSICIÓN	Cada dosis de la vacuna reconstituida de 0.5ml contiene no menos de 1350 UFP. Puede contener una cantidad traza de Neomicina.
PRESENTACIÓN	1 frasco ampolla con dosis única de 0.5 ml de vacuna liofilizada acompañada con un frasco de diluyente para reconstitución. Vacuna monodosis
INDICACIÓN	Prevención de la Varicela
ESQUEMA DE VACUNACIÓN	12 meses de edad: 1ra Dosis. 24 meses de edad: 2da Dosis (*) ***Vacunación Post Exposición y control de brote:*** • En brotes hospitalarios con casos de varicela, se aplicará la vacuna a todos los susceptibles inmunocompetentes desde los 9 meses en adelante. • También se vacunará contra la varicela a las personas inmunocompetentes susceptibles (pacientes, acompañantes y personal de la salud) dentro de las primeras 72 horas de producido el contacto con el caso.

	• El manejo será igual en poblaciones cautivas (albergues, cunas, jardín, guarderías, instituciones educativas, entre otros. Ver: Dosis de rescate en anexo 2 y casos especiales en ítem 6.3.
DOSIS (CANTIDAD)	0.5 ml.
CONSERVACIÓN DE LA VACUNA	+ 2° a + 8°C. Frasco abierto: su uso es inmediato
VÍA Y SITIO DE ADMINISTRACIÓN	Subcutánea En la parte superior de la cara lateral externa del brazo (tercio medio del músculo deltoides).
JERINGAS A UTILIZAR	Para administrar: Jeringa descartable de 1ml con aguja auto retráctil 25G x 5/8". Para reconstituir: Jeringa descartable de 5ml con aguja 21G x 11/2"
POSIBLES EFECTOS POST-VACUNALES	Dolor en la zona de aplicación, enrojecimiento, edema. Las reacciones sistémicas se pueden manifestar a partir del 5° día a 30 días posteriores de la vacunación; cursan con irritabilidad, alza térmica mayor a 38 °C, reacción cutánea, somnolencia, pérdida de apetito.
CONTRAINDICACIÓN	Antecedentes de hipersensibilidad a cualquier componente de la vacuna. Individuos que estén recibiendo tratamiento inmunosupresor (incluidas dosis altas de corticosteroides). Inmunodeficiencia Tuberculosis activa no tratada; cualquier enfermedad que presente fiebre >38,5°C.
USO SIMULTÁNEO CON OTRAS VACUNAS	Se puede administrar simultáneamente con cualquier otra vacuna vivos atenuados e inactivados.

(*) 2da dosis de Varicela se incorporará progresivamente.

6.1.1.14. VACUNA CONTRA FIEBRE AMARILLA (AMA)

TIPO DE VACUNA	Virus Vivo Atenuado
DESCRIPCIÓN	Virus de la fiebre amarilla* de la cepa 17D-204 (*Producidos en embriones de pollos libres de patógenos específicos).
COMPOSICIÓN	Cada dosis de 0.5 ml contiene: Frasco o ampolla con disolvente: cloruro de sodio y agua para inyectables (Solución inyectable de cloruro de sodio 0.9%). Virus vivo atenuado: ≥ a 1000 DL^{50} O UFP. Otros componentes: lactosa, sorbitol, clorhidrato de L-histidina-alanina, cloruro de sodio, cloruro de potasio, fosfato disódico,

	fosfato mono potásico, cloruro de calcio y fosfato de magnesio. Frasco o ampolla con disolvente: cloruro de sodio y agua para inyectables (Solución inyectable de cloruro de sodio 0.9%).
PRESENTACIÓN	Vacuna multidosis Frasco con polvo liofilizado para 10 dosis y diluyente de 5 ml. Después de la reconstitución, la suspensión es de color beige a beige-rosado, más o menos opalescente.
INDICACIÓN	• Vacuna que confiere protección contra la infección por el virus causante de la fiebre amarilla
ESQUEMA DE VACUNACIÓN	• 15 meses de edad: 1 dosis (única) • La duración de la protección de una dosis de la vacuna es de por vida, no es necesario revacunar. • En el caso se tenga que viajar a una zona endémica o a un país que solicite esta vacuna, debe ser administrada 10 días antes, hasta antes de los 60 años. Ver: Dosis de rescate en anexo 2 y casos especiales en ítem 6.3.
DOSIS (CANTIDAD)	0.5 ml.
CONSERVACIÓN DE LA VACUNA	+ 2°C a +8°C. Una vez reconstituida, el tiempo de uso es 6 horas.
VÍA Y SITIO DE ADMINISTRACIÓN	Subcutánea, En la parte superior de la cara lateral externa del brazo (tercio medio del músculo deltoides).
JERINGAS A UTILIZAR	Para administrar: jeringa descartable de 1ml con aguja auto retráctil 25G x 5/8, Para reconstituir: Jeringa descartable de 5 ml con aguja 21G x 11/2"
POSIBLES EFECTOS POST-VACUNALES	**Reacciones locales:** Dolor, eritema, edema e induración en el sitio de aplicación. **Reacciones sistémicas:** Cefalea, mialgias. Reacciones adversas severas son extremadamente raras, se han descrito tres tipos de reacciones serias: reacción de hipersensibilidad (anafilaxia), enfermedad neurotrópica (encefalitis) y enfermedad viscerotrópica. La incidencia de estos efectos es más alta en los mayores de 60 años, en razón a ello no se recomienda su vacunación.
CONTRAINDICACIÓN	Mayores de 60 años.

	Hipersensibilidad al huevo, proteínas de pollo o cualquiera de los componentes de la vacuna. Inmunosupresión o antecedentes de afecciones del Timo, o que se le ha extirpado por alguna disfunción. Gestantes o madres en periodo de lactancia (primeros 6 meses de lactancia), salvo prescripción médica.
USO SIMULTÁNEO CON OTRAS VACUNAS	Se puede administrar simultáneamente con cualquier otra vacuna vivo atenuados e inactivados.

6.1.1.15. VACUNA CONTRA DIFTERIA, PERTUSSIS Y TÉTANOS (DPT)

TIPO DE VACUNA	Inactivadas
DESCRIPCIÓN	La Vacuna Adsorbida Antidiftérica, Antitetánica y contra la Tos Ferina se prepara combinando el toxoide diftérico purificado, el toxoide tetánico purificado y bacilos muertos Bordetella Pertussis. Los antígenos se adsorben en el fosfato de aluminio en la forma de adyuvante. Se agrega el Tiomersal como preservante.
COMPOSICIÓN	Cada dosis de 0.5ml contiene: Toxoide diftérico ≤ a 25 LF (≥ a 30 UI) Toxoide tetánico ≥ a 5 LF (≥ a 40 UI) Bordetella pertussis ≤ 16 UO (≥ a 4 UI) Adsorbida en fosfato de aluminio Al+++ ≤ a 1.25 mg. Preservante: Tiomersal 0.005 %
PRESENTACIÓN	Vacuna multidosis Frasco de 10 dosis de 5 ml, suspensión inyectable, blanca grisácea.
INDICACIÓN	Protección contra la Difteria, Tétanos y Tos ferina
ESQUEMA DE VACUNACIÓN	Se administra como Refuerzo dos dosis: 1er Refuerzo a los 18 meses. 2do Refuerzo a los 4 años. Ver: Dosis de rescate en anexo 2 y casos especiales en ítem 6.3.
DOSIS (CANTIDAD)	0.5 ml
CONSERVACIÓN DE LA VACUNA	+ 2°C a +8°C Luego de la apertura del frasco se puede conservar 4 semanas.
VÍA Y SITIO DE ADMINISTRACIÓN	Intramuscular. Menor de 2 años: tercio medio del músculo vasto externo, en la cara antero lateral externa del muslo.

	Mayor de 2 años: músculo deltoides, cara lateral externa, tercio superior del brazo.
JERINGAS A UTILIZAR	Jeringa descartable de 1ml con aguja auto retráctil 25G x 1
POSIBLES EFECTOS POST-VACUNALES	**Reacciones locales:** Dolor, sensibilidad, enrojecimiento, edema e induración en el lugar de la aplicación de la vacuna. **Reacciones sistémicas:** Alza térmica, malestar general e irritabilidad, llanto prolongado de 24 horas dentro de la administración y convulsiones-episodios de hipotonía y reacciones anafilácticas.
CONTRAINDICACIÓN	Anafilaxia a cualquier componente de la vacuna. Encefalopatía en los primeros siete días post vacunación. Mayores de 7 años 0 días.
USO SIMULTÁNEO CON OTRAS VACUNAS	Se puede administrar simultáneamente con otras vacunas vivos atenuados e inactivados.

6.1.1.16. VACUNA CONTRA DIFTERIA Y TÉTANOS (dT ADULTO)

TIPO DE VACUNA	Inactivadas
DESCRIPCIÓN	La vacuna adsorbida antidiftérica y antitetánica para adultos y adolescentes (Td) se prepara combinando el toxoide diftérico purificado y el toxoide tetánico purificado. Los antígenos se adsorben en el fosfato de aluminio en la forma de adyuvante. Se agrega el tiomersal como preservante
COMPOSICIÓN	Una dosis de 0.5ml de vacuna contiene: Toxoide diftérico: ≤ a 5 L.F (≥ a 2UT) Toxoide tetánico: ≤ a 5 L.F (≥ a 40 UT) Adsorbida: En fosfato de aluminio Al^{+++} ≤ Al1.25 mg Preservante: 0.005% Tiomersal
PRESENTACIÓN	Frasco de 10 dosis de 5 ml. Suspensión blanca grisácea. Vacuna multidosis
INDICACIÓN	Prevención de la difteria y tétanos.
ESQUEMA DE VACUNACIÓN	• Toda persona ≥ 7 años de edad en adelante Si no recibió o completó su esquema primario de vacunación (verificar carnet digital y/o físico, administrar un esquema de 3 dosis: – 1ra dosis al primer contacto con el Servicio de Salud – 2da dosis a los 2 meses de la primera dosis

	– 3ra dosis a los 6 meses de la primera dosis • Gestante (ver esquema de gestante). • Cada 10 años se reforzará la inmunidad con una dosis de dT en personas que recibieron esquema completo Ver: Dosis de rescate en anexo 2 y casos especiales en ítem 6.3.
DOSIS (CANTIDAD)	0.5 ml.
CONSERVACIÓN DE LA VACUNA	+ 2°C a +8°C Luego de la apertura del frasco se puede conservar 4 semanas.
VÍA Y SITIO DE ADMINISTRACIÓN	Intramuscular. En la parte superior de la cara lateral externa del brazo, (región deltoides).
JERINGAS A UTILIZAR	Jeringa descartable de 1ml con aguja auto retráctil 25G x 1".
POSIBLES EFECTOS POST-VACUNALES	**Reacciones locales:** Dolor, eritema, nódulo en el sitio de la aplicación de la vacuna. **Reacciones sistémicas:** Malestar general.
CONTRAINDICACIÓN	Hipersensibilidad a cualquier componente de la vacuna en dosis previa. Reacciones neurológicas o reacciones alérgicas sistémicas posteriores a una dosis previa de dT.
USO SIMULTÁNEO CON OTRAS VACUNAS	Se puede administrar simultáneamente con otras vacunas vivos atenuados e inactivados.

6.1.1.17. VACUNA CONTRA DIFTERIA, TÉTANOS Y PERTUSSIS ACELULAR (Tdap)

TIPO DE VACUNA	Acelular inactivada
DESCRIPCIÓN	Vacuna adsorbida de toxoides de tétanos y difteria combinada con componentes de pertussis.
COMPOSICIÓN	Cada dosis (0,5 ml) contiene: Cada dosis de 0,5 ml contiene: Toxoide tetánico: 5 Lf; Toxoide diftérico: 2 Lf; Pertussis acelular: Toxoide de tos ferina (PT): 2,5 µg; Hemaglutinina filamentosa (FHA): 5 µg; Pertactina (PRN): 3 µg; Fimbrias tipos 2 y 3 (FIM): 5 µg; Excipientes: Fosfato de aluminio (adyuvante): 1,5 mg; 2-fenoxietanol: 0,6% (v/v); Residuo del proceso de fabricación: Cantidades ínfimas de formaldehido y glutaraldehído.
PRESENTACIÓN	Frasco de vidrio con 0,5 ml. de suspensión inyectable. Es una suspensión uniforme, turbia y blanca.

	Antes del uso, se debe inspeccionar en busca de partículas o materiales extraños y/o decoloración. Agitar bien el frasco, de manera que se obtenga una suspensión uniforme y turbia. Vacuna monodosis.
INDICACIÓN	Vacunación en cada embarazo para la inmunización pasiva contra la tos ferina.
ESQUEMA DE VACUNACIÓN	• Gestantes una dosis de Tdap entre 20 a 36 semanas de gestación y en cada gestación, (Ver vacunación en gestante). Se debe considerar vacunación completa. • Personal de salud que trabaja en áreas críticas y población mayor de 7 años en zonas de brote de Tos ferina. Ver: Dosis de rescate en anexo 2 y casos especiales en ítem 6.3.
DOSIS (CANTIDAD)	0.5 ml
CONSERVACIÓN DE LA VACUNA	+ 2° a + 8°C Frasco abierto: su uso es inmediato
VÍA Y SITIO DE ADMINISTRACIÓN	Vía intramuscular en la parte superior de la cara lateral externa del brazo, (región deltoides).
JERINGAS A UTILIZAR	Jeringa descartable de 1ml con aguja auto retráctil 25G x 1
POSIBLES EFECTOS POST-VACUNALES	En el lugar de la aplicación puede presentar dolor, eritema, hinchazón. Reacciones sistémicas: alza térmica mayor a 38°C, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea, malestar general.
CONTRAINDICACIÓN	Hipersensibilidad a los principios activos o algún excipiente. Hipersensibilidad después de la administración previa de una vacuna contra la difteria, el tétano y la tos ferina.
USO SIMULTÁNEO CON OTRAS VACUNAS	Se puede administrar simultáneamente con otras vacunas vivos atenuados e inactivados.

6.1.1.18. VACUNA CONTRA HEPATITIS A (HVA)

TIPO DE VACUNA	Virus Inactivado y adsorbido
DESCRIPCIÓN	Vacuna que contiene virus de la hepatitis A inactivado (cepa HM175) y adsorbido en hidróxido de aluminio.
COMPOSICIÓN	Cada dosis de 0.5ml contiene: Virus de la Hepatitis A inactivado (cepa HM175): 720 Unidades de ELISA Adsorbido en hidróxido de aluminio hidratado Al+++: 0.25 mg

	El sulfato de neomicina está presente como residuo del proceso de fabricación.
PRESENTACIÓN	Vacuna Monodosis: 1 jeringa prellenada de vidrio por 1 dosis (0.5 ml) + 1 aguja descartable 25G 5/8" 1 frasco de vidrio por 1 dosis (0.5 ml) 100 frascos de vidrio por 1 dosis (0.5 ml) La vacuna en reposo, el contenido muestra un sedimento ligeramente blanquecino con un líquido claro incoloro sobre este. La vacuna se debe agitar bien antes de su uso a fin de obtener una suspensión blanca ligeramente opaca. Si la apariencia del contenido es diferente, no se debe usar el producto.
INDICACIÓN	Prevención contra la "infección por virus de la Hepatitis A" Ver: Dosis de rescate en anexo 2 y casos especiales en ítem 6.3.
ESQUEMA DE VACUNACIÓN	Una sola dosis a los 15 meses de edad.
DOSIS (CANTIDAD)	0.5 ml
CONSERVACIÓN DE LA VACUNA	+ 2°C a +8°C Frasco abierto: su uso es inmediato
VÍA Y SITIO DE ADMINISTRACIÓN	Intramuscular. Menor de 2 años: Tercio medio del músculo vasto externo, en la cara antero lateral externa del muslo. Mayor de 2 años: músculo deltoides, cara lateral externa, tercio superior del brazo.
JERINGAS A UTILIZAR	Jeringa descartable de 1ml con aguja auto retráctil 25G x 1
POSIBLES EFECTOS POST-VACUNALES	Las reacciones en cuestión son leves e incluyen dolor local y, con menor frecuencia, induración en el sitio de la inyección, pérdida de apetito, somnolencia, cefalea o fiebre.
CONTRAINDICACIÓN	Hipersensibilidad a los excipientes de la vacuna o a la neomicina. Posponer la vacunación en caso de enfermedad febril aguda grave.
USO SIMULTÁNEO CON OTRAS VACUNAS	Se puede administrar simultáneamente con otras vacunas vivos atenuados e inactivados.

6.1.1.19. VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH) (*)

TIPO DE VACUNA	Inactivada (recombinante)
DESCRIPCIÓN	Vacuna Recombinante que ofrece protección contra la infección por los principales genotipos oncogénicos del virus del papiloma

	humano, asociados con el desarrollo del cáncer de cuello uterino, cervical y verrugas genitales.
COMPOSICIÓN	Vacuna nonavalente. Cada dosis de 0.5 ml contiene: Proteína L1 tipo $6^{1,2}$ 30 µg, Proteína L1 tipo $11^{1,2}$ 40 µg, Proteína L1 tipo $16^{1,2}$ 60 µg, Proteína L1 tipo $18^{1,2}$ 40 µg, Proteína L1 tipo $31^{1,2}$ 20 µg, Proteína L1 tipo $33^{1,2}$ 20 µg, Proteína L1 tipo $45^{1,2}$ 20 µg, Proteína L1 tipo $52^{1,2}$ 20 µg, Proteína L1 tipo $58^{1,2}$ 20 µg. Sustrato levadura. Adyuvante: Absorbida en hidroxidofosfato sulfato de aluminio amorfo como adyuvante (0,5 miligramos de Al). Otros componentes: Cloruro de sodio, L-histidina, polisorbato, 80 µg borato de sodio y agua para inyección.
PRESENTACIÓN	Frasco monodosis de 0.5ml, líquido blanco, nublado
INDICACIÓN	Prevención de: Cancer cervical causado por el VPH Tipo 16 y 18. Neoplasia Intraepitelial cervical (NIC) grado I y II. Verrugas genitales causadas por el VPH 6 y 11. También protege contra los tipos 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58 de VPH de riesgo alto que causan la mayoría de las lesiones precancerosas y los cánceres de cuello uterino, vagina, vulva, ano, y cabeza y cuello, incluso el cáncer de orofaringe.
ESQUEMA DE VACUNACIÓN	Vacuna VPH en niños y niñas Dosis única de 9 a 18 años Ver: Casos especiales en ítem 6.3.
DOSIS (CANTIDAD)	0.5 ml
CONSERVACIÓN DE LA VACUNA	+ 2°C a +8°C Frasco abierto: su uso es inmediato
VÍA Y SITIO DE ADMINISTRACIÓN	Vía intramuscular en la parte superior de la cara lateral externa del brazo, (región deltoides).
JERINGAS A UTILIZAR	Jeringa descartable de 1ml y aguja auto retráctil de 25G x 1".
POSIBLES EFECTOS POST-VACUNALES	Enrojecimiento, adormecimiento de la zona de inyección, alza térmica y sensación de fatiga, rara vez sincope por ansiedad del adolescente.
CONTRAINDICACIÓN	Reacción alérgica grave (anafilaxia) con una dosis de vacuna.
USO SIMULTÁNEO CON OTRAS VACUNAS	Se puede administrar simultáneamente con otras vacunas vivos atenuados o inactivos.

MINISTERIO DE SALUD C. VILA

MINISTERIO DE SALUD Dirección de Inmunizaciones Lic. Liliana Antony Chirinos Acosta V°B° Dirección Ejecutiva Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública

(*) La incorporación progresiva de esta vacuna está supeditada al agotamiento de stocks de vacuna contra el virus de papiloma humano (VPH) tetravalente.

6.1.1.20. VACUNA CONTRA INFLUENZA

TIPO DE VACUNA	Virus Inactivado	
DESCRIPCIÓN	Vacuna que confiere inmunidad contra los serotipos prevalentes de la influenza según su circulación estacional. Las cepas varían cada año de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.	
COMPOSICIÓN	Vacuna trivalente que contiene cepas de virus fraccionado, inactivados y purificados, obtenidos en cultivos celulares de pollo. Incluye cepas de influenza A (H1N1 y H3N2) y cepas de influenza tipo B.	
PRESENTACIÓN	Vacuna monodosis (pediátrica y adultos). 1 frasco de vidrio por 1 dosis (0.5 ml) Vacuna multidosis (pediátrica y adultos) 1 frasco de vidrio por 10 dosis (5 ml)	
INDICACIÓN	Profilaxis contra el virus de la influenza. La Vacuna contra Influenza se administra una vez cada año.	
ESQUEMA DE VACUNACIÓN	**Vacuna Influenza Pediátrica:** • En niños y niñas hasta los 2 años, 11 meses y 29 días de edad. ➢ Menores de 1 año: administrar 2 dosis a los 6 y 7 meses. ➢ De 1 y 2 años: administrar 1 dosis cada año.	**Vacuna Influenza Adulto:** • A partir de los 3 años de edad, se utiliza la presentación de adulto. • Administrar 1 dosis cada año. ➢ Vacunar a personas con comorbilidad: enfermedades cardiovasculares, respiratorias crónicas, enfermedad renal, diabetes, obesidad, otras enfermedades metabólicas, cáncer o inmunodeficiencia en fase controlada, hipertensión arterial, accidentes cerebrovasculares, enfermedades neurodegenerativas (Enf. de Parkinson, ELA, enfermedades que reciben controles médicos, entre otros (ver esquema especial numeral 6.3).

		➢ vacunar en pacientes sin síntomas respiratorios activos o reagudizados. ➢ **Adulto mayor:** de 60 años a más. ➢ **Personal de Salud (ver esquema).** ➢ **Grupos de Riesgo**: - Población de distritos en riesgo por bajas temperaturas (heladas y friajes). - Comunidades Nativas. - Estudiantes de ciencias de la salud. - Fuerzas Armadas. - Personal de la PNP- Perú. - Cruz Roja, Bomberos y Defensa Civil. - Población Privada de su Libertad (cárceles, penales). - Centros de rehabilitación, casas de reposo, albergues. - Trabajadores avícolas (expuestas a aves infectadas vivas o muertas) residentes en granjas con brote. - Personal de control de brote (sacrificio, limpieza y desinfección) - Gestantes (ver esquema)
	Ver: Dosis de rescate en anexo 2 y casos especiales en ítem 6.3.	
DOSIS (CANTIDAD)	0.25 ml. Dosis pediátrica 0.50 ml. Dosis de Adultos desde los 3 años	

MINISTERIO DE SALUD
C. VILA

MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Inmunizaciones
Lic. Liliana Matterry Chirinos Agonía
V°B°
Dirección Ejecutiva
Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública

CONSERVACIÓN DE LA VACUNA	+ 2°C a +8°C Pediátrica: Luego de la apertura del frasco se puede conservar 4 semanas Adulto: Frasco abierto: su uso es inmediato
VÍA Y SITIO DE ADMINISTRACIÓN	Intramuscular. Menor de 2 años: músculo vasto externo, en la cara antero lateral externa del muslo (pierna). Mayores de 2 años a más: músculo deltoides, cara lateral externa, tercio superior del brazo.
JERINGAS A UTILIZAR	Jeringa descartable de 1ml con aguja auto retráctil 25G x 1", (para dosis pediátrico) Jeringa prellenada o jeringa descartable de 1ml con aguja auto retráctil 25G x 1" auto retráctil. (adultos)
POSIBLES EFECTOS POST-VACUNALES	**Reacciones locales:** Dolor, enrojecimiento, edema e induración en el lugar de la inyección. **Reacciones sistémicas:** Alza térmica, malestar general y mialgias usualmente desaparecen de 2 a 3 días.
CONTRAINDICACIÓN	Antecedente de reacción alérgica severa a dosis previa de la vacuna o sus componentes. Lactantes menores de 6 meses de edad.
USO SIMULTÁNEO CON OTRAS VACUNAS	Se puede administrar simultáneamente con cualquier otra vacuna vivos atenuados o inactivados.

6.1.1.21. VACUNA FRENTE AL VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL (RECOMBINANTE) (VRS)

TIPO DE VACUNA	Vacunas de subunidades proteicas, basadas en proteínas recombinantes.
DESCRIPCIÓN	Vacuna frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS) bivalente recombinante, diseñada para prevenir enfermedades graves del tracto respiratorio inferior
COMPOSICIÓN	Cada dosis de 0.5 ml contiene: • Antígeno F estabilizado en prefusión del subgrupo A del VRS 60 microgramos • Antígeno F estabilizado en prefusión del subgrupo B del VRS 60 microgramos. • Excipientes: clorhidrato de trometamol, sacarosa, manitol, polisorbato 80mg, y cloruro de sodio, trometamol.
PRESENTACIÓN	Vial con polvo + jeringa precargada de disolvente + adaptador de vial con o sin aguja 25G x 1 Vacuna monodosis

INDICACIÓN	Prevención de infecciones de vías respiratorias por Virus Respiratorio Sincitial.
ESQUEMA DE VACUNACIÓN	Dosis única de 0.5 ml para gestantes entre 32 a 36 semanas de gestación, en periodo estacional (Abril – septiembre)
DOSIS (CANTIDAD)	Dosis única de 0.5 ml
CONSERVACIÓN DE LA VACUNA	+ 2°C a +8°C Uso inmediato después de la reconstitución o en 4 horas siguientes si se conserva entre 15°C y 30°C. No congelar.
VÍA Y SITIO DE ADMINISTRACIÓN	Intramuscular en la región deltoidea de la parte superior del brazo.
JERINGAS A UTILIZAR	Para la reconstitución del polvo se requiere de un adaptador del vial con o sin aguja 25G x 1"que permita el ingreso del disolvente (jeringa prellenada) al vial con el polvo.
POSIBLES EFECTOS POSTVACUNALES	Dolor en el lugar de vacunación, cefalea y mialgia, de intensidad leve a moderada que remiten en los 2 a 3 días posteriores a la aparición.
CONTRAINDICACION	Hipersensibilidad a los principios activos, trometamol, clorhidrato de trometamol, sacarosa, manitol, polisorbato 80, cloruro de sodio, ácido clorhídrico y agua para inyección.
USO SIMULTÁNEO CON OTRAS VACUNAS	Puede ser aplicada simultáneamente con cualquier otra vacuna ya sean inactivas o muertas. Importante: colocar con 4 semanas de intervalo de la vacuna Tdap.

6.1.1.22. VACUNA COMBINADA HEXAVALENTE (DTaP-HvB-Hib-IPV) (NIÑAS Y NIÑOS VIVIENDO CON VIH)

TIPO DE VACUNA	Inactivados
DESCRIPCIÓN	Vacuna contra la difteria, el tétanos, la tosferina (acelular compuesta), hepatitis B (ADN recombinante), la poliomielitis (inactivada) y Haemophilus Influenzae tipo b (conjugada), absorbida.
COMPOSICIÓN	Suspensión para inyección (líquida/liofilizado), una dosis de 0.5ml contiene: • Toxoide diftérico • Toxoide tetánico

	• Antígenos de Bordetella pertussis • Polio virus (inactivado): Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3 • Antígeno de superficie del virus de la Hepatitis B • Polisacárido de Haemophilus influenzae tipo b
PRESENTACIÓN	Frasco monodosis de 0.5 ml, líquido turbio, blanquecino
INDICACIÓN	Vacunación primaria y de refuerzo frente a difteria, tétanos, tos ferina, hepatitis B, poliomielitis y enfermedades invasivas causadas por Haemophilus influenzae tipo b (Hib) en prematuros y lactantes con VIH.
ESQUEMA DE VACUNACIÓN	Esquema regular en menores de un año nacido prematuro o viviendo con VIH: tres dosis primarias con 8 semanas de diferencia entre dosis, excepcionalmente 4 semanas o más (ámbitos de difícil acceso, situación de riesgo epidemiológico, entre otras). • Primera dosis: a los (2) dos meses de edad. • Segunda dosis: a los (4) cuatro meses de edad. • Tercera dosis: a los (6) seis meses de edad. • Refuerzo: a los 18 meses de edad (al menos 6 meses después de la última dosis de la vacunación primaria). En caso de interrupción de la vacunación, es importante completar el esquema de 3 dosis.
DOSIS (CANTIDAD)	0.5 ml
CONSERVACIÓN DE LA VACUNA	+2°C a + 8°C Frasco abierto su uso es inmediato.
VÍA Y SITIO DE ADMINISTRACIÓN	Intramuscular: Menor de 2 años: músculo vasto externo, en la cara anterolateral externa del muslo, tercio medio.

	Mayor de 2 años: músculo deltoides, cara lateral externa, tercio superior del brazo.
JERINGAS A UTILIZAR	Jeringa descartable de 1 ml con aguja auto retráctil 25G x 1".
POSIBLES EFECTOS POSTVACUNALES	Reacciones locales: Dolor, enrojecimiento, induración en el lugar de la aplicación Reacciones sistémicas: Anorexia, llanto, somnolencia, alza térmica (temperatura corporal ≥38,0 °C), irritabilidad, reacción de hipersensibilidad. Menos frecuentes: Reacción anafiláctica, convulsiones con o sin fiebre, erupción. Inflamación extensa de un miembro
CONTRAINDICACION	Reacción alérgica o anafiláctica a dosis previas de la vacuna o a uno de sus componentes. Encefalopatía de etiología desconocida en los 7 días posteriores a una vacuna previa de pertusis Mayores de 3 años
USO SIMULTÁNEO CON OTRAS VACUNAS	Puede ser aplicada simultáneamente con cualquier otra vacuna ya sean estas vivos atenuados o inactivados

6.1.1.23. VACUNA MENINGOCOCO (NIÑAS Y NIÑOS VIVIENDO CON VIH)

TIPO DE VACUNA	Vacuna conjugada
DESCRIPCIÓN	Vacuna meningocócica tetravalente que protege contra los serogrupos **A, C, W, Y**
COMPOSICIÓN	Cada dosis (0,5 ml) contiene: Polisacárido de Neisseria meningitidis del grupo A[1] ..... 5 ó 10 microgramos Polisacárido de Neisseria meningitidis del grupo C[1] ..... 5 microgramos Polisacárido de Neisseria meningitidis del grupo W ..... 5 microgramos Polisacárido de Neisseria meningitidis del grupo Y[1] ..... 5 microgramos [1] conjugado con toxoide tetánico como proteína portadora

PRESENTACIÓN	Solución inyectable lista para usar ó frasco con polvo y disolvente para su reconstitución
INDICACIÓN	Prevención de enfermedad meningocócica invasiva causada por *Neisseria meningitidis* de los serogrupos A, C, W, Y
ESQUEMA DE VACUNACIÓN	02 dosis: a los 13 meses y 15 meses
DOSIS (CANTIDAD)	0.5 ml
CONSERVACIÓN DE LA VACUNA	+ 2°C a +8°C.
VÍA Y SITIO DE ADMINISTRACIÓN	Inyección intramuscular Muslo anterolateral (externo) en niños menores de 2 años
JERINGAS A UTILIZAR	Para administrar: jeringa descartable de 1cc con aguja auto retráctil 25G x 1
POSIBLES EFECTOS POST-VACUNALES	Pérdida del apetito, irritabilidad, somnolencia, insomnio, vómitos, diarrea, urticaria, llanto, prurito, fiebre e induración en el lugar de administración.
CONTRAINDICACIÓN	Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.
USO SIMULTÁNEO CON OTRAS VACUNAS	Puede ser aplicada simultáneamente con otras vacunas

6.1.1.24. INMUNIZACIÓN CON ANTICUERPO MONOCLONAL CONTRA EL VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL

TIPO DE INMUNIZACIÓN	Inmunización pasiva con Anticuerpo monoclonal humano (IgG1κ) recombinante de vida media extendida con alta capacidad neutralizante contra el Virus Respiratorio Sincitial (VRS) Nirsevimab
DESCRIPCIÓN	Está clasificado como un Anticuerpo Monoclonal de acción prolongada. Categoría farmacoterapéutica: Inmunosueros e inmunoglobulinas. Código ATC: J06BD08 (pertenece al grupo de antivirales de acción directa, específicamente anticuerpos monoclonales).
COMPOSICIÓN	Solución inyectable sin preservantes, cada dosis contiene: • Nirsevimab 50 mg/ 0,5 mL, ó • Nirsevimab 100 mg/ 1 mL. Excipientes: • L-histidina,,clorhidrato de L-histidina monohidrato • clorhidrato de L-arginina; • Polisorbato 80, Sacarosa agua para inyección.
PRESENTACIÓN	Jeringa precargada

INDICACIÓN	Prevención de infecciones de vías respiratorias por Virus Respiratorio Sincitial en recién nacidos y lactantes menores de 6 meses, nacidos durante el periodo estacional de abril a septiembre.
ESQUEMA	En recién nacidos de madres no vacunadas frente al virus respiratorio sincitial VRS y excepcionalmente en niños menores de 6 meses de no haber recibido la vacuna en su etapa de recién nacido
DOSIS (CANTIDAD)	La dosis recomendada es una dosis única de 50 mg administrados vía intramuscular para recién nacidos con peso corporal <5 kg y una dosis única de 100 mg administrados vía intramuscular para lactantes con peso corporal ≥5 kg, en casos excepcionales para los menores de 6 meses
CONSERVACIÓN DE LA VACUNA	+ 2°C a +8°C No congelar. Proteger de la luz (conservar la jeringa prellenada en el envase secundario). No agitar ni exponer al calor directo
VÍA Y SITIO DE ADMINISTRACIÓN	Se administra por vía intramuscular, preferiblemente en la cara anterolateral del muslo. Si se requieren dos inyecciones, se deben usar diferentes sitios de inyección
JERINGAS A UTILIZAR	Jeringa precargada.
POSIBLES EFECTOS POSTVACUNALES	Reacciones poco frecuentes: Reacciones en el sitio de punción (dolor, inflamación, edema): 0,3% - Fiebre: 0,5%- Erupción cutánea (erupción maculopapular, erupción macular): 0,7%. La mayoría de los casos son de intensidad leve a moderada
CONTRAINDICACION	Hipersensibilidad a los principios activos, L-histidina, Hidrocloruro de L-histidina, Hidrocloruro de L-arginina, Sacarosa, Polisorbato 80 (E433) y Agua para preparaciones inyectables.
USO SIMULTÁNEO CON OTRAS VACUNAS	Puede ser aplicada simultáneamente con cualquier otra vacuna ya sean estas vivas atenuadas e inactivas o muertas No requiere intervalo de tiempo específico con otras vacunas.

Para mayor información de las vacunas, revisar las fichas técnicas autorizadas por DIGEMID disponibles en el siguiente enlace: https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/fichas-tecnicas-de-productos-biologicos/

6.2. ESQUEMA DE VACUNACIÓN POR CURSO DE VIDA

En base a las evidencias, las inmunizaciones en el Perú han migrado, desde vacunación en la infancia hacia la vacunación por curso de vida de la persona, ofreciendo vacunas para los distintos grupos de edades y con enfoque de riesgo.

6.2.1. ESQUEMA DE VACUNACIÓN EN EL PERIODO PRENATAL

EDAD GESTACIONAL	TIPO DE VACUNA	DOSIS	OBSERVACIÓN
Embarazo de 20 a 36 semanas	**Tdap**	01 dosis en cada gestación	En cada embarazo
Embarazo de 32 a 36 semanas	**VRS**	01 dosis en cada gestación	En cada embarazo
Embarazo (cualquier edad gestacional)	**Influenza adulta**	01 dosis	Anual
Embarazo (cualquier edad gestacional) si no están vacunadas o tienen esquema incompleto	**Hepatitis B**	1ª dosis Al contacto con servicio de salud	Una vez iniciado el esquema debe completar su esquema, aún después del parto.
		2ª dosis Al mes de la primera	
		3ª dosis Al mes de la segunda	
Embarazo (a partir de las 20 semanas)	**dT**	Si no recibió su esquema primario debe recibir 1 dosis de Tdap y 2 dosis de dT (según edad gestacional que inicie la vacunación):	Una vez iniciado el esquema debe completar su esquema, aún después del parto
		1ra dosis a partir de las 20 semanas de gestación Tdap	
		2da dosis a los 2 meses de la 1era dosis	
		3ra dosis a los 4 meses de la 2da dosis	
		Vacunación incompleta: Completar vacunas con prioridad de vacuna Tdap entre las 20-36 semanas de gestación	
		El intervalo mínimo es de 4 semanas	

6.2.2. ESQUEMA DE VACUNACIÓN DE LA NIÑA Y EL NIÑO (0 a 11 años, 11 meses y 29 días).

EDAD	TIPO DE VACUNA	DOSIS
Recién Nacido	Vacuna Bacilo de Calmette-Guerin (BCG).	Dosis Única
	Vacuna Virus de Hepatitis B (HVB)	

	Anticuerpo Monoclonal contra el Virus Respiratorio Sincitial	
2 meses	Vacuna Pentavalente (DPT-HvB-Hib) o Hexavalente (DPT-HvB-Hib-IPV) (*)	1ra. Dosis
	Vacuna Antipolio inactivada inyectable (IPV). (**)	
	Vacuna contra Rotavirus	
	Vacuna Neumococo	
4 meses	Vacuna Pentavalente (DPT-HvB-Hib) o Hexavalente (DPT-HvB-Hib-IPV).(*)	2da. Dosis
	Vacuna Antipolio inactivada inyectable (IPV). (**)	
	Vacuna contra Rotavirus	
	Vacuna Neumococo	
6 meses	Vacuna Pentavalente (DPT-HvB-Hib) o Hexavalente (DPT-HvB-Hib-IPV) (*).	3ra. Dosis
	Vacuna Antipolio inactivada inyectable (IPV)(**)	
	Vacuna Influenza Pediátrica	1ra. Dosis
1 a 6 meses	Anticuerpo Monoclonal contra el Virus Respiratorio Sincitial (***)	Dosis única
7 meses	Vacuna Influenza Pediátrica	2da. Dosis
12 meses	Vacuna Sarampión, Paperas, Rubéola (SPR)	1ra. Dosis
	Vacuna Neumococo	3ra. Dosis
	Vacuna contra la Varicela	1ra. Dosis
	Vacuna Influenza Pediátrica	Dosis única
15 meses	Vacuna Antiamarílica (AMA)	Dosis Única
	Vacuna Virus de Hepatitis A	Dosis Única
18 meses	Vacuna Difteria-Pertussis-Tétanos (DPT) - Vacuna Antipolio inactivada inyectable (IPV) (**) o Hexavalente (DPT-HvB-Hib-IPV) (*)	1er. Refuerzo
	Vacuna Sarampión, Paperas, Rubéola (SPR)	2da. Dosis
2 años	Vacuna Influenza Pediátrica	Dosis única
	Vacuna contra la Varicela(****)	2da. Dosis
3 años	Vacuna Influenza Adulto	Dosis única
4 años	Vacuna Influenza Adulto	Dosis única
	Vacuna Difteria-Pertussis-Tétanos. (DPT)	2da. Dosis de Refuerzo
	Vacuna Antipolio oral (APO)	2da. Dosis de Refuerzo
5 a 11 años	Vacuna SR/SPR	Dosis única según cumplimiento del esquema primario: (sin dosis o esquema incompleto) en zonas de brote.
9 a 11 años	Vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH)	Dosis única

MINISTERIO DE SALUD Dirección de Inmunizaciones Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública C. VILA

MINISTERIO DE SALUD Dirección de Inmunizaciones Lic. Liliana Marleny Chumos Apaclla V°B° Dirección Ejecutiva Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública

(*) La aplicación de la vacuna hexavalente está supeditada al agotamiento de los stocks de vacuna pentavalente e IPV en el almacén nacional, regional y nivel local (Red, Microrred, IPRESS).
(**) Considerar su aplicación cuando recibe vacuna pentavalente.
(***) En caso no haya recibido el anticuerpo monoclonal en la etapa neonatal (recién nacido) o se considere de alto riesgo
(****) 2da dosis de Varicela se incorporará progresivamente

6.2.3. ESQUEMA DE VACUNACIÓN EN EL ADOLESCENTE

EDAD	TIPO DE VACUNA	DOSIS
De 12 a 17 años	Vacuna contra la Influenza adulto	Dosis única cada año
	Vacuna dT adulto	3 dosis (según esquema primario)
	Vacuna HvB según edad	3 dosis (según esquema primario)
	Vacuna AMA	Dosis única (según esquema primario)
	Vacuna SR/SPR	Dosis única según cumplimiento del esquema primario: (sin dosis o esquema incompleto). Zonas de brote.
	Vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH)	Dosis única (según esquema primario)
De 14 a 17 años	Vacuna Tdap	Dosis única (en zonas de brote de tos ferina) y en gestante

6.2.4. ESQUEMA DE VACUNACIÓN EN EL JOVEN

EDAD	TIPO DE VACUNA	DOSIS
18 años	Vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH)	Dosis única (según esquema primario)
De 18 a 29 años (Joven)	Vacuna Influenza adulto	Dosis única cada año
	Vacuna dT adulto	3 dosis (según esquema primario)
	Vacuna HvB	3 dosis (según esquema primario)
	Vacuna AMA	Dosis única (según esquema primario)
	Vacuna Tdap	Dosis única (en zonas de brote de tos ferina) y gestantes
	Vacuna SR/SPR	Dosis única según cumplimiento del esquema primario: (sin dosis o esquema incompleto). Zonas de brote.

6.2.5. ESQUEMA DE VACUNACIÓN EN EL ADULTO

EDAD	TIPO DE VACUNA	DOSIS
	Vacuna Influenza adulto	Dosis única cada año

De 30 a 59 años (Adulto)	Vacuna dT adulto	3 dosis (según esquema primario)
	Vacuna HvB	3 dosis (según esquema primario)
	Vacuna AMA	Dosis única (según esquema primario)
	Vacuna Tdap	Dosis única (en zonas de brote de tos ferina) y gestante
	Vacuna SR/SPR	Dosis única según cumplimiento del esquema primario: (sin dosis o esquema incompleto). Zonas de brote.

6.2.6. ESQUEMA DE VACUNACIÓN EN EL ADULTO MAYOR (60 años a más)

EDAD	TIPO DE VACUNA	DOSIS
De 60 años a mas	Vacuna Influenza adulto	Dosis única cada año.
	Vacuna Neumococo	Dosis única.

6.3. ESQUEMA DE VACUNACIÓN PARA CASOS ESPECIALES

6.3.1. ESQUEMA DE VACUNACIÓN PARA NIÑAS Y NIÑOS CON INFECCIÓN POR EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) O NACIDOS DE MADRES CON VIH

EDAD	VACUNA	
	VIH (+) ASINTOMÁTICO	VIH (+) SINTOMÁTICO
Recién nacido (28 días)	Una dosis de BCG	(*) Bajo evaluación médica
	Una dosis de HvB Monodosis	Una dosis de HvB Monodosis
	Una dosis de anticuerpo monoclonal	Una dosis de anticuerpo monoclonal
2 meses	1ra. dosis: Pentavalente - Polio inactivada (IPV) o Hexavalente acelular, Neumococo y Rotavirus	1ra. dosis: Pentavalente - Polio inactivada (IPV) o hexavalente acelular, Neumococo (estas vacunas se colocan a todos) Rotavirus la vacunación se realizará bajo evaluación médica
4 meses	2da. dosis Pentavalente - Polio inactivada (IPV) o Hexavalente acelular, Neumococo y Rotavirus*	2da. Dosis: Pentavalente - Polio inactivada (IPV) o hexavalente acelular, Neumococo Rotavirus la vacunación se realizará bajo evaluación médica
6 meses	3ra. dosis Pentavalente y Polio inactivada (IPV) o hexavalente acelular y Neumococo, 1era dosis influenza	
7 meses	2da dosis Influenza	

12 meses	1ra. dosis SPR y 1era dosis de varicela. 4ta. dosis Neumococo.	(*) SPR y VARICELA. La vacunación se realizará bajo evaluación médica. 4ta. dosis Neumococo
13 meses	Meningococo 1ra dosis	
15 meses	1 dosis de vacuna Antiamarílica* 1 dosis de vacuna HvA Meningococo 2da dosis	Individualizar según nivel de riesgo de exposición y estado inmunológico La vacunación se realizará bajo evaluación médica
18 meses	1er. refuerzo de vacuna DPT - Polio inactivada (IPV) o Hexavalente acelular, 2da. Dosis de SPR* 2da. Dosis de Varicela	1er. refuerzo de vacuna DPT - Polio inactivada (IPV) o Hexavalente acelular, 2da. Dosis de SPR*. 2da. Dosis de Varicela (*) (Se recomienda la vacunación bajo evaluación médica)
Mayor de 1 año	1 dosis Influenza cada año	
4 años hasta 7 años 0 días	2do. Refuerzo: DPT-IPV	2$^{do.}$ Refuerzo: DPT-IPV
Niñas, niños y adolescentes de 9 – 18 años	VPH 3 dosis: según esquema 1ra dosis al contacto 2da dosis a los 2 meses de la 1era dosis 3era dosis a los 6 meses de la 2da dosis Los pacientes que han recibido la segunda dosis, completarán el esquema de vacunación con tres dosis a partir de los seis meses de haber recibido la segunda dosis. Pacientes con Tuberculosis: El diagnóstico de Tuberculosis activa no constituye una contraindicación para la vacunación	

* (BCG, SPR, Varicela, Antiamarílica), evaluación e indicación médica

6.3.2. ESQUEMA DE VACUNACIÓN PARA ADULTOS CON INFECCIÓN VIH/SIDA

VACUNA	DOSIS	INDICACIONES
Anti difto-tétano (dT)	0.5 ml IM, 3 dosis (0, 2, 6 meses)	Cada 10 años
Hepatitis B (HvB)	40 ug/2ml IM. 3 dosis (0, 1, 2 meses)	Se deberá solicitar dosaje de anti-HBs Ag a los 30 días de culminada la vacunación, si anti-HBs Ag es < 10 UI, aplicar una dosis adicional, según criterio médico.
Influenza Estacional	0.5 ml IM.	Anualmente
Neumococo	0.5 ml IM.	Una dosis única
HIB	0.5 ml IM.	Una dosis única
VPH (18 a 26 años)	0.5 ml IM.	1ra dosis al contacto 2da dosis a los 2 meses de la 1era dosis 3era dosis a los 6 meses de la 2da dosis Los pacientes que han recibido la segunda dosis, completarán el esquema de

		vacunación con tres dosis a partir de los seis meses de haber recibido la segunda dosis.

6.3.3. ESQUEMA DE VACUNACIÓN EN OTROS CASOS ESPECIALES

POBLACIÓN OBJETIVO	EDAD	VACUNA	DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
R.N. Prematuro/ Bajo peso al nacer / Niño nacido de madre con VIH	Al recuperar peso 1,500g	BCG	0.05ml Intradérmica
		HVB	0.5 ml Intramuscular
	Esquema primario: 2, 4, y 6 meses. Refuerzos: 1° refuerzo a los 18 meses	Hexavalente acelular (DTaP-HvB-Hib-IPV)	0.5 ml Intramuscular
Contacto de TB pulmonar	De 1 a menor de 5 años	BCG	0.1cc. vía intradérmica
Pacientes con Hemodiálisis y enfermedad renal crónica	En todas las edades	HVB	Deben recibir dosis doble de antígeno vacunal según edad: < 1 año: 10 ug 1-20 años: 20 ug A partir de 20 años: 40 ug Esquemas acelerados 0, 7 y 21 días; 0, 10 y 21 días; 0, 1, 2 y 12 meses. Si el título de anticuerpos es < 10 mUL/ml luego de completar el primer esquema de vacunación se administrará una nueva serie de 3 dosis con el doble de antígeno vacunal en cada dosis. Si después de este segundo esquema no se obtiene respuesta adecuada se considerará como no respondedor. En los pacientes en diálisis y trasplantados renales se debe medir niveles de anticuerpos anualmente y darse dosis de refuerzo si los

MINISTERIO DE SALUD C. VILA

MINISTERIO DE SALUD Dirección de Inmunizaciones Lic. Liliana Karina Chirinos Arteaga V°B° Dirección Ejecutiva Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública

			niveles caen debajo del nivel de protección
		Neumococo	Sin vacunación: Aplicar 1 dosis
		Influenza	Una dosis anual
Personas que conviven con pacientes inmunodeprimidos	De acuerdo a edad	Influenza y las demás vacunas según esquema.	De acuerdo a evaluación médica Contraindicadas las Vacuna Anti polio Oral
Pacientes Esplenectomizados (**Vacunas de virus atenuados NO están contraindicados**)	Todas las edades (2 semanas antes de la cirugía programada o 2 semanas después de la esplenectomía)	Neumococo	Sin vacunación: Aplicar 1 dosis
		HIB	1 dosis
		Influenza	1 dosis anual
		Resto de Vacunas	Administrar según esquema de vacunación
Pacientes Oncohematológico / Oncológicos	Todas las edades: Iniciar de 3 a 6 meses posterior al término de la quimioterapia	dT	Previamente vacunados 1dosis de refuerzo de lo contrario completar inmunización.
		HiB	Sin vacunación: administrar 1 dosis
		Neumococo	Sin vacunación: Aplicar 1 dosis
		HVB	Mantiene el mismo esquema de vacunación de 3 dosis 0-1-6 meses
		Influenza	Aplicar una dosis anual
		VPH	Niños y adolescentes de 9 a 18 años, deben recibir vacuna al culminar la quimioterapia. Para los pacientes que recibieron su dosis antes de la quimioterapia, deberán recibir 06 meses después de culminada la quimioterapia una dosis adicional.
		Resto de vacunas	Vacunas virus vivo atenuado de acuerdo a evaluación médica
Pacientes Trasplante de Progenitores	Todas las edades desde 3 meses post TPH	Neumococo	3 dosis: intervalo un mes. 4° dosis: refuerzo, aplicar 6 meses

MINISTERIO DE SALUD Dirección de Inmunizaciones Estrategias en Salud Pública C. VILA

MINISTERIO DE SALUD Dirección de Inmunizaciones Lic. Liliana Marleny Chirinos Alcorta V°B° Dirección Ejecutiva Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública

Hematopoyéticos (TPH)			después de la 3era dosis
		Influenza	Una (1) dosis anual
	Todas las edades, desde 6 meses post TPH	IPV	3 dosis: intervalo un mes.
		Hib	3 dosis: intervalo un mes
		HvB	3 dosis: intervalo un mes
		Tdap	3 dosis: intervalo un mes
		VPH	Para los pacientes post TPH, la vacunación con 03 dosis se administrará luego de 06 meses del trasplante, independientemente del status vacunal previo al trasplante
	Todas las edades desde 24 meses post TPH si no hay contraindicación	SPR Si no hay contraindicación, aplicar 24 meses post trasplante	Según valoración médica. Después de la primera dosis, si son seronegativos, se puede considerar una segunda dosis.
		Varicela	Previa serología en pacientes seropositivos previos a TPH: 1 dosis Pacientes seronegativos previos a TPH: 2 dosis, 2 meses de intervalo.
Pacientes con Trasplante de Órganos Sólidos (TOS)	Iniciar al 6to. mes post Trasplante	Neumococo	Dosis única
		Hib	Dosis única
		Influenza	Dosis anual
		HVA	Trasplante hepático: paciente seronegativo aplicar 2 dosis, intervalo 6 meses.
		VPH	Para los pacientes post TOS, la vacunación con 03 dosis se administrará luego de 06 meses del trasplante, independientemente del status vacunal previo al trasplante
		Vacunas inactivadas	Completar según esquema de vacunación

		Vacunas vivas atenuadas	4 semanas antes del trasplante
Inmunosuprimidos	Pediátricos	vacunas inactivas	Según esquema de vacunación
		vacunas vivas atenuadas	De acuerdo a evaluación y prescripción medica

6.3.4. ESQUEMA DE VACUNACIÓN PARA EL PERSONAL DE SALUD

POBLACIÓN OBJETIVO	VACUNA	INTERVALO
Personal de la salud asistencial, administrativo, y estudiantes de la salud (priorizando las áreas asistenciales de emergencia, unidad de cuidados críticos y centro quirúrgico)	Vacuna HVB	1era dosis al contacto con el EE.SS. (según esquema primario)
		2da dosis Al mes de haber recibido la 1era dosis. (según esquema primario)
		3era dosis Al 6to mes de la primera dosis. (según esquema primario)
	Vacuna Influenza	Una dosis anual.
	Vacuna Antiamarílica	Dosis única al contacto con el establecimiento de salud. (según esquema primario)
	Vacuna Neumococo	Dosis única.
	Vacuna dT	1ra dosis al primer contacto con el EE.SS. (según esquema primario)
		2da, a los 2 meses de la primera dosis. (según esquema primario)
		3ra, al sexto mes de la primera dosis. (según esquema primario)
	Tdap* zonas con casos de brotes de tosferina	Una dosis
	SR**	Una dosis según riesgo epidemiológico definido en el país.

*Aplicación de vacuna Tdap en unidades críticas, 2027
** Se utilizará las vacunas disponibles SR o SPR

Nota: Todo personal de una institución de salud, cumple con este esquema de vacunación, siempre y cuando no haya recibido su esquema primario. Asimismo, se aplican otras vacunas según sean aprobadas por la Autoridad Nacional de Salud.

6.4. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN LA VACUNACIÓN

6.4.1. ACTIVIDADES DE VACUNACIÓN INTRAMURALES.

Se realizan en el establecimiento de salud en ambientes que cumplan con las buenas prácticas de almacenamiento (consultorio de inmunizaciones, vacunatorio o consultorio de niño) ver Anexo N° 5, aprovechando la infraestructura, equipamiento y personal disponible capacitado.

Se ejecutan en estricto cumplimiento de los procedimientos establecidos en la normativa de cadena de frío y el presente Esquema Nacional de Inmunizaciones.

6.4.2. ACTIVIDADES DE VACUNACIÓN EXTRAMURALES.

La vacunación extramural se realiza en diversos escenarios fuera de los establecimientos de salud, donde se garantiza en todo momento condiciones adecuadas de almacenamiento y el ingreso al sistema de información HIS MINSA o al componente de inmunizaciones del SIHCE del MINSA; la entrega del carné de vacunación en físico de la persona vacunada (niños o adultos) y la custodia segura de la documentación con información de las personas. Estos puntos se implementan a través de un puesto fijo o un puesto móvil de vacunación, que dependerá de la realidad epidemiológica, demográfica y sociocultural de cada lugar.

a) **Vacunación en puestos fijos**, debidamente identificados y ubicados estratégicamente, son considerados, los mercados, parroquias, lozas deportivas, parques, locales comunales, centros educativos, centros laborales, entre otros. Estos espacios de vacunación garantizan condiciones adecuadas de almacenamiento y de bioseguridad con un flujo adecuado de circulación de los usuarios.

b) **Vacunación en puestos móviles**, están consideradas las brigadas de vacunación que se desplazan por las calles y comunidades para captación de transeúntes y seguimiento de la población objetivo a vacunar o a través de visitas de casa por casa, estas estrategias responden en función al número de brigadas de vacunación consideradas de acuerdo a la población, sectores y conglomerados a visitar.

c) **Intervención en caso de brote de enfermedades inmunoprevenibles:**
   - **Bloqueo vacunal**:
   - Ante la notificación de un caso sospechoso de una enfermedad prevenible por vacuna (tos ferina, sarampión u otras) corresponde a los equipos de inmunizaciones y epidemiología o los que hagan sus veces, organizar y planificar la mencionada actividad: (Monitoreo de disponibilidad de insumos, Operatividad de cadena de frío en inmunizaciones en las zonas de intervención, estrategia a realizar, brigadas, N° de días, zonas de intervención, registro de información a utilizar, entre otros), ejecutar, informar y evaluar la actividad de vacunación.
   - Determinar el ámbito de acción: 5 manzanas a la redonda en torno a la ubicación de la vivienda del caso notificado (121 manzanas), teniendo en cuenta la cadena de transmisión y la ruta que se desplazó el caso en el periodo de transmisibilidad. En poblaciones pequeñas, el ámbito de acción será la totalidad del distrito y centro poblado

1	2	3	4	5	5	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	4	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	3	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	2	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	1	21	22	23	24	25
5	4	3	2	1		1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	1	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	2	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	3	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	4	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	5	21	22	23	24	25

- Las brigadas de vacunación realizan el trabajo de campo (iniciar y/o completar dosis pendientes según esquema de vacunación) en un periodo no menor a 72 horas de notificado el caso.
- Registran la vacunación inmediatamente en el carné, en el registro diario unificado de vacunados, además de garantizar el ingreso oportuno de la información en los sistemas de información, sea en el HIS MINSA o en el componente de inmunizaciones del SIHCE del MINSA.
- La vacunación de los contactos menores de 5 años directos del caso debe realizarse dentro de las 72 horas de notificado el caso o dentro de las 72 horas posteriores a la exposición o según se recomiende para cada enfermedad inmunoprevenible según documento normativo vigente.
- Consolida la información de todos los niños y niñas identificadas en el bloqueo vacunal documentado, identificando la población encontrada con vacunas y a los que vacunaron durante el bloqueo
- El bloqueo vacunal se realiza de forma simultánea a las actividades de monitoreo rápido de vacunación y búsqueda activa comunitaria de casos, como parte de las actividades de los equipos de intervención (brigadas de vacunación y equipo alerta respuesta según sus competencias); en coordinación con el responsable de epidemiología o quien haga sus veces en el establecimiento de salud y niveles regionales.
- De la misma manera, durante las actividades de vacunación complementarias, en su fase casa por casa, el área de epidemiologia es responsable de coordinar actividades de búsqueda activa comunitaria con su personal capacitado.
- Remitir la información de vacunados durante el bloqueo a su inmediato superior y posteriormente a la Dirección de Inmunizaciones de la DGIESP-MINSA, que debe ser socializada al equipo de epidemiología, para incluir en el informe de la investigación epidemiológica del caso confirmado o brote de enfermedad prevenible por vacuna

6.4.3. ACTIVIDADES DE VACUNACIÓN COMPLEMENTARIAS

6.4.3.1 CAMPAÑA NACIONAL "SEMANA DE VACUNACIÓN EN LAS AMÉRICAS" (SVA).

Se desarrollarán todos los años, su finalidad es posicionar a la

vacunación en la comunidad como un derecho, basado en principios de equidad, género, interculturalidad y panamericanismo, así como promover la movilización social a favor de la vacunación como un bien público. Se realiza en la última semana del mes de abril de cada año y se extiende de acuerdo al contexto epidemiológico de las enfermedades prevenibles por vacunación, donde se promueve el desarrollo de acciones de abogacía e incidencia para la implementación de políticas públicas a través de los diferentes niveles de gobierno (nacional, regional y local), sectores del Estado (MINEDU, MIDIS, MIMP, otros), organismos internacionales (OPS, UNICEF, ORAS-CONHU), sector privado y comunidad organizada, que visualiza la importancia de la vacunación en la prevención de enfermedades y la participación de todos los actores en el territorio.

Está orientada a cerrar las brechas de vacunación, mejorando el acceso de las poblaciones dispersas y excluidas del país, enfatizando en los distritos el riesgo por bajas coberturas y presencia de población vulnerable como comunidades alto andinas, amazónicas, migrantes y aquellas zonas de difícil acceso.

Debe programarse todos los años de forma obligatoria en el POI, según nivel de responsabilidad en salud, a nivel nacional, regional y local.

Toda actividad complementaria de vacunación debe contar con estrategias básicas de difusión y movilización social, coordinadas con las Oficinas de Comunicaciones, o quien haga sus veces. Se priorizará el uso de canales de mayor alcance poblacional (medios locales, comunitarios y digitales) según el contexto.

6.4.3.2 CAMPAÑAS DE SEGUIMIENTO - BARRIDOS DE VACUNACIÓN

- Es una actividad complementaria de vacunación masiva. Tiene por finalidad desarrollar una barrera sanitaria en un determinado ámbito geográfico para mantener el control de las enfermedades prevenibles por vacunas. Su implementación debe garantizar coberturas de vacunación adecuada, homogénea y sostenible; disminuyendo los susceptibles a estas enfermedades. Se realiza utilizando diferentes tácticas de vacunación como puestos fijos y móviles, la vacunación de casa por casa es una táctica por excelencia.
- Se realiza cuando el número de susceptibles menores de 5 años supere el tamaño de la cohorte de un año de edad de alguna vacuna del esquema regular
- Ante alertas epidemiológicas que reporten casos importados y se evidencie la posibilidad de circulación comunitaria y el riesgo de reintroducción de estas enfermedades.
- Ante riesgo inminente de reintroducción de alguna enfermedad inmunoprevenible y cuando se tiene que controlar un brote o epidemia de estas enfermedades.
- El ámbito de su ejecución puede ser distrital, provincial, regional o nacional.
- La vacunación es de manera independiente del esquema de vacunación.
- Su ejecución debe ser rápida, de 2 a 4 semanas como máximo.
- Las coberturas alcanzadas son verificadas por MRV directo a

cargo de inmunizaciones y el cruzado a cargo de epidemiología.

6.4.3.3 JORNADAS DE VACUNACIÓN - CIERRE DE BRECHAS:

La disminución de las coberturas de inmunizaciones constituye un importante riesgo para la salud pública, especialmente en la población infantil. En ese contexto, una de las actividades prioritarias en el proceso de vacunación es el Cierre de Brechas, estrategia que se desarrolla con la finalidad de identificar y captar a la población objetivo que no ha iniciado o no ha completado oportunamente su esquema regular de vacunación, contribuyendo así a la protección individual y colectiva frente a enfermedades inmunoprevenibles.

Estas jornadas de vacunación ofrecen:

- Mejorar el acceso de la población a los servicios de vacunación incrementando la oferta con la ampliación del número de brigadas de vacunación.
- Ampliación del horario de atención en los servicios de vacunación de los establecimientos de salud de mayor demanda, estableciendo la programación en el periodo de atención (Días/meses).
- Implementar puntos de vacunación en fechas y horarios estratégicos en lugares públicos accesibles, como estadios, plazas, mercados, iglesias, Instituciones Educativas, etc.
- Utilizar diferentes tácticas según la realidad local tales como Vacunación casa por casa, brigadas móviles, vacunación institucional en los servicios de salud con horarios ampliados y diferenciados.

6.4.3.4 ACTIVIDADES FOCALIZADAS PARA POBLACIONES EN RIESGO:

a) **Vacunación en zonas de Heladas, Friaje y Bajas de temperaturas:** Cada establecimiento de salud según su nivel de responsabilidad fortalecerá la vacunación contra el neumococo y la influenza como prioridad en los distritos priorizados de las zonas altoandinas y en la amazonia de nuestro país afectados, asegurando la vacunación en los menores de 5 años y adultos mayores con el objetivo fundamental de prevenir las complicaciones por IRA durante la temporada de bajas temperaturas con mayor intensidad en los meses de abril a setiembre.

b) **Vacunación en Comunidades Indígenas:** La población indígena será vacunada a través de brigadas itinerantes AISPED y con otras estrategias locales que faciliten el acceso a la vacunación de esta población.

c) **Vacunación en fronteras:** Se realizan a través de actividades articuladas con otros sectores y organismos internacionales, con el objetivo de mejorar las coberturas de vacunación en las zonas fronterizas donde existen brechas por cerrar, con énfasis en niñas, niños, adolescentes, gestantes y adultos mayores, promoviendo la participación de actores sociales.

A través del ORAS-CONHU, se organiza la jornada de vacunación denominada la Semana Andina de Vacunación en Fronteras, durante el mes de agosto, simultáneamente entre los países de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

Toda actividad complementaria de vacunación debe contar con estrategias básicas de difusión y movilización social, coordinadas con las Oficinas de Comunicaciones o quien haga sus veces. Se priorizará el uso de canales de mayor alcance poblacional (medios locales, comunitarios y digitales) según el contexto

6.5. INTERVENCIÓN POR NIVELES DE ATENCIÓN

La DIRESA, GERESA, DIRIS, UE, y todas las instituciones establecidas en el ámbito de aplicación de la presente norma, para la implementación de lo establecido toman en cuenta lo siguiente:

- Las actividades de vacunación deben regirse bajo el cumplimiento estricto de los documentos normativos: NTS de Esquema Nacional de Inmunizaciones y NTS para el manejo de cadena de frío en inmunizaciones.

- El Estado Peruano, a través del MINSA, garantiza la provisión de vacunas y jeringas a nivel regional para el cumplimiento del presente Esquema Nacional de Inmunizaciones.

- La operatividad de las acciones previstas en la presente norma es responsabilidad del gobierno regional y de todas las instituciones establecidas en el ámbito de aplicación de la presente norma.

- Es responsabilidad de los Gobiernos Regionales, DIRIS de Lima Metropolitana, y todas las instituciones establecidas en el ámbito de aplicación de la presente norma, la planificación, programación, ejecución, evaluación, financiamiento y sostenibilidad de las intervenciones de inmunizaciones, asegurar el cumplimiento de las buenas prácticas de almacenamiento y las buenas prácticas de distribución y transporte, así como fortalecer la articulación intersectorial, incluyendo la articulación activa de entidades como RENIEC, a fin de garantizar la identificación oportuna de la población objetivo desde el nacimiento, para asegurar la continuidad de las coberturas y la protección de datos personales de las personas vacunadas.

Es responsabilidad de los Gobiernos Regionales, DIRIS de Lima Metropolitana, y todas las instituciones establecidas en el ámbito de aplicación de la presente norma, garantizar recursos financieros para gastos operativos (distribución de vacunas y jeringas hasta el nivel de establecimientos de salud, compra de insumos médicos, combustible, mantenimiento de cadena de frío en inmunizaciones y medios de transporte, pagos de movilidad local o viáticos para el personal que se desplaza fuera del establecimiento de salud para realizar acciones de seguimiento, buenas prácticas de almacenamiento, distribución, transporte de insumos y otros) a fin de brindar sostenibilidad y continuidad de las acciones para el logro de coberturas de seguridad, así como en la ejecución de actividades de supervisión y asistencia técnica presencial en los establecimientos de salud y otros).

- Los intervalos mínimos de vacunación en población indígena y difícil acceso es de 4 semanas.

- La notificación y la atención de los ESAVI severo se realiza de acuerdo a lo establecido en Directiva Sanitaria N° 054-MINSA/DGE-V.01, "Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación o Inmunización (ESAVI)".

- El registro y notificación de los casos de ESAVI no severo, leve y moderado se realiza de acuerdo a lo establecido por la DIGEMID, en la R.D. N°001-2021-DIGEMID-DG-MINSA o la que haga sus veces. Ver Anexo 13.

6.6. COMPONENTES:

6.6.1 COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN

6.6.1.1 COMITES TÉCNICOS A NIVEL NACIONAL

La normativa sectorial vigente reconoce que la Dirección de Inmunizaciones cuenta con órganos colegiados, tales como los Comités de Expertos y Consultivo, que se detallan a continuación:

- El **COMITÉ DE EXPERTOS DE LA DIRECCIÓN DE INMUNIZACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS EN SALUD PÚBLICA** tiene las siguientes funciones:

  a) Brindar recomendaciones basadas en evidencia científica respecto a la introducción de nuevas vacunas, considerando las prioridades nacionales de salud pública, así como los criterios técnicos programáticos, logísticos y financieros existentes.
  b) Emitir opinión sobre el calendario nacional de vacunación, incluidos los esquemas y tipos de vacunas, así como las especificaciones técnicas para su mejor uso.
  c) Colaborar con las estrategias diseñadas para brindar seguridad a las vacunas incluidas en el calendario nacional.
  d) Proponer mejoras en las políticas sanitarias de inmunizaciones, con particular énfasis en los sistemas de información que permitan monitorear y evaluar las coberturas de vacunación y la calidad de los servicios brindados.
  e) Proponer estrategias de vigilancia y protocolos para notificación de enfermedades prevenibles por vacunación.
  f) Asesorar sobre los adelantos en el desarrollo de nuevas vacunas y el potencial para la inclusión en el calendario nacional de inmunizaciones, así como en las estrategias para la investigación y desarrollo de nuevas vacunas y las tecnologías de administración de vacunas.

- **El COMITÉ DE EXPERTOS DENOMINADO "COMITÉ NACIONAL DE MONITOREO Y RECERTIFICACIÓN DE LA ELIMINACIÓN DEL SARAMPIÓN, LA RUBÉOLA Y EL SÍNDROME DE RUBÉOLA CONGÉNITA"** de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, tiene las siguientes funciones:

a) Verificar la preparación del "Plan de Acción de Monitoreo y de Recertificación de la eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita 2024-2027".
b) Verificar el cumplimiento de los indicadores de inmunizaciones, vigilancia epidemiológica y laboratorio, e informar de dicha situación al Ministro de Salud, así como a la representación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el país.
c) Recomendar y asesorar al Ministerio de Salud una respuesta rápida al detectar casos importados de sarampión para evitar el restablecimiento de la transmisión endémica del virus, incluyendo la activación de equipos que den seguimiento a los casos y sus contactos.
d) Recomendar aspectos relacionados a la reserva de vacuna Sarampión Rubéola (RS) para acciones de control de casos importados.
e) Verificar y validar el documento de la situación del país como libre del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita para presentar al Comité Internacional de la Comisión Regional de Certificación de la Erradicación de la Poliomielitis en la Región de las Américas OPS.

- **COMITÉ DE EXPERTOS DENOMINADO "COMITÉ NACIONAL DE CERTIFICACIÓN DE LA ERRADICACIÓN DE LA POLIOMIELITIS" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS EN SALUD PÚBLICA**, desempeña las siguientes funciones:

a) Verificar y validar la situación del país como libre de Poliomielitis.
b) Verificar la formulación de los planes nacionales, "Plan de respuesta rápida frente a brotes de Poliomielitis" y "Plan Nacional de Mitigación de Poliomielitis".
c) Verificar el cumplimiento e implementación de las actividades relacionadas al Comité Nacional para la Contención de Poliovirus.
d) Verificar y recomendar el cumplimiento de los indicadores de inmunizaciones, vigilancia epidemiológica y laboratorio e informar dicha situación al Ministro de Salud, así como a la representación de la Organización Panamericana de la Salud en el país.

- **COMITÉ NACIONAL PARA LA CONTENCIÓN DE POLIOVIRUS** tiene, entre otras, las siguientes funciones:

a) Elaborar la propuesta del Plan Nacional para la Contención de Poliovirus.
b) Elaborar anualmente y presentar al /a la titular del Ministerio de Salud el informe de la contención de poliovirus, que luego se presentará el Comité Nacional de Certificación de la Erradicación de la Poliomielitis.
c) Mantener informado el Ministerio de Salud y al Comité Nacional de Certificación de la Erradicación de la Poliomielitis, sobre los avances de las actividades.

- El **COMITÉ CONSULTIVO DE INMUNIZACIONES, ADSCRITO AL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE SALUD PÚBLICA DEL MINISTERIO DE SALUD** tiene las siguientes funciones:

a) Emitir opinión sobre la adopción de políticas y acciones orientadas a la universalización de la inmunización preventiva.
b) Formular propuestas para lograr la coordinación entre actores de la salud pública orientadas a la universalización de la inmunización preventiva.
c) Recomendar la realización de acciones para potenciar la universalización de la inmunización preventiva.
d) Emitir opinión sobre los asuntos que el Comité de Expertos de la Dirección de Inmunizaciones pudiera someter a su consideración.

Así mismo el Comité Consultivo de Inmunizaciones, en función a sus necesidades y objetivos, puede convocar, en calidad de invitados, a profesionales e instituciones públicas y privadas y organismos de cooperación internacional que sean necesarios, para cumplir con las funciones señaladas anteriormente.

6.6.1.2 EQUIPOS DE TRABAJO:

Se reconoce como equipos de trabajo de la Dirección de Inmunizaciones, al Equipo Técnico Nacional y al Equipo Técnico Regional, según lo siguiente:

- **EQUIPO TÉCNICO NACIONAL:** se conforma desde el Despacho Viceministerial de Salud Pública para desarrollar acciones conjuntas para prevenir o minimizar problemas asociados al uso de las vacunas y otros inmunobiológicos y está integrado por representantes de las diferentes dependencias:

  - Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública (DGIESP).
  - Dirección de Inmunizaciones, quien ejerce la Secretaría Técnica.
  - Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES).
  - Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC).
  - Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI).
  - Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA).
  - Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID).
  - Instituto Nacional de Salud (INS).
  - Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM).
  - Dirección de Promoción de la Salud (DPROM).
  - Oficina General de Comunicaciones (OGC).
  - Dirección General de Operaciones en Salud (DGOS).
  - Dirección de Intervenciones por Curso de Vida y Cuidado Integral (DVICI).
  - Y otros órganos institucionales de considerarlo pertinente, previamente autorizados por la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública.
  - Oficina General de Administración (OGA).
  - Oficina General de Gestión de Recursos Humanos (OGGRH).

Sus actividades principales son:

a) Difusión y capacitación de la Norma Técnica de Salud que establece el Esquema Nacional de Inmunizaciones, así como la Norma Técnica de Salud para el Manejo de la Cadena de Frío en las Inmunizaciones y otros temas específicos de acuerdo a necesidad de cada dirección que interactúa para el trabajo en las inmunizaciones.
b) Implementar acciones de información, educación y comunicación, sobre actividades de vacunación, garantizando un escenario informado para las intervenciones en el público objetivo.
c) Promover la articulación multisectorial en favor de las inmunizaciones.
d) Realizar la vigilancia activa de los ESAVI en las actividades regulares y campañas de vacunación o en la incorporación de nuevas vacunas al esquema de vacunación nacional.
e) Garantizar un registro adecuado y control de calidad de la información.
f) Contar con reportes del sistema de información en tiempo real para un adecuado análisis y toma de decisiones.
g) Promover y/o desarrollar estudios de fármaco epidemiología necesarios para evaluar la seguridad de las vacunas.
h) Vigilar y monitorear las actividades relacionadas a la vacunación segura.
i) Participar activamente en coordinación con los otros componentes en las acciones de investigación, prevención, control y manejo de situaciones de crisis.
j) Brindar asistencia técnica para la investigación de los casos de ESAVI severo y fatal.
k) Realizar la supervigilancia y asistencia técnica para el adecuado manejo de los residuos sólidos generados en campañas sanitarias.
l) Evaluar y analizar los eventos sanitarios correspondientes a enfermedades inmunoprevenibles, participando y proponiendo actividades de apoyo en el control de brotes.
m) Formular mensajes nacionales estandarizados sobre seguridad, confianza, beneficios, y manejo de ESAVI.

- **EQUIPO TÉCNICO REGIONAL:** están conformados por comités técnicos operativos de cada DIRESA/GERESA/DIRIS/UE, los cuales son responsables de la elaboración del plan regional de inmunizaciones y de garantizar las actividades de inmunizaciones en el ámbito de la jurisdicción correspondiente.

El Equipo Técnico Regional debe conformarse por representantes de las siguientes direcciones u oficinas, o las que hagan sus veces:

- Dirección de Salud de las Personas.
- Dirección Ejecutiva de Salud Integral, o quien haga las veces según estructura, quien lo presidirá.
- Coordinador(a) de la Estrategia Regional Sanitaria de Inmunizaciones, quien ejercerá la Secretaría Técnica.
- Dirección de Estadística e Informática.
- Dirección de Epidemiología o Inteligencia Sanitaria.
- Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental.
- Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas.
- Dirección de Seguros.
- Dirección de Laboratorio.

- Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto.
- Dirección de Promoción de la Salud.
- Oficina de Comunicaciones.
- Oficinas, estrategias sanitarias y otras involucradas en aspectos de inmunización a nivel regional.

Sus actividades están orientadas a contribuir a una gestión adecuada en las inmunizaciones.

6.6.2 COMPONENTES DE PLANIFICACIÓN

6.6.2.1 MICROPLANIFICACION

Los establecimientos de salud de las DIRESA/GERESA/DIRIS aplican esta estrategia de planificación local, de manera detallada, para organizar y gestionar los recursos, de acuerdo a la realidad local, para alcanzar los objetivos y metas de las inmunizaciones.

Realizar el levantamiento de información "de abajo hacia arriba", que permita un análisis de la situación actual (recursos humanos, materiales y financieros), para la programación de acciones de vacunación para el seguimiento y evaluación de los objetivos con amplia participación de la comunidad, a través de la comunicación y movilización social. Ver Anexo 4.

6.6.2.2 PROGRAMACIÓN, PROVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE VACUNAS Y JERINGAS DEL ESQUEMA NACIONAL DE VACUNACIÓN

Nivel Nacional
La programación anual de vacunas y jeringas se realizará en base a los criterios de programación establecidos en el Anexo 17 de la presente norma.

Es responsabilidad del CENARES la compra de los inmunobiológicos y jeringas, la misma que responde a la programación anual y distribución de acuerdo a la programación trimestral de las regiones, desde el almacén nacional al almacén regional.

Nivel Regional
El responsable de la programación de vacunas y jeringas es el/la coordinadora(a) regional de inmunizaciones, esta actividad se ejecuta anualmente, un año antes, considerando los criterios de programación establecidos por la Dirección de Inmunizaciones, tomando como base el Padrón Nominal de niños < de 5 años, población INEI/RENIEC.

Las DIRESA/GERESA/DIRIS, Redes, deben garantizar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Distribución y Transporte en la distribución de las vacunas, jeringas e insumos de acuerdo a lo programado, hasta el nivel del punto de vacunación, con la finalidad de lograr el abastecimiento oportuno y suficiente en cada establecimiento de salud del ámbito de su jurisdicción.

Los Gobiernos Regionales, a través de la autoridad sanitaria regional, podrán celebrar convenios de cooperación mutua con organizaciones públicas o privadas a fin de incrementar las coberturas de vacunación,

garantizando la gratuidad en la entrega del servicio, la adecuada cadena de frío, la idoneidad del recurso humano e instalaciones, así como la entrega de la información, en los aplicativos informáticos HIS/MINSA y SIHCE DEL MINSA.

Nivel Local
Los(as) responsables de inmunizaciones de los establecimientos de salud de las REDES y Microrredes de las GERESA/DIRESA/DIRIS, y todas las instituciones establecidas en el ámbito de aplicación de la presente norma, son responsables de la elaboración de la programación y cumplimiento de metas de las actividades de vacunación en su ámbito jurisdiccional.

El (La) responsable de Cadena de Frío en coordinación con el (la) responsable de Inmunizaciones y DEMID, garantizan la distribución de vacunas, jeringas e insumos a los establecimientos de salud.

6.6.3 COMPONENTES DE CONTROL

6.6.3.1 MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN:

El monitoreo, supervisión y la evaluación cumplen un rol importante dentro de las inmunizaciones; permiten medir, analizar los avances, realizar los ajustes y correcciones necesarias, marcando las pautas para alcanzar resultados.

- **Monitoreo:** A través de reuniones virtuales o presencial, asistencias técnicas, socialización de informes de análisis del avance de coberturas, control de calidad de datos, análisis de indicadores del esquema y cadena de frío en inmunizaciones, análisis de movimientos de biológicos, de manera periódica, para toma de decisiones e implementación de acciones oportunas para el logro de los objetivos.

- **Supervisión:** Visita a los establecimientos de salud, para observar, evaluar, orientar y capacitar sobre las acciones de vacunación, con el fin de asegurar el cumplimiento de normas, evidenciados en los resultados de los indicadores de desempeño.

- **Evaluación**: Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las metas y el logro de los objetivos, se convoca a reuniones nacionales y macro regionales para la evaluación de los indicadores y realizar el plan de mejora, cuya medición se realizará con el denominador máximo de población del padrón nominal cerrado del año en curso.

- **Estos procesos se realizan periódicamente a nivel nacional, regional y local, de acuerdo a sus competencias y necesidades.**

6.6.4 COMPONENTE DE CONOCIMIENTO

6.6.4.1 CAPACITACIÓN

La capacitación y actualización en materia de inmunizaciones está a cargo de la DMUNI en el nivel nacional, y a nivel regional

capacita el Coordinador de inmunizaciones, debiendo realizar una capacitación como mínimo 40 horas académicas anualmente, bajo la modalidad presencial o de tele capacitación, involucrando a las diferentes instancias que conforman el equipo nacional y regional, con los siguientes contenidos mínimos:

- Esquema de vacunación, Definiciones Operacionales, Criterios de Programación, Presupuesto por categoría presupuestal y fuentes de financiamiento.
- Estrategias, Tácticas de vacunación.
- Administración de vacuna, Manejo de Cadena de frío.
- Inyección Segura, Manejo y Seguimiento de los Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación y/o Inmunización (ESAVI) y Manejo de Residuos sólidos.
- Manejo de situaciones de crisis en vacunación.
- Sistemas de información: Registros adecuados, reportes actualizados, control de calidad de datos.
- Cierre de brechas oportunas por cada tipo de vacuna.
- Análisis del uso de las vacunas, evaluación de la dosis no utilizada
- Análisis y evaluación de indicadores.
- Habilidades de consejería en vacunación y comunicación interpersonal.
- Manejo de dudas frecuentes, mitos, temores y resistencia.
- Comunicación empática en situaciones de rechazo o indecisión.

En los establecimientos de salud en forma permanente según necesidad local (rotaciones frecuentes del personal en el servicio de inmunizaciones, ingreso SERUMS, realización de campañas, jornadas de vacunación, cierre de brechas, barridos, entre otros), a cargo de la DIRESA, GERESA, DIRIS u otra instancia en el caso de otras instituciones.

6.6.4.2 INDICADORES

Para el monitoreo, supervisión y la evaluación se utilizarán los siguientes indicadores[1]:

a) Indicadores de Proceso

- Porcentaje de acceso, cobertura y deserción por tipo de vacuna trazadora: IPV, Pentavalente/Hexavalente, SPR1 y SPR2.

b) Indicadores de Resultado (Fuente ENDES)

- Porcentaje de menores de 12 meses con vacunas completas (indicador trazador).
- Porcentaje de menores de 15 meses con vacunas completas (indicador trazador).
- Porcentaje de menores de 36 meses con vacunas completas para su edad (indicador trazador).

[1] Ver más en la Ficha Técnica de Indicadores Anexo 17 de la presente NTS.

c) Indicador de Desempeño.

- Porcentaje de Recién Nacido con Vacuna BCG y Hepatitis B dentro de las 24 horas después del nacimiento.
- Niños y niñas de 24 meses que reciben vacunas para su edad
- Niñas y Niños menores de 12 meses de edad procedentes de los quintiles 1 y 2 de pobreza departamental que reciben el paquete integrado de servicios FED.
- Porcentaje de niñas y niños de 9 años de edad vacunados contra el Virus del Papiloma Humano (VPH).

d) Indicador de Impacto (a medirse en 5 años)

- Disminución de morbimortalidad por polio, sarampión y tosferina.

6.6.5 COMPONENTE DE LA INFORMACIÓN

La Oficina General de Tecnologías de la Información del MINSA es responsable de brindar el apoyo para la definición de precisiones técnicas en materia de diseño de la recopilación de datos de calidad, para su tratamiento de forma oportuna y, consolidar y sistematizar la información de inmunizaciones a nivel nacional, del ámbito público y privado. Dicha información sirve de base para que la Dirección de Inmunizaciones y el CDC, realicen el análisis, seguimiento y monitoreo de las actividades regulares y complementarias de vacunación a nivel nacional, regional y local.

El personal de salud que realiza la vacunación es responsable de registrar y/o codificar diariamente las dosis aplicadas de todas las vacunas del calendario de vacunación de acuerdo al Manual de Registro Diario de Atención y Otras Actividades de Salud HIS/MINSA, de la DMUNI, publicado por la OGTI y de remitir oportunamente, de acuerdo a las fechas establecidas en cada nivel administrativo, el formato A y/o los registros HIS a los puntos de procesamiento.

Con la Resolución Ministerial N° 780-2015/MINSA y la Resolución Ministerial N° 553-2025/MINSA, se dispone el uso del aplicativo informático HIS MINSA y del sistema de información de historias clínicas electrónicas SIHCE del MINSA para el primer nivel de atención, respectivamente, como instrumentos de registro de información de las actividades asistenciales relacionadas con las prestaciones en salud en los EE.SS. de las GERESA, DIRESA y DIRIS o las que hagan sus veces.

Los establecimientos de salud de los sub sectores diferentes al MINSA, como EsSalud, Sanidad de la PNP e instituciones privadas, o las que hagan sus veces, deben reportar las dosis aplicadas de vacunados en la trama de datos estándar de acuerdo a los criterios técnicos de codificación, seguridad e infraestructura establecidos por la Oficina General de Tecnologías de la Información del MINSA.

Los establecimientos de salud son responsables del tratamiento de los datos personales de las personas que vacunan, debiendo cumplir con las medidas

legales, organizativas y técnicas necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales y garantizar la confidencialidad de la información que resguardan, conforme a las disposiciones de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y en su norma Reglamentaria. Las GERESA, DIRESA y DIRIS son responsables de supervisar activamente que los establecimientos de salud del ámbito de su jurisdicción den cumplimiento a estas disposiciones.

El Padrón Nominal es la nómina de la población menor de seis (6) años de edad con residencia habitual en el territorio nacional, registrada en una plataforma electrónica de alcance nacional. Tiene por finalidad identificar y mantener actualizada la información individualizada, a fin de garantizar su acceso oportuno a los servicios de identidad, salud, nutrición, educación y otros sobre protección social.

La OGTI brindará la información del padrón nominal hasta el cumplimiento de lo dispuesto en la Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N°1702, Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N°1612, Decreto Legislativo que fortalece el Sistema Nacional de Focalización mediante la creación del Organismo Técnico Especializado denominado Organismo de Focalización e Información Social (OFIS) y dicta otras medidas complementarias, a fin de incorporar el padrón nominal de la población menor de seis años como instrumento del OFIS y determinar el alcance del rol de los gobiernos locales y del OFIS para el seguimiento nominal a la primera infancia, desde la gestación y con miras a un seguimiento longitudinal.

Asimismo, el "Padrón Nominal distrital de niñas y niños menores de seis (06) años de edad" se utiliza para el cálculo de: productos (biológicos), estimaciones de población, indicadores, coberturas de intervención estratégicas en salud pública, así como la programación, seguimiento, monitoreo y evaluación de las metas físicas de los programas presupuestales en salud de la DGIESP.

El tratamiento de datos personales, con especial énfasis en la información de salud, se rige por los criterios de minimización de datos y de privacidad desde el diseño y por defecto. Para ello, se prioriza la aplicación de procedimientos de disociación y anonimización.

El personal de salud de los establecimientos de las GERESA, DIRESA y DIRIS en coordinación y mediante un trabajo articulado con el gobierno local (municipio), son los encargados de la actualización del padrón nominal.

El personal de los establecimientos de salud que intervenga en el tratamiento de los datos personales de las personas vacunadas está obligado a guardar confidencialidad sobre dicha información y sus antecedentes. Esta obligación se mantiene incluso después de finalizada la relación laboral o contractual con el establecimiento de salud.

Los establecimientos de salud, las GERESA, DIRESA y DIRIS cumplen con las medidas de seguridad que disponga el MINSA para el registro de la información de las personas vacunadas en el sistema oficial que disponga el MINSA para ello.

El personal de salud autorizado de los establecimientos de salud, acceden mediante consulta al historial de vacunación disponible de la persona a vacunar en los sistemas oficiales del MINSA, independientemente de su jurisdicción de atención.

La DIGEMID, a través del aplicativo SISMED, es responsable de establecer los criterios de registro, recabar los datos en forma oportuna y de calidad, consolidar y sistematizar la información sobre el suministro de vacunas y jeringas del MINSA a nivel nacional, a fin de garantizar la trazabilidad del producto que se inicia con el correcto registro de ingreso en todos los niveles de gestión hasta el retorno oportuno de la información generada por la administración de la vacuna como consumo, la cual es registrada mensualmente a través del ICI - SISMED.

El IGA es una herramienta práctica para el manejo del inventario de equipos de cadena de frío en inmunizaciones, para las necesidades de cada país, permitiendo mejorar el rendimiento, evitar riesgos legales, facilitando la planificación estratégica, el análisis de brechas entre el desempeño real y el esperado; además del plan de reposición de equipos. Esta herramienta permite realizar:

- Análisis de las deficiencias en la capacidad de la cadena de frío en inmunización.
- Segmentación de las instalaciones.
- Exportación de la base de datos completa o parcial para su posterior análisis.
- Generación de un código QR que permite a los usuarios acceder rápidamente a la información más reciente sobre los equipos.

Las instituciones de EsSalud, de las Sanidades de las FF.AA., PNP y del sector privado, que realicen actividades de vacunación, ya sea con biológicos de adquisición propia o provistos por el Estado, están obligadas a registrar y notificar la información de las dosis administradas de manera diaria, oportuna y obligatoria. Dicho registro se efectuará a través de los sistemas oficiales vigentes (HIS-MINSA, SIHCE del MINSA y otros que defina el MINSA) o mediante los mecanismos de interoperabilidad (servicios de integración o envío de tramas) establecidos por la Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI) del Ministerio de Salud. Para tal fin, se coordina la gestión de accesos y el flujo de datos con la DIRIS, DIRESA, GERESA o MINSA, según corresponda.

De acuerdo con el ámbito del desarrollo de las actividades de inmunizaciones, se establecen las siguientes consideraciones:

a) Nivel Nacional.

La Oficina General de Tecnologías de la Información del MINSA:

- Genera los reportes de vacunación consolidados por regiones de acuerdo a los indicadores según niveles y periodos establecidos en coordinación con la Dirección de Inmunizaciones, lo cual contribuye para el análisis y toma de decisiones.
- Elabora los tableros de información de vacunación de campañas, indicadores de convenios e información estadística y los difunde periódicamente de acuerdo a necesidad y en coordinación con la

Dirección de Inmunizaciones que es la responsable de establecer los requerimientos de su elaboración.

- Publica los tableros de información a través de la plataforma web "REUNIS", el cual muestra el avance de coberturas de vacunación en el menor y mayor de 5 años, a partir de las metas de vacunación determinadas por la DMUNI para a las poblaciones de menores y mayores de 5 años. (Fuentes oficiales: Padrón nominal para el menor de 5 años y población INEI/RENIEC para mayores de 5 años).
- Publica el carnet digital del Ministerio de Salud del Perú (MINSA) que es una herramienta virtual que permite a los ciudadanos consultar, descargar y validar su historial oficial de vacunación de manera rápida y segura a través de internet. Este sistema forma parte del proceso de transformación digital del sector salud y está integrado a la plataforma oficial [Minsa Digital] (https://minsadigital.minsa.gob.pe/?utm_source=chatgpt.com), donde los usuarios pueden acceder utilizando su DNI o carné de extranjería y una contraseña personal.
- Establece los criterios de control de calidad de los datos de la vacunación, de acuerdo a los manuales vigentes y los difunde periódicamente de acuerdo a necesidad, notifica a la DIRESA/GERESA/DIRIS sobre los hallazgos de errores de registro.
- Pone a disposición de la DMUNI y las DIRESA/GERESA/DIRIS el reporte por edad puntual del "Padrón Nominal distrital de niñas y niños menores de seis (06) años de edad" actualizado según la periodicidad que establezca el OFIS.

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas establece las fechas de envío de la información mensual del ICI de las regiones.

b) Nivel Regional. La oficina de estadística e informática o la que haga sus veces:

- Consolida la información de los establecimientos MINSA a través de HIS MINSA y para el caso de los establecimientos de salud de otros sub sectores diferentes al MINSA que no utilicen el sistema oficial, se remiten las dosis aplicadas de vacunados en la estructura de datos y según los plazos establecidos por la oficina de estadística e informática.
- La oficina de estadística e informática o la que haga sus veces proporciona el reporte de los vacunados a nivel de distritos, redes de salud, unidad ejecutora y establecimientos de salud o segmentado de acuerdo a sus criterios de análisis en el avance de la vacunación; dicha información nuestra coberturas por tipos de vacuna, grupos de edad, subsector desde el nivel de establecimiento hasta nivel regional de acuerdo a periodos establecidos según necesidad; esta información consolidada es remitida a la ESRI para el análisis y toma de decisiones.
- La oficina de estadística e informática o la que haga sus veces en coordinación con los responsables de todas las estrategias involucradas en la Atención Integral del Niño/Niña de las DIRESA/GERESA/DIRIS realizan el monitoreo y control de calidad del registro y el procesamiento de las actividades de vacunación en el aplicativo informático oficial (SIHCE del MINSA o HIS/MINSA), además verifican la actualización constante del "Padrón Nominal de niñas y niños menores de seis (06) años" en todos los niveles

administrativos (Redes de Salud, establecimientos de salud) según corresponda.

- Las DIRESA/GERESA//DIRIS o quien haga sus veces en las unidades ejecutoras y establecimientos de salud, son responsables de garantizar la consolidación de la información del ICI - SISMED en el ámbito de su jurisdicción, para su envío al portal web del SISMED de acuerdo a lo estipulado en el numeral 6.7.8 de la Directiva Administrativa N° 249-MINSA/2018/DIGEMID.

c) Nivel Local.

- Para el caso del reporte ICI, es responsabilidad de farmacia en coordinación con el servicio de inmunizaciones reportar el stock y consumo de vacunas y jeringas, de acuerdo a los plazos establecidos por la dirección de medicamentos de su jurisdicción para su envío oportuno. El establecimiento de salud que tenga acceso a internet, propio o en su ámbito geográfico, remite diariamente; caso contrario, la envía mensualmente.
- El personal de la salud que realiza la vacunación es responsable de registrar todas las vacunas del calendario de vacunación, de acuerdo al Manual de Registro Diario de Atención y Otras Actividades de Salud HIS de la DMUNI, publicado por la OGTI del MINSA.
- Es responsabilidad del personal asistencial realizar el control de calidad de la información que registró en el sistema oficial en coordinación con el responsable de estadística o quien haga sus veces.
- El personal de la salud entrega el carné de Atención Integral del Niño y la Niña menor de 5 años en el cual está incorporado el esquema nacional de inmunizaciones donde se registra y acredita las vacunas administradas.
- Cada establecimiento de salud aplica instrumentos de captación, seguimiento y monitoreo con la finalidad de garantizar el cumplimiento del Esquema Nacional de Inmunizaciones.
- Para el registro de la vacunación con los diferentes biológicos, tener en cuenta el código CPMS para el sistema de información HIS/MINSA y SIHCE del MINSA según detalle:

Tabla: Relación de vacunas según código CPMS

	cod_CPMS	descripción de vacuna
Esquema Regular	**90585**	Vacuna Antituberculosa (BCG)
Esquema Regular	**90744**	Vacuna Antihepatitis Viral B (HVB) Pediátrico
Esquema Regular	**90746**	Vacuna Antihepatitis Viral B (HVB) Adulto
Esquema Regular	**90713**	Vacuna Antipoliomielítica (IPV)
Esquema Regular	**90712**	Vacuna Antipoliomielítica (APO)
Esquema Regular	**90722**	VACUNA DPT-HVB-HIB
Esquema Regular	**90702**	Vacuna Diftotetanica Pediátrico (dT)

Esquema Regular	**90714**	Vacuna Diftotetanica Adulto (dT)
Esquema Regular	**90648**	Vacuna contra Haemophilus Influenza B (HiB)
Esquema Regular	**90681**	Vacuna contra Rotavirus
Esquema Regular	**90670**	Vacuna Antineumocócica 13V
Esquema Regular	**90657**	Vacuna contra la Influenza Pediátrico (Trivalente)
Esquema Regular	**90658**	Vacuna contra la Influenza Adulto (Trivalente)
Esquema Regular	**90687**	Vacuna contra la Influenza Pediátrico (Cuadrivalente)
Esquema Regular	**90688**	Vacuna contra la Influenza Adulto (Cuadrivalente)
Esquema Regular	**90707**	Vacuna Anti sarampión Paperas y Rubeola (SPR)
Esquema Regular	**90708**	Vacuna Anti sarampión y Rubeola (SR)
Esquema Regular	**90716**	Vacuna Anti varicela, uso subcutáneo
Esquema Regular	**90717**	Vacuna Antiamarílica (AMA)
Esquema Regular	**90633.01**	Vacuna contra Hepatitis A (HAV)
Esquema Regular	**90701**	Vacuna anti Ditteria, Pertusis y Tétanos (DPT)
Esquema Regular	**90649**	Vacuna contra el Virus Papiloma Humano (VPH-4V)
Esquema Regular	**90715**	Vacuna para tétanos, toxoide diftérico (TDAP)
Otros esquemas	**90749.01**	Vacuna contra Covid Adulto
Otros esquemas	**90749.02**	Vacuna contra Covid Pediátrico 5 - 11 años.
Otros esquemas	**90749.03**	Vacuna contra Covid Pediátrico 6m - 4 años 11m29d.
Otros esquemas	**90749.04**	Vacuna contra la Viruela del Mono
Otros esquemas	**90749.05**	Vacuna contra el Dengue
Nuevas vacunas	**90749.06**	Vacuna Hexavalente (DPT-HVB-HIB-IPV)
Nuevas vacunas	**90651**	Vacuna Contra el Virus Papiloma Humano (VPH-9V) Esquema 2 o 3 Dosis
Nuevas vacunas	**90651.01**	Vacuna Contra el Virus Papiloma Humano (VPH-9V) Esquema 1 Dosis
Nuevas vacunas	**90677**	Vacuna Antineumocócica Conjugada 20V
Nuevas vacunas	**90678**	Vacuna Contra El Virus Respiratorio Sincitial (VRS)

MINISTERIO DE SALUD Dirección de Inmunizaciones C. VILA

MINISTERIO DE SALUD Dirección de Inmunizaciones Lic. Liliana Karleny Chaires Aponte V°B° Dirección Ejecutiva Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública

Nuevas vacunas	**90734**	Vacuna Conjugada Contra Meningocócica, Serogrupo A, C, W, Y
Nuevas vacunas	**90378**	Anticuerpo Monoclonal, Recombinante, Virus Respiratorio Sincitial
Nuevas vacunas		Vacuna Hexavalente acelular (DaPT-HVB-HIB-IPV)

6.6.6 COMPONENTE DE FINANCIAMIENTO

En el marco de la descentralización, el nivel nacional solo garantiza el financiamiento de la compra de las vacunas y jeringas, así como su distribución desde los almacenes del nivel nacional al nivel regional.

Los Gobiernos Regionales, GERESA, DIRESA, Redes Integradas de Salud con sus UE, tienen la responsabilidad de asegurar el presupuesto para garantizar la operatividad de las actividades de vacunación (insumos médicos, material de limpieza, materiales de bioseguridad para la eliminación de los residuos sólidos, distribución y traslado de vacunas, materiales de escritorio, pago de movilidad local y viáticos para el personal que realiza seguimiento de vacunas, contrato de personal y otros) a los EE.SS. a través de los Programas Presupuestales (PPORDIT: Niños y niñas con Vacuna Completa), Salud Materno Neonatal (Atención Prenatal reenfocada; Vacunación a la gestante), Prevención y Control del Cáncer (Vacunación a niñas con VPH), y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Producto (APNOP) y otras fuentes de financiamiento para vacunación en población mayor de 5 años, así como acciones de Promoción y otras acciones involucradas en inmunizaciones.

6.7. FACTOR PÉRDIDA DE FRASCOS MULTIDOSIS/DOSIS NO UTILIZADAS

El factor pérdida o también conocido como dosis no utilizadas, son aquellas dosis de los frascos abiertos y cerrados que durante el proceso de vacunación por diversas situaciones quedan sin utilizar.

Para el cálculo del factor pérdida de dosis o dosis no utilizada de las vacunas a nivel nacional y de manera individual por punto de vacunación, es necesario tener en cuenta que se relacionan con frascos de vacuna multidosis, por lo que considera los elementos externos e internos teniendo el detalle:

- Las características geográficas (urbana y rural), demográficas, climatológicas, culturales, sociales y económicas en todo el territorio nacional, que dificultarían el despliegue de las brigadas de vacunación a las viviendas.
- Oportunidad de la vacunación, donde se prevalece el derecho a la vida y protección de las personas.
- Tiempo de desplazamiento de las brigadas móviles hacia los establecimientos y/o comunidades.
- Demanda y afluencia de la población en los puntos de vacunación.
- Tiempo de vida útil de las vacunas multidosis, una vez abierto el frasco por exposición y bioseguridad del insumo.
- Las vacunas liofilizadas tienen duración de 6 horas de vida útil luego de abierto el frasco.
- Falta de personas en el punto de vacunación para la apertura del frasco multidosis por la asistencia de 1 persona.

- En actividades intramurales, extramurales, jornadas, campañas de vacunación, entre otras diversas actividades de vacunación.
- Dosis no utilizadas aplicadas durante el periodo de desarrollo de estrategias específicas (cierre de brechas, campañas, etc.).
- Cantidad de dosis por frasco de vacuna multidosis.
- Eventos accidentales como robo en los puntos de vacunación (se tienen elementos que respalden las actividades de vacunación y planificación que realizaron antes del suceso).
- Entre otras situaciones que son informadas a su jefe inmediato.

A razón de todas las situaciones mencionadas se determina lo siguiente:

6.7.1 Pérdida de vacunas en frascos cerrados

Se prevé las pérdidas de dosis de vacuna que suceden antes de abrir el frasco para su aplicación o uso, que pueden ocurrir en los siguientes casos:

- Expiración de la fecha límite de caducidad informada por el fabricante.
- Ruptura de cadena de frío (alteración de temperaturas por congelamiento o aumento de temperatura).
- Rupturas accidentales.
- Error de registro del inventario.
- Sustracciones o faltantes.

6.7.2 Pérdida de vacunas en frascos abiertos

Son aquellas pérdidas que suceden después de abrir el frasco para su aplicación o uso, pueden ocurrir en los siguientes casos:

- Errores en las prácticas de reconstitución.
- Frascos abiertos sumergidos en agua.
- Sospecha de contaminación.
- Mala aplicación o desconocimiento de la política sobre frascos de dosis múltiple.
- Descarte de dosis sobrante al finalizar el tiempo de vida útil.
- Descarte de dosis cuando se salen a actividades extramurales, con apertura o sin apertura de frascos de vacuna por exposición de insumo.
- Descarte de dosis cuando se evidencia oportunidad de vacunación, que genera la apertura de 1 frasco por una sola persona a vacunar.
- En las vacunas orales, las dosis devueltas (arrojadas) por los niños y niñas vacunadas.

6.7.3 REGISTRO Y CONTROL "DE LA PÉRDIDA DE DOSIS/DOSIS NO UTILIZADAS" DE VACUNAS MULTIDOSIS

Para el control existente de los desperdicios en cada establecimiento de salud, se cumplen con estrategias para el control de desperdicios o pérdidas de vacunas monodosis o multidosis como parte de las actividades primordiales de la gestión de las inmunizaciones en el país.

En los puntos de vacunación, el personal de salud encargado de las inmunizaciones realiza lo siguiente:

- Registro diario de las pérdidas de vacunas en el formato de actas de cierre de vacunas.

- Generar un reporte mensual de factor pérdida por cada una de las vacunas en el que se consignan datos del personal responsable de inmunizaciones en base a los reportes recibidos de las brigadas de vacunación, los datos mínimos a registrar son:

  - Datos de ubicación del punto de vacunación:
  - Nombre del punto de vacunación:
  - N° de lote de la vacuna:
  - Total, de dosis aplicadas por vacunas:
  - Dosis pérdida en frascos abiertos:
    Observaciones

- Previa a la eliminación definitiva de los frascos con dosis desperdiciada o vencida, el personal responsable de inmunizaciones remite obligatoriamente el reporte de factor pérdida y las actas de incidencia a la Jefatura de Farmacia o quien haga sus veces en el establecimiento de salud. El director de Medicamentos o jefe de Farmacia según corresponda, es el responsable de conciliar dicha información e ingresarla en el Informe de Consumo Integrado (ICI) para mantener la concordancia exigida con el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), tramitando las bajas patrimoniales conforme a la normativa del SISMED.

6.8. MANEJO DE RIESGOS EN LAS VACUNAS

6.8.1 SEGURIDAD DE VACUNAS Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LOS EVENTOS SUPUESTAMENTE ATRIBUIDOS A LA VACUNACIÓN O INMUNIZACIÓN (ESAVI)

En la actualidad, las vacunas son más seguras que hace 40 años, su fabricación, control y reglamentación, exigen conocimientos y procedimientos especiales considerando que por lo general son administradas en personas sanas y primordialmente a la población infantil, observándose comúnmente manifestaciones clínicas leves y transitorias y en muy raras veces cuadros graves.

Los síntomas, signos o resultados anormales de laboratorio de enfermedades coexistentes pueden conllevar a confusión con reacciones post vacunales generando dudas de su seguridad y hasta en ocasiones llevando a la crisis con la interrupción de campañas. Los eventos severos ameritan de una atención preferente en los establecimientos de salud cuyo manejo es de acuerdo a la impresión diagnóstica, se comunica a epidemiología para su notificación inmediata, según lo establecido en la Directiva Sanitaria N° 054-MINSA/DGE-V.01 "Directiva Sanitaria para la vigilancia epidemiológica de eventos supuestamente atribuidos a la vacunación o inmunización (ESAVI)", estando a cargo del CDC - MINSA.

Durante campañas masivas de vacunación o incorporación de nuevas vacunas al Esquema Nacional, se activa el sistema de vigilancia de ESAVI, vigilancia intensificada consistente en el reporte diario de presencia o ausencia de caso ESAVI por los establecimientos de salud al CDC-MINSA, a través del aplicativo informático creado para este fin. Los cuadros severos ameritan investigación individual minuciosa según la normativa, realizando el llenado inicial de la Ficha de Investigación Clínico Epidemiológica de ESAVI severo, mientras que los conglomerados no graves también son

investigados; tanto la notificación como los flujos de información siguen las pautas establecidas en la normatividad vigente y lineamientos proporcionados por el CDC-MINSA.

En caso de ESAVI no severo, leve y moderado se registrará en el Formato de Notificación de Eventos Supuestamente atribuidos a la vacunación e inmunización (ESAVI) aprobado por DIGEMID con R.D. N° 001-2021-DIGEMID-DG-MINSA o la que haga sus veces. Ver Anexo 13.

Se ha establecido el "Grupo de trabajo para la vigilancia de ESAVI" conformado por CDC-MINSA, DIGEMID y la Dirección de Inmunizaciones para fortalecer la vigilancia de los ESAVI.

6.8.2 ERRORES PROGRAMÁTICOS

Los establecimientos de salud reportan estos eventos al inmediato superior a través del formato de reporte de errores programáticos descrito en el Anexo N° 13, quienes a su vez consolidan y remiten dicha información a la Dirección de Inmunizaciones de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública.

6.9. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

GESTIÓN Y MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS, DURANTE EL PROCESO DE LA VACUNACIÓN.

La gestión y manejo de residuos sólidos se realizará según lo establecido en la NTS N° 144-MINSA/2018/DIGESA, Norma Técnica de Salud: "Gestión Integral y Manejo de Residuos Sólidos de Establecimientos de Salud, Servicios Médicos de Apoyo y Centros de Investigación", aprobada por Resolución Ministerial N° 1295-2018/MINSA o la que haga sus veces.

6.10. ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD

Las intervenciones de promoción de la salud en el país, se orientan a brindar a las comunidades, los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma, a través de:

6.10.1. La articulación intergubernamental (Gobiernos Locales y Regionales) e intersectorial.

INCIDENCIA Y ABOGACÍA EN SALUD: Influir en los tomadores de decisiones (autoridades), con la finalidad de causar un efecto positivo en su comunidad, con el objetivo de que se emitan políticas, directivas, normas y se desarrollen actividades en beneficio de la salud de su población, además de incorporar en su agenda acciones dirigidas a promover prácticas y entornos saludables para promover la salud infantil incluyendo las inmunizaciones y considerando, además, la articulación con los Comités distritales de salud u otros, para conocer la situación de salud local, con énfasis en las acciones de promoción de las inmunizaciones, así como en la orientación para la elaboración del plan multisectorial local en el marco de la gestión territorial en salud fortaleciendo el compromiso político y financiero.

6.10.2. La participación comunitaria.

Promueve la toma de decisiones y acción de la comunidad de acuerdo con sus necesidades e intereses en salud, fomentando el empoderamiento de la comunidad para el autocuidado de la salud a través:

SECTORIZACIÓN DE LA COMUNIDAD: Es usada por los establecimientos de salud y coincide con la sectorización utilizada por los municipios para que pueda existir una mejor articulación de acciones.

MAPEO DE INSTITUCIONES Y LÍDERES COMUNITARIOS (incluye ACS): El establecimiento de salud identifica las instituciones (universidades, centros juveniles y otros), líderes, lideresas de la comunidad, a fin de vincularlos a las intervenciones en salud.

TALLERES DE CAPACITACIÓN A LÍDERES COMUNITARIOS: posterior al mapeo en comunidad, se procede a organizar la capacitación en salud infantil incluyendo las inmunizaciones.

Otras acciones: El personal de salud de la jurisdicción organiza, conduce, realiza el seguimiento, acompañamiento y evaluación de las intervenciones realizadas por los líderes comunitarios, así como de las referencias comunitarias generadas.

6.10.3. La educación para la salud.

El personal de salud de los establecimientos de salud informa, orienta y educa a la población sobre:

- Consejería, a través de visita domiciliaria, en cuidados durante la gestación (vacunación Tdap).
- Consejería, a través de visita domiciliaria, en cuidado integral con énfasis en inmunizaciones.
- Consejería, a través de visita domiciliaria, en salud sexual y reproductiva (vacunación contra el VPH)

VII. RESPONSABILIDADES

La vacunación es responsabilidad de todos los establecimientos de salud públicos (Ministerio de Salud, Seguro Social de Salud – EsSalud, Sanidades de las Fuerzas Armadas, Sanidad de la Policía Nacional del Perú, Gobiernos Regionales, entre otros) y privados del Sector Salud, que realicen actividades de vacunación.

7.1 Nivel Nacional

El Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública y la Dirección de Inmunizaciones (DMUNI), es responsable de difundir la presente Norma Técnica de Salud, hasta el nivel regional, así como de brindar asistencia técnica, supervisar y evaluar su cumplimiento, en coordinación con todas las instituciones establecidas en el ámbito de aplicación de la presente norma.

7.2 Nivel Regional

La DIRESA/ GERESA/ DIRIS son responsables de difundir, brindar asistencia técnica, implementar y hacer cumplir lo establecido en la presente Norma

Técnica de Salud en su respectivo ámbito o jurisdicción, así como monitorear, supervisar y evaluar su cumplimiento.

7.3 Nivel Local

Las Unidades Ejecutoras, Redes de Salud, Redes Integradas de Salud y establecimientos de salud públicos (Ministerio de Salud, EsSalud, Sanidades de las Fuerzas Armadas, Sanidad de la Policía Nacional del Perú, Gobiernos Regionales, INPE, entre otros) y privados con actividades de vacunación, son responsables de aplicar y cumplir la Norma Técnica de Salud e informar de lo ejecutado al nivel inmediato superior.

VIII. DISPOSICIONES FINALES (SITUACIONES ESPECIALES)

8.1 Vacunación Frente a enfermedades emergentes

En situaciones especiales generadas por la presencia de agentes patógenos que causan enfermedades emergentes o reemergentes provocando epidemias, pandemias u otras situaciones epidemiológicas no previstas, lo que puede incrementar el riesgo para la vida y salud de la población; y en las que amerita el uso de nuevas vacunas diferentes al esquema regular de vacunación y su posible implementación será de acuerdo al escenario epidemiológico del momento, y solamente puede ser dispuesto por la Autoridad Nacional de Salud. Para tal efecto se formularán planes o directivas específicas de acuerdo con las evidencias científicas y recomendaciones por expertos en la materia

Así mismo, es necesario considerar el escenario epidemiológico que declare o señale el Ministerio de Salud para elaborar la intervención a través de planes, directivas, guías técnicas, lineamientos, entre otros, a fin de salvaguardar la salud pública en el País. **Para COVID-19, Viruela del Mono (MPOX), Dengue, Antirrábica Humana, el manejo es de acuerdo a sus documentos normativos vigentes.**

IX. ANEXOS

ANEXO 1	Administración simultánea de vacunas.
ANEXO 2	Esquemas de vacunación con dosis de rescate.
ANEXO 3	Política de frascos abiertos multidosis para vacunas precalificadas por OMS.
ANEXO 4	Aspectos técnicos para el desarrollo de la microplanificación.
ANEXO 5	Aspectos técnicos a tener en cuenta en la vacunación en el establecimiento de salud y en la comunidad.
ANEXO 6	Vías y técnicas de administración de las vacunas.
ANEXO 7	Tasa de ESAVI leves atribuidos a la vacunación o inmunización.
ANEXO 8	Tasa de ESAVI severos atribuidos a la vacunación y tiempo de aparición.
ANEXO 9	Errores operativos del programa y su consecuencia.
ANEXO 10	Registro Diario de Vacunación Unificado.
ANEXO 11	Registro Diario de Vacunación durante Bloqueo Vacunal.
ANEXO 12	Consolidado de Vacunación durante Bloqueo Vacunal.
ANEXO 13	Formato de Notificación de ESAVI.
ANEXO 14	Ficha de Notificación de Error Programático Relacionado a la Vacunación.
ANEXO 15	Requisitos para un vacunatorio adecuado de Inmunizaciones.

ANEXO 16	Indicadores de Inmunizaciones.
ANEXO 17	Criterios de Programación.
ANEXO 18	Carné de Atención Integral de Salud de la Niña y el Niño.
ANEXO 19	Carné de Vacunación en Personas mayores de 5 años.
ANEXO 20	Programación de Inmunizaciones en Programas Presupuestales y APNOP.
ANEXO 21	KIT de insumos críticos y gastos operativos para asegurar las intervenciones de vacunación.

ANEXO 1
ADMINISTRACIÓN SIMULTÁNEA DE VACUNAS

No existe contraindicación para la administración simultánea de múltiples vacunas rutinariamente recomendadas en personas de cualquier grupo de edad. No altera la producción de anticuerpos, ni aumentan las reacciones post - vacunales.

Ventajas:

- Protección de las niñas y niños: Vacunarlos cuanto antes los protege durante los primeros meses de vida, edad en la que son más vulnerables, debido a que las 6 a 8 semanas de vida pierden los anticuerpos maternos transferidos por la placenta, para la mayoría de las EPV y otras al año de edad como el sarampión. A menudo, las enfermedades son más graves en los lactantes.
- Menos visitas de vacunación: Permite a los padres o cuidadores economicen su tiempo y su dinero, al no necesitar ir repetidas veces al centro de salud, evitando a la vez exposición a personas con problemas de salud, además de protegerlos de varias enfermedades simultáneamente.
- Recibe las vacunas que necesita en el momento adecuado para no exponerlo al riesgo de contraer enfermedades potencialmente mortales.
- Mayor eficiencia: Los proveedores de atención sanitaria pueden prestar más eficientemente sus servicios y brindar otros servicios de salud si se reduce el tiempo que dedican a aplicar vacunas.

INTERVALOS DE TIEMPO ENTRE LA APLICACIÓN DE DIFERENTES VACUNAS SEGÚN TIPO DE ANTÍGENOS:

TIPOS DE ANTÍGENOS	VACUNAS	INTERVALO ENTRE DOSIS	OBSERVACIONES	PRECAUCIONES
Dos o más antígenos Vivos atenuados (parenterales)	- SPR - SR - AMA - Varicela	Mínimo con intervalo de 1 mes en caso NO se pudo administrar simultáneamente	Administrar considerando una separación mínima de 2.5 cm entre los sitios de inyección.	Si se administraron 2 vacunas vivas parenterales con un intervalo menor de 1 mes, la 2da. Vacuna administrada NO se considera válida y debe repetirse 1 mes después de la última dosis que anuló.
Dos o más antígenos inactivados	- Pentavalente - Hexavalente - IPV - Neumococo - DPT - Hib - HvB - Influenza - dT - HVA - DT	Administrar con cualquier intervalo entre dosis	Administrar considerando una separación mínima de 2.5 cm entre los sitios de inyección.	Diferenciar la zona de administración de las vacunas, específicamente Pentavalente, que se aplicará en el muslo opuesto a las otras vacunas.

Nota: En ambos casos lo ideal sería vacunar simultáneamente. Si no es posible cumplir con las vacunas vivas atenuadas, el intervalo mínimo es de 1 mes.

Administración de Anticuerpos Monoclonales Inmunizantes. Se puede administrar de forma concomitante con vacunas de la infancia.

ANEXO 2
ESQUEMAS DE VACUNACIÓN CON DOSIS DE RESCATE

En caso de interrupción del esquema de vacunación en niños y niñas, adolescentes, adultos o adultos mayores, se continuará con las dosis faltantes sin considerar el tiempo transcurrido desde la última dosis. **No es necesario reiniciar el esquema en ninguna circunstancia.**

La vacunación deberá iniciar, continuar o concluir el esquema según las siguientes precisiones:

VACUNA	PRECISIONES
BCG	Si no recibe la vacuna, administrar la dosis correspondiente lo antes posible durante el primer año de vida hasta los 11meses 29 días. Después de un 1 año hasta los 4 años 11 meses 29 días, previo descarte de infección por tuberculosis (PPD).
HvB	Si no se administró en las primeras 12 o 24 horas de nacido, podrá recibir hasta 7 días en casos excepcionales. (Partos domiciliarios). Para mayores de 4 meses hasta los 19 años deben recibir vacuna HvB pediátrica y a partir de los 20 años HvB adulto según esquema para aquellos que no completaron sus dosis y/o no vacunados.
PENTAVALENTE	Inicia desde la captación y se administra según esquema, hasta los 6 años 11 meses 29 días. En caso excepcionales con un intervalo mínimo de 4 semanas. **Mientras esté disponible.**
HEXAVALENTE	Inicia desde la captación y se administra según esquema, hasta los 6 años 11 meses 29 días. En caso excepcionales con un intervalo mínimo de 4 semanas.
IPV	Inicia desde la captación y se administra según esquema, hasta los 6 años 11 meses 29 días. En caso excepcionales con un intervalo mínimo de 4 semanas. **Mientras esté disponible.** • En casos especiales se puede colocar en todas las edades.
APO	Se aplica hasta los 4 años 11 meses 29 días.
ROTAVIRUS	Inicia desde la captación hasta los 8 meses 0 días.
NEUMOCOCO	Inicia desde la captación: • En menor de 1 año se colocará 2 dosis según esquema, en casos excepcionales a intervalo mínima de 4 semanas. • Niños y niñas de 1 a 2 años, sin ninguna dosis, se aplicará dos dosis. • Niños y niñas de 3 a 4 años sin una dosis se aplicará una dosis. • En población de 5 a 59 años (con comorbilidad), se aplicará una dosis única.
SPR	Se colocará la primera dosis a la captación y la segunda con un intervalo de 6 meses según esquema, hasta los 4 años 11 meses 29 días. En caso excepcionales con un intervalo mínimo de 4 semanas.
DPT	Se colocará la 1ra dosis de refuerzo a la captación y el 2do refuerzo con un intervalo de 6 meses. La captación será hasta los 6 años 11 meses 29 días. **En 2027 el 1er refuerzo será remplazado con Hexavalente**
HvA	Se inicia a la captación y se administra hasta los 4 años 11 meses 29 días.
FIEBRE AMARILLA	A la captación en dosis única, desde los 15 meses hasta los 59 años 11 meses 29 días. Población que vive en regiones endémicas y expulsoras: Se dará pautas especiales en caso de brote de riesgo epidemiológico.
Varicela	Se colocará la primera dosis a la captación y la segunda con un intervalo de 12 meses según esquema, hasta los 4 años 11 meses 29 días. En caso excepcionales con un intervalo mínimo de 4 semanas.

Las dosis administradas previamente si las hubiera, se consideran válidas siempre que estén correctamente registradas o identificadas, respeten la edad mínima de aplicación de la vacuna y los intervalos mínimos entre las dosis de la misma.

La administración de dosis de una vacuna a un intervalo menor del recomendado puede disminuir la respuesta inmunitaria, por lo tanto, se evalúa la pertinencia de acortar los intervalos considerando situaciones excepcionales.

Administrar primero las vacunas que inmunicen frente a la patología de mayor riesgo con relación a la edad del niño y a la epidemiología de su entorno y luego contra las otras enfermedades de los que no recibieron ninguna dosis o tengan dosis incompletas.

MINISTERIO DE SALUD
C. VILA

MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Inmunizaciones
Lic. Liliana Marleny Cirineos Reporte
V°B°
Dirección Ejecutiva
Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública

ANEXO 3
POLÍTICA DE FRASCOS ABIERTOS MULTIDOSIS PARA VACUNAS PRECALIFICADAS POR OMS

TIPO DE VACUNA	DURACIÓN FRASCO UNA VEZ ABIERTO
APO, DPT, dT pediátrica, dT adulto, influenza pediátrica (presentación líquida multidosis)	Hasta 28 días (con obligatoriedad de rotular el frasco con la fecha y hora de apertura).
BCG, SPR, SR, Antiamarílica (presentación liofilizadas multidosis)	Una vez reconstituida la vacuna, usar hasta 6 horas.
Se descartan las vacunas en los siguientes casos: a) Vacunas vencidas. b) vacunas almacenadas en formas inapropiadas de cadena de frío (ver normatividad de cadena de frío). c) El tapón del frasco ha sido sumergido en agua. d) NO se han utilizado técnicas asépticas para administrar todas las dosis.	
ALERTA: a) Prohibido dejar agujas introducidas en el tapón del frasco. b) NO precargar las jeringas con vacunas. c) Leer las instrucciones y recomendaciones del fabricante y los lineamientos nacionales.	

Nota: En caso de trabajo extramural, los frascos multidosis abiertos se descarta una vez terminada la jornada independientemente de las dosis usadas, por lo que se implementan las estrategias para evitar el exceso de factor pérdida de dosis de vacunas.

ANEXO 4
ASPECTOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE LA MICROPLANIFICACIÓN

El proceso de micro planificación es un ciclo de pasos que se implementa por etapas. El punto de partida es el análisis de la situación y la identificación de brechas en la cobertura, tasa de deserción, esquemas de vacunación incompletos, con base a esta información se definen las estrategias y tácticas de vacunación, se calculan los requerimientos y se procede con la ejecución de las acciones de vacunación.

Así mismo se incorpora el MRV para identificar los bolsones de población susceptible pendiente de vacunar, ejecutando intervenciones oportunas para la captación de esa población.

Finalmente, a través de la información disponible, la supervisión y evaluación, se determinada si se alcanzaron las metas de la CVS de alta calidad, de acuerdo a los criterios de eficacia, homogeneidad, oportunidad y eficiencia con sus respectivos indicadores, planteando acciones para mejorar el desempeño de la CVS y del programa e identificando las lecciones aprendidas y buenas prácticas.

Cada paso del proceso de microplanificación aplica procedimientos para generar productos que alimentan el siguiente paso. Al ser un proceso con entradas y salidas, cada paso debe responder a tres preguntas: ¿qué requerimos?, ¿qué debemos hacer? y ¿cuál es el producto?

La microplanificación es:

- Basada en la realidad local: Basado en el entendimiento de la dinámica poblacional de cada sector, así como en la identificación y estimación de su población objetivo, incluyendo su número y localización.
- Factible: Identificando la realidad local, se definen las estrategias más eficaces para la vacunación y se realiza el cálculo de los recursos y la logística más eficiente.
- Flexible: Permite implementar ajustes, reaccionar con prontitud y ofrecer una respuesta eficaz a los problemas que puedan presentarse, estableciendo medidas de contingencia.
- Eficiente: Optimiza la gestión de los recursos y posibilita que se realice adecuadamente la previsión, la implementación, el seguimiento y la evaluación del uso de recursos para vacunar.
- Lograr el empoderamiento: Permite que los equipos de salud desarrollen su creatividad a través de la elaboración de una guía de acción propia y los motiva para alcanzar sus metas.
- Ordenada: Fomenta la ejecución de actividades de forma ordenada y secuencial, con metas claras y medibles, dirigiendo las acciones hacia los resultados esperados.
- Establece controles: Hace posible verificar que la programación está produciendo los resultados esperados.

Etapas y pasos de la microplanificación:

Etapa I - Análisis de la situación:

- **Primer paso:** Recopilación y organización de datos.
- **Segundo paso:** Análisis de la información.
- **Tercer paso:** Mapeo y sectorización.

Etapa II - Programación:

- **Cuarto paso:** Definición de tácticas de vacunación.
- **Quinto paso:** Cálculo de necesidades.
- **Sexto paso:** Operacionalización.

Etapa III – Seguimiento:

- **Séptimo paso:** Monitoreo rápido de vacunación.
- **Octavo paso:** Análisis de bolsones de susceptibles.

Etapa IV – Supervisión y Evaluación:

- **Séptimo paso:** Supervisión.
- **Octavo paso:** Evaluación.

Matrices para la elaboración de la Microplanificación (solo para descarga)
Las matrices se encuentran disponibles en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/17BW6pUmRoHZz2hADJSp4almEj9BRtqWQ?usp=sharing

ANEXO 5
ASPECTOS TÉCNICOS A TENER EN CUENTA EN LA VACUNACIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y EN LA COMUNIDAD

1. En el Establecimiento de Salud:



a) Contar con un ambiente para la ejecución de las actividades de vacunación debidamente identificado "VACUNATORIO" (señalizado), tiene "Punto de Agua" (lavadero de manos) y condiciones de bioseguridad adecuadas. (limpio, ordenado, iluminado, y con buena ventilación).
b) Cuenta con termo porta vacunas, data logger, cajas de bioseguridad y termómetro operativo dentro del Vacunatorio.
c) Contar con algodón, jabón líquido o clorhexidina al 0.05%, papel toalla, kit ESAVI, materiales de escritorio u otros, en la cantidad suficiente, para las actividades diarias de vacunación.
d) El ambiente de cadena de frío debe estar ordenado, limpio, contar con el equipamiento completo y operativo según la Norma Técnica de Salud vigente.
e) El mobiliario del vacunatorio cuenta con: camilla, coche de curación equipado, vitrina metálica, escritorio, sillas, dispensadores de papel y jabón, contenedores de residuos sólidos (según NTS DIGESA, vigente).
f) El equipamiento mínimo para información, considera: una computadora, impresora y acceso a internet.
g) En el Vacunatorio se mantendrán disponibles y accesibles los siguientes documentos: NTS Esquema Nacional de Inmunizaciones, NTS de Cadena de Frío, NTS que establece la vacunación contra la COVID-19, MPOX, Dengue, Insertos de Vacunas, Manual de Vacunación Segura, Carné de vacunación del Niño – Niña, Carné de adultos y otros.

2. En Comunidad:





EN DOMICILIO

- Identificación de los niños o niñas u otra población objetivo a vacunar, identificado en el reporteador nominal emitido por MINSA u otras fuentes de información regional y local, su estado vacunal.
- Contar con el mapa sectorizado o georreferenciado según padrón nominal y población mayor de 5 años para acciones de seguimiento.
- Disponer del material necesario para una vacunación segura (jeringas, algodón, jabón líquido, alcohol gel, entre otros)
- Contar con un cronograma de visita domiciliaria considerando la fecha y hora adecuadas, para asegurar la presencia del padre, tutor o cuidador de la niña y niño (mayor de 18 años de edad) a fin de que la visita sea efectiva.
- El termo porta vacunas debidamente preparado, con data logger y/o termómetro operativo, ubicar un lugar adecuado

MINISTERIO DE SALUD Dirección de Inmunizaciones C. VILA

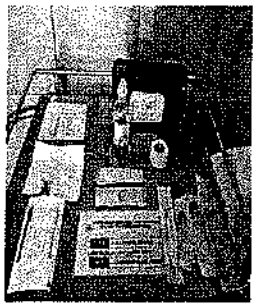
MINISTERIO DE SALUD Dirección de Inmunizaciones Lic. Liliana Marleny Chirinos Apaza V°B° Dirección Ejecutiva Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública

	(evitando rayos solares) para la preparación y administración de las vacunas, evitar poner en el piso. • Disponer de bolsas, cajas de bioseguridad, formatos de registro diario y carné de vacunación de niños y adulto
	**EN PUESTO FIJO** • Ubicarse en un lugar bajo sombra (carpa, sombrilla, ambiente, etc.). • Contar con un termo porta vacunas debidamente preparado, con data logger y/o termómetro operativo, bolsas, cajas de bioseguridad, formatos de registro diario de vacunación unificado y carné de vacunación de niños y adultos. • Contar con el material necesario para una vacunación segura (jeringas, algodón, jabón líquido, alcohol gel, entre otros). • Identificación y registro de la población a vacunar. • Material educativo comunicacional para la población.
	**POBLACIÓN CAUTIVA** • Coordinación local entre el Establecimiento de Salud y la institución a intervenir. • Desarrollar sesiones informativas para sensibilizar a las autoridades de la institución y público objetivo (en instituciones educativas incluir a los profesores y padres de familia). • Brindar material educativo al público objetivo. • Asegurar que la institución facilite un ambiente que permita la vacunación segura. • Elaborar un cronograma de vacunación. • Identificación y registro de la población a vacunar. • En instituciones educativas considerar el uso del consentimiento informado, firmado por los padres de familia o tutor. • Contar con un termo porta vacunas debidamente preparado, con data logger y/o termómetro operativo, bolsas, cajas de bioseguridad, formatos de registro diario de vacunación unificado y carné de vacunación de niños y adultos. • Contar con el material necesario para una vacunación segura (jeringas, algodón, jabón líquido, alcohol gel, entre otros).

MINISTERIO DE SALUD C. VILA

MINISTERIO DE SALUD Dirección de Inmunizaciones Lic. Liliana Marleny Chirinos Apaza V°B° Dirección Ejecutiva Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública

3. Uso del Kit de ESAVI



En todas las estrategias y tácticas de vacunación se cuenta con lo siguiente:

- Kit de Emergencia:
- Ampollas de Epinefrina o Adrenalina 1mg /1ml.
- Jeringas de 1ml con aguja de 25 x 5/8.
- Frascos ampollas de Hidrocortisona succinato Sódico 100 mg.
- Ampollas de Clorfenamina 10 mg/1ml.
- Frascos Agua Destilada.
- Jeringas de 5ml.
- El Profesional de salud está capacitado para manejar situaciones de emergencia (shock anafiláctico).

Protocolo de Manejo en caso de Shock anafiláctico: Coordinar para la capacitación con un médico especialista.

Cómo debemos aplicar:

Administre adrenalina o epinefrina (como solución 1:1000) 0.01 mg/kg) de peso por inyección intramuscular

Dosis por edad y peso

Edad y peso aproximados	Dosis de adrenalina/epinefrina
<1 año (< 7,5 kg)	0,10 ml
1 – 2 (10 kg)	0,10 ml
2 – 3 años (15 kg)	0,15 ml
4 – 6 años (20 kg)	0,20 ml
7 – 10 años (30 kg)	0,30 ml
10 – 12 años (40 kg)	0,40 ml
>12 años y adultos, incluidas mujeres embarazadas (más de 50kg)	0,50 ml

Fuente: Modificado de la Sociedad de Inmunología Clínica y alergia de Australasia 12. Disponible en: https://immunisationhandbook.health.gov.au/resources/tables/table-recognition-and-treatment-of-anaphylaxis

Administre hidrocortisona 10 mg / kg, vía IV, como dosis de carga, luego una dosis similar repartida cada seis horas hasta la recuperación del choque.

4. Acciones que realiza el profesional de enfermería:

4.1 Antes de vacunar: Consideraciones generales:

- Registro diario de temperatura de la cadena de frío (dos veces al día, al comienzo y al final de la jornada).
- Asegurar el orden y limpieza del ambiente de vacunas (Vacunatorio).
- Contar con el material e insumos necesarios (termos, jeringas, torundas de algodón, agua, jabón, registros, carné, entre otros).
- Adecuación de los paquetes fríos a las temperaturas recomendadas.
- Preparación del termo con paquetes fríos a las temperaturas recomendadas para la vacunación diaria (tanto intra como extramural) el cual contiene un termómetro de control de temperatura digital o de alcohol.

- Revisar las vacunas para el traslado a los termos (verificar fecha de vencimiento y lote).
- Conocer las dosis, vía de administración y jeringa a utilizar según esquema de vacunación.
- Leer el inserto de la vacuna (como referencia de los diferentes tipos de vacuna según la fabricación).

Preguntas básicas previas a la vacunación:

N°	PREGUNTAS	SÍ	NO
1	¿El niño o persona a vacunar tiene fiebre mayor a 38°C, o algún problema de salud? Antes de vacunar.		
2	¿Es alérgico a algún medicamento, alimento, vacuna o al látex?		
3	¿Alguna vez tuvo una reacción importante a alguna vacuna?		
4	¿Ha recibido alguna vacuna el mes anterior?		
5	¿Tiene alguna enfermedad crónica?		
6	¿Ha tenido convulsiones, algún problema cerebral o el síndrome de Guillan Barré?		
7	¿Tiene problemas de inmunidad: Leucemia, Cáncer, VIH, TBC, ¿Insuficiencia renal, trasplante o alguna otra enfermedad que afecte su inmunidad?, ¿recibe quimioterapia, o corticoide? o convive con personas inmunodeprimidas		
8	¿Ha recibido transfusiones de sangre o derivados en los últimos 3 meses?		
9	¿Está embarazada o existe la posibilidad (mes de gestación en que se encuentra) ¿Se encuentra en periodo de lactancia exclusiva?		

Brindar información completa sobre las vacunas a administrar:
- Esta información es clara y sencilla para la persona que la recibe, y se registra en la historia clínica.
- Incluye además la información sobre posibles efectos post-vacunales y riesgos de la no vacunación.

Información sobre las vacunas a los padres, tutores o cuidadores	Posibles efectos post-vacunales que pueden producirse y lo que debe hacer en caso de reacción
• Cuántos tipos de vacuna recibirá el niño o la niña durante la presente visita, contra qué enfermedades protegen las vacunas, posibles efectos post-vacunales y por qué es importante completar todas sus dosis. • Qué fecha deberá regresar para continuar su esquema (utilice el carné de vacunación).	Para cualquier consulta sobre los posibles efectos post-vacunales, llamar al número de teléfono del Establecimiento de Salud o a Infosalud **(LINEA 113)** a fin de orientar y garantizar la confianza de los padres de familia, tutores o cuidadores.
• En caso de personas adultas mayores reciben información adaptada de acuerdo a su edad y de	Si bien el consentimiento es verbal, el personal de enfermería deja

tener la oportunidad, explicar dudas y brindar aclaraciones.	constancia escrita en la Historia Clínica de la vacuna aplicada.

4.2 Durante la vacunación:

El profesional de enfermería cuenta con las vacunas según esquema nacional de vacunación.
Proceder al lavado de manos con agua y jabón antes y después de la vacunación. No es necesario el uso de guantes para administrar una vacuna.
Tener presente todas las precauciones y preguntas antes de administrar la vacuna.

Preparación de la vacuna.

- Identificar la vacuna o vacunas que corresponden, de acuerdo al esquema, estado vacunal y la edad del usuario.
- La preparación y administración se realiza en forma inmediata por cada tipo de vacuna, para evitar errores programáticos y/o alterar la cadena de frío del biológico. Tener presente en todo momento los procesos de inyección segura.

Limpieza en el lugar de inyección.

- Asepsia de la zona de administración con una torunda de algodón (1 gr) humedecido con jabón líquido o clorhexidina al 0.05%, realizando movimientos circulares de adentro hacia afuera.
- Se encuentra prohibido utilizar algodones previamente humedecidos y guardados en tambores u otros recipientes

Técnica de administración:

- Tener presente en todo momento los procesos de inyección segura: paciente, vacuna, diluyente, jeringas y agujas, dosis, vía y sitio e intervalos correctos, según esquema y edad del usuario.

4.3 Después de la administración de la vacuna:

1. Hacer presión suave con la torunda de algodón, evitar frotar o presión excesiva.
2. Reiterar al padre o acompañante la fecha de la próxima cita e informarle sobre los posibles efectos post-vacunales, acciones a seguir, de no ceder, acudir a su centro de salud más cercano.
3. Recomendar a los acompañantes que esperen en el establecimiento de salud durante 5 a 10 minutos, en observación ante una posible reacción severa.
4. Desechar la jeringa y aguja en cajas de bioseguridad (según Norma Técnica de Salud de Gestión de Residuos Sólidos en Establecimientos de Salud vigente, así como desechar los otros materiales que no se utilicen.
5. El paracetamol no debe recomendarse de forma rutinaria con el propósito de prevenir posibles reacciones. Puede usarse para tratar la fiebre (mayor o igual a 38°C si se presenta).

ANEXO 6
VÍAS Y TÉCNICAS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS VACUNAS

En el Esquema Nacional de Inmunizaciones se usan vacunas en presentación líquida y liofilizada que al reconstituirse pasan a ser líquidas, las cuales pueden ser administradas por vía oral o parenteral.

ADMINISTRACIÓN DE LAS VACUNAS

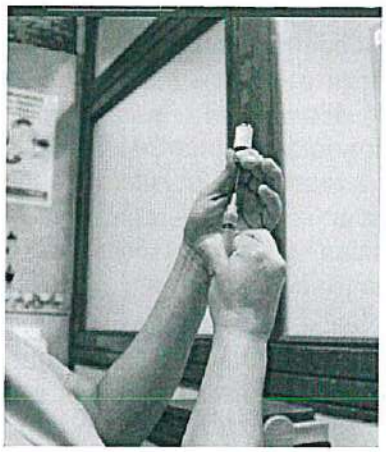
Las vías de administración utilizadas son: vía oral y parenteral.

TIPO DE VÍA	TÉCNICAS DE APLICACIÓN
Vía oral: La ruta de aplicación es por la boca, y se utiliza para la vacuna de polio oral - Sabin y Rotavirus 	Explíquele a la madre el tipo de vacuna a aplicar, número de dosis y el sitio de aplicación. **Vacuna de polio oral:** • Quitar el protector del gotero. • Dejar caer dos gotas en la boca del niño. • Evitar que el gotero toque la boca del Niño, a fin de evitar la contaminación. • Asegurarse que el niño no rechace, regurgite o vomite la vacuna, dentro de 5 minutos; de lo contrario REPITA la aplicación.
	**Vacuna Rotavirus:** • Coloque al niño en los brazos de su madre en posición de semisentado con la cabeza inclinada hacia atrás. • Aplique lentamente el contenido de la vacuna por vía oral en la parte interna de la mejilla del niño, para evitar que la rechace. • Si el niño escupe o regurgita o vomita la Vacuna, NO SE DEBE administrar otra dosis, explicar que la absorción es inmediata a través de la mucosa oral. En caso de no administrarse inmediatamente, la jeringa que contiene la vacuna reconstituida debe agitarse otra vez antes de la administración por vía oral.
Vía parenteral: **Intradérmica, subcutánea, e intramuscular**	Explique a la madre sobre el tipo de vacuna y el sitio de aplicación (brazo derecho o izquierdo). De preferencia en el brazo no dominante. **Preparar la vacuna BCG, combinando el diluyente con la solución liofilizada así**: • Proteja la ampolla del diluyente con un algodón, para quebrar el cuello de la ampolla.

MINISTERIO DE SALUD C. VILA

MINISTERIO DE SALUD Dirección de Inmunizaciones Lic. Liliana Marleny Chumpitaz Aguilar V°B° Dirección Ejecutiva Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública

Intradérmica (ID)



Se usa para la aplicación de la vacuna BCG. La inyección ID consiste en aplicación de la vacuna en la capa superior de la piel (dermis), ya que, por las características del tejido, por su poca distribución de vasos sanguíneos y capacidad de absorción lenta, la vacuna se absorbe poco a poco.





- El mismo procedimiento realice con la ampolla liofilizada.
- Registre la hora de apertura de la vacuna en el frasco de la vacuna.
- Utilizando la jeringa para preparar la vacuna, aspire el diluyente y mezcle con el liofilizado, evite rozar la aguja con el borde de la ampolla y elimine la jeringa utilizada, en la caja de bioseguridad.
- Utilizando una jeringa descartable de 1cc con aguja auto retráctil de calibre 27GX ½"; extraiga la dosis de 0.05 o 0.1cc del frasco según corresponda de acuerdo al inserto del laboratorio productor.

Aplique la vacuna en el tercio superior de la región deltoides del *brazo derecho*.

- Pedirle a la madre que coloque al niño en la camilla y que descubra el *brazo derecho* y que sujete el antebrazo del recién nacido.
- Limpiar el sitio de aplicación de la inyección, utilizando algodón con jabón líquido o clorhexidina al 0.05%, en forma circular del centro hacia fuera en 5 cm de diámetro.
- Sostener la piel con el dedo índice y pulgar con una mano, estirando bien la piel, dejando el dedo medio y anular bajo el brazo, para que fácilmente pueda introducirse la aguja en la dermis.
- Colocar la aguja, con un ángulo de 15° de manera que quede casi paralela a la superficie de la piel y con el bisel hacia arriba.
- Introducir la aguja presionando contra la piel cuidadosa y lentamente.
- Si el bisel de la aguja está en el tejido intradérmico cuando empieza a introducir el líquido se siente ligera resistencia.
- Avanzar unos 3 mm, inyectar suavemente, verificando que se forme una pequeña pápula de 5 mm de diámetro con el aspecto de piel de naranja.

MINISTERIO DE SALUD Dirección de Inmunizaciones C. VILA

MINISTERIO DE SALUD Dirección de Inmunizaciones Lic. Liliana Mallerly Chirinos Argote V°B° Dirección Ejecutiva Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública OPS

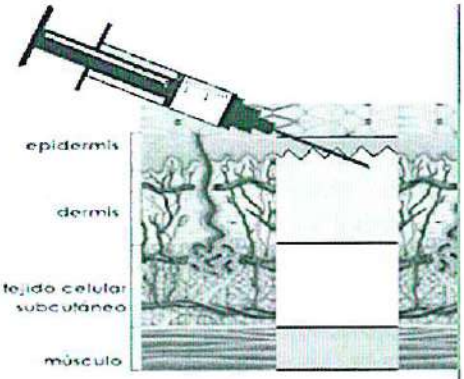


Figura 1.- Vía intradérmica

- Cuando no hay resistencia significa que la aplicación se está realizando muy al fondo del tejido intradérmico.
- Retirar la aguja sin realizar masaje en el lugar donde se aplicó la vacuna; explicándole a la madre que no presione, ni haga masaje en el sitio de la inyección.
- Observar cuidadosamente el sitio de aplicación y al paciente, para verificar alguna reacción alérgica.

Explicar a la madre las reacciones de la vacuna BCG, la formación de la pápula y el proceso de cicatrización que no requiere de ningún tratamiento especial e indique fecha de próxima visita.
Una vez finalizado el procedimiento, desechar la jeringa en la caja de bioseguridad.

Vía subcutánea (SC)

Es la administración de la vacuna por debajo de la piel, en el interior del tejido subcutáneo se aplica en la parte superior externa del brazo a nivel del músculo deltoides. Por esta vía se aplican las vacunas SRP, SR, Varicela y Fiebre Amarilla.

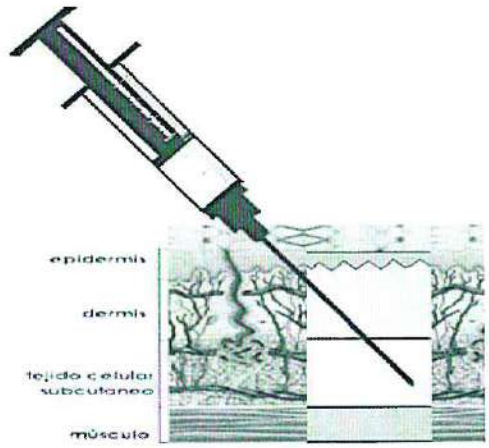


Figura 2.- Vía subcutánea o hipodérmica

Explicarle a la madre sobre el tipo de vacuna, la dosis y la técnica de aplicación.

Pedirle a la madre que se siente y abrace al niño, sosteniendo el brazo izquierdo.

Preparar la vacuna combinando el diluyente con el liofilizado utilizando una jeringa de 5cc con aguja 21G para luego administrar la vacuna con una jeringa de 1 cc con aguja 25 G x 5/8.

- Retire el sello de protección del frasco, sin retirar el anillo metálico, ni el tapón de goma.
- Romper la ampolla del diluyente por el cuello; llene la jeringa con el diluyente agitando la solución.
- Rotular la hora de apertura en el frasco de vacuna en caso de multidosis.
- Llene la jeringa con la solución, evitando rozar la aguja con el borde del frasco.
- Limpiar el sitio de aplicación de la inyección, utilizando, jabón líquido o clorhexidina al 0.05%, en forma circular del centro hacia fuera, en 5 cm. de diámetro.
- Levantar la piel del músculo deltoides para calcular el grosor del tejido celular subcutáneo en la zona elegida.

<table>
<tr>
<td>  </td>
<td>

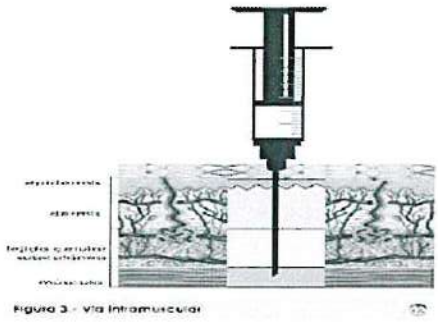
Introducir la aguja en un ángulo de 45°, en el tercio superior externo de la zona del músculo deltoides, de manera que la solución de la vacuna se sitúe exactamente en el tejido celular subcutáneo.
Después de introducir la aguja, aspirar, observar si no hay salida de sangre. Si observa combinación de la vacuna con sangre retire y repita el procedimiento desde el inicio.
Aplicar lentamente la vacuna.
Al terminar de introducir la vacuna retire la aguja siguiendo el ángulo de introducción; ya que esto evita daño al tejido.
No dé masaje y aconseje a la madre no dar masaje, ni colocar ninguna substancia en el sitio de aplicación, explíquele las reacciones que puede presentar el niño por causa de la vacuna.
Indique fecha de próxima cita.
Deseche la jeringa en la caja de bioseguridad.

</td>
</tr>
<tr>
<td>
Vía intramuscular (IM)

La vía Intramuscular se realiza en el tejido muscular, el cual tiene mayor circulación sanguínea que el tejido celular subcutáneo, por esta razón absorbe la vacuna más rápido y de manera segura.

En el tejido muscular se administran las vacunas: Pentavalente, Hexavalente, Neumococo, DPT, HvB, Influenza, HVA, VPH, Tdap, Dt y dT. Para aplicación de la vacuna se utilizan dos sitios de acuerdo a la edad:

Menores de 2 años: músculo Vasto externo del muslo.
De 2 años a más: músculo Deltoides del brazo.

</td>
<td>


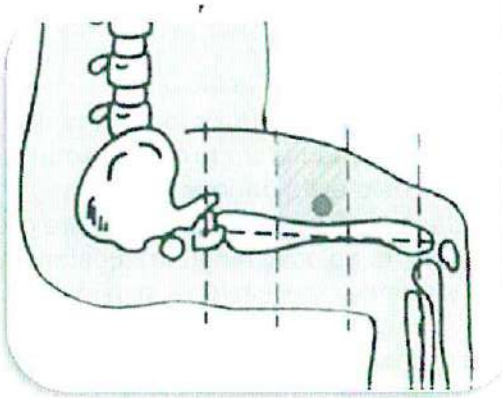
Explíquele a la madre sobre la técnica de aplicación y el tipo de vacuna a aplicar.

Coloque al niño sobre las piernas de la madre, en posición supina o lateral con la punta de los dedos del pie hacia adentro, con esta posición se observa bien el lado exterior de la pierna.

Para identificar el sitio de la inyección se coloca la mano en el trocánter y el cóndilo inferior del fémur, esta área se divide en tres partes y la parte del centro (tercio medio) es el sitio ideal para aplicar la inyección.
Se coloca una mano al lado de la rodilla y la otra al lado del trocánter, generalmente el espacio que queda libre puede ser seleccionado para la inyección.

</td>
</tr>
</table>

Músculo Vasto externo: en el tercio medio de la cara antero lateral del muslo. Esta vía de aplicación se utiliza en población menor de 2 años debido a que en este lugar no existen nervios, ni vasos sanguíneos importantes.





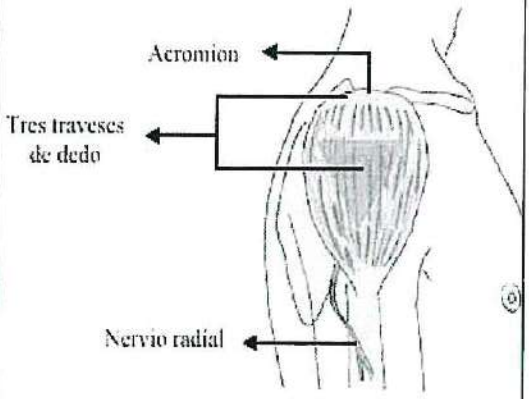
Prepare las vacunas así:

- Retire el sello de protección de los frascos de las vacunas; agite el frasco suavemente.
- Con la jeringa de 1 cc con aguja retráctil de 25g x 1, retire el líquido.
- Limpie el sitio de aplicación, tercio medio, cara antero lateral externa del muslo, con algodón con, jabón líquido o clorhexidina al 0.05% y sujete el muslo por la parte posterior para fijar.
- Introduzca la aguja de la jeringa con el bisel hacia arriba, en un ángulo de 90° profunda, evitando dirigirla hacia el hueso y verifique si hay retorno de sangre en la jeringa, si esto sucede retire la aguja unos milímetros y cambie la dirección de la aguja, inyecte lentamente.
- Retire la aguja sin realizar masaje en el lugar donde se aplicó la vacuna.
- Observar cuidadosamente el sitio de aplicación y al paciente para verificar alguna reacción alérgica.
- Explíquele las reacciones de la vacuna e indique fecha de próxima visita.
- Una vez finalizado el procedimiento, desechar la jeringa en la caja de bioseguridad.

MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Inmunizaciones
C. VILA

MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Inmunizaciones
Lic. Liliana Marleny Chirinos Apolinario
V°B°
Dirección Ejecutiva
Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública

Músculo Deltoides: esta vía de aplicación se utilizará en adultos y niños mayores de 2 años; la localización del punto de la inyección se identifica trazando un triángulo de base en el borde inferior del acromion y el vértice, debajo de la inserción del músculo deltoides, en el tercio superior del brazo.



Músculo deltoides



Explicar a las personas sobre la técnica de aplicación y el tipo de vacuna a administrar.

- La persona puede estar parada o sentada; el brazo se dobla para lograr la relajación del músculo deltoides y luego se mantiene el brazo en esa posición.
- Para ubicar el músculo deltoides se palpa el acromion con los dedos y con la otra mano se ubica la línea externa de la axila; la zona que queda libre es el deltoides.
- En el centro de este músculo, o sea el espacio entre ambas manos, es el sitio de aplicación de la inyección.
- Retire el sello de protección del frasco de la vacuna, sin retirar el anillo metálico, ni el tapón de goma.
- Llene la jeringa con la solución de la vacuna, evitando rozar la aguja con el borde del frasco.
- Limpie el sitio de aplicación, cuatro dedos abajo del hombro con un algodón con agua y jabón en forma circular del centro hacia afuera 5 cm de diámetro, dejarlo secar.
- Introduzca con rapidez la aguja de la jeringa de 1 cc con aguja 25 G X 1 con el bisel hacia arriba, en ángulo de 90º, hacerlo de un "solo golpe" es menos doloroso. Verifique antes de inyectar, aspirando si hay retorno de sangre en la jeringa, y si esto sucede, retire la aguja unos milímetros; cambie la dirección de la aguja e inyecte lentamente.
- Retirar la aguja sin realizar masaje en el lugar donde se aplicó la vacuna, no presionar ni hacer masaje.
- Observar cuidadosamente el sitio de aplicación y al paciente para verificar alguna reacción alérgica.
- Explíquele las reacciones de la vacuna e indique fecha de próxima cita.
- Una vez finalizado el procedimiento, desechar la jeringa en la caja de bioseguridad.

MINISTERIO DE SALUD C. VILA

MINISTERIO DE SALUD Dirección de Inmunizaciones Lic. Liliana Marleny Cisneros Aponte V°B° Dirección Ejecutiva Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública

ANEXO 7
TASA DE ESAVI LEVES ATRIBUIDOS A LA VACUNACIÓN O INMUNIZACIÓN

Vacuna	Reacción local (dolor, tumefacción, enrojecimiento)	Fiebre	Irritabilidad, malestar y síntomas no específicos
Haemophilus influenzae tipo b (Hib) [a]	5% a 30%	2% a 10%	Inusual
Hepatitis B [a]	hasta 30% en adultos hasta 5% en niñas y niños	1% a 6%	Poco frecuente
Antisarampionosa / SRP [a]	hasta 10%[b]	hasta 5%	hasta 5%
Antipoliomielítica oral (VPO) [a]	No compatible	menos de 1%	menos de 1 % [c]
TT / DT [a]	hasta 10% [d]	hasta 10%	hasta 25%
DTP [a,e]	hasta 50%	hasta 50%	hasta 60%
BCG [a,f]	Común	-	-
Influenza estacional	10% a 64% [h] 15% a 20% [i]	5% a 12% [i]	menos de 1%
Varicela	10% a 24% [j]	10% a 15%	-
Hepatitis A [k]	20% a 56%	menos de 10%	menos de 10%
Rabia [l]	21% a 77%	6% a 55%	5% a 40%
Influenza pandémica A(H1N1) [m]	5% a 64%	1% a 11%	1% a 26%
VPH	25% a 84%	10%	1% a 7%
Antineumocócica vacuna conjugada [n]	10% a 20%	15% a 24%	
Rotavirus	No compatible	40% a 43%	9% a 62%

Fuente: compilado por Turpo G, Ticona M, Whittembury A, diciembre 2009 - enero 2010 Whittembury A, et al. Eventos Supuestamente Atribuidos a Vacunación o Inmunización Rev. Perú. Epidemiologia. Vol. 13 No 3 diciembre 2009.

Modificado de los módulos de capacitación de vacunación segura de la OPS (2007).

a) Exantema leve en el 5% de los vacunados, que aparece 7 a 10 días después de la vacunación y dura 1 a 2 días. Artralgia y artritis transitorias en el 25% y 10%, respectivamente, de las mujeres post-púberes vacunadas; aparecen 1 a 3 semanas después de la vacunación y duran de 1 día a 3 semanas.
b) Diarrea, cefalea y dolores musculares.
c) Es probable que las tasas de reacciones locales aumenten con las dosis de refuerzo del 50 al 85%. Reacciones locales intensas pueden presentarse en el 1% a 2% de los vacunados, usualmente personas con múltiples dosis, 2 a 8 horas después de la vacunación.
d) Para la vacuna contra la tos ferina de células enteras. Las tasas para la vacuna contra la vacuna acelular son más bajas.
e) La reactogenicidad local varía de una vacuna a otra en función de la cepa y el número de bacilos viables.
f) El episodio consiste en la aparición de un nódulo, ulceración y cicatriz.
g) En adultos con vacuna inactivada.
h) En niñas y niños con vacuna inactivada. Vacuna atenuada: en niñas y niños también coriza (48%), cefalea (18%), vómitos (3%) sin diferencias estadísticas con placebo; en adultos congestión nasal (28% a 78%), cefalea (16% a 44%) y dolor de garganta (15% a 27%) con diferencia estadísticamente significativa con placebo.

i) Se puede presentar una erupción semejante a la varicela en el lugar de la inyección en el 3%-5% de las personas vacunadas con la primera dosis, y en el 1% con la segunda dosis. Se puede presentar una erupción generalizada en el 4% a 6% con la primera dosis y en el 1% con la segunda dosis.
j) Vacuna inactivada con células completas.
k) Vacuna de cultivo celular.
l) Vacuna inactivada. La información es preliminar ya que solo se cuenta con información de los estudios clínicos. Los estudios epidemiológicos en población vacunada aún están en desarrollo.
m) Los estudios realizados con la vacuna conjugada se han realizado junto con vacuna DPT.

MINISTERIO DE SALUD
C. VILA

MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Inmunizaciones
Lic. Liliana Marleny Chirinos Arancio
V°B°
Dirección Ejecutiva
Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública